



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai

PERSALINAN NORMAL DAN PENATALAKSANAANNYA

Dede Waslia • Zumrotul Ula • Umu Qonitun
Anisah Tifani Maulidyanti • Siti Rochimatul Lailiyah • Wira Meiriza
Pipih Salanti • Resta Betaliani Wirata

Editor: Nahdiyah Karimah



BUNGA RAMPAI: PERSALINAN NORMAL DAN PENATALAKSANAANNYA

Penulis:

Bdn. Dede Waslia, SST., MKM.
Zumrotul Ula, S.ST., M.Kes.
Umu Qonitun, S.ST., M.Keb., M.M.
Anisah Tifani Maulidyanti, M.Keb.
Bdn. Siti Rochimatul Lailiyah, S.SiT., M.Kes.
Wira Meiriza, S.ST., M.Keb.
Bdn. Pipih Salanti, SST., MKM.
Resta Betaliani Wirata, S.Kep., Ns., MSN.

Editor:

Nahdiyah Karimah, M.Tr.Keb.



Bunga Rampai: Persalinan Normal dan Penatalaksanaannya

Penulis: Bdn. Dede Waslia, SST., MKM.
Zumrotul Ula, S.ST., M.Kes.
Umu Qonitun, S.ST., M.Keb., M.M.
Anisah Tifani Maulidyanti, M.Keb.
Bdn. Siti Rochimatul Lailiyah, S.SiT., M.Kes.
Wira Meiriza, S.ST., M.Keb.
Bdn. Pipih Salanti, SST., MKM.
Resta Betaliani Wirata, S.Kep., Ns., MSN.

Editor: Bdn. Dede Waslia, SST., MKM

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7139-91-7
Cetakan Pertama: Maret, 2025
Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
website: www.nuansafajarcemerlang.com instagram:
@bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang Grand
Slipi Tower, Lantai 5 Unit F Jl. S.
Parman Kav 22-24, Palmerah
Jakarta Barat, 11480
Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif mengenai berbagai aspek persalinan normal dan penatalaksanaannya. Dalam dunia kebidanan, pemahaman yang mendalam tentang proses persalinan serta cara terbaik untuk mengelola setiap fase sangatlah penting untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan ibu serta bayi. Melalui buku ini, kami berharap dapat memberikan panduan yang bermanfaat bagi tenaga medis, terutama para bidan, dokter, dan perawat yang terlibat langsung dalam proses persalinan, agar dapat memberikan pelayanan yang optimal.

Kami memulai dengan pembahasan tentang manajemen nyeri persalinan dengan teknik non-farmakologis, yang kini semakin banyak diminati sebagai alternatif dalam mengurangi rasa sakit tanpa risiko efek samping obat. Berbagai metode seperti teknik pernapasan, relaksasi, dan penggunaan air hangat akan dibahas secara rinci sebagai pilihan yang dapat diberikan kepada ibu yang sedang melahirkan.

Selanjutnya, buku ini membahas tentang fase-fase persalinan normal dan pengelolaannya, yang sangat krusial untuk memahami tahapan yang harus dilalui oleh ibu dalam proses melahirkan. Setiap fase membutuhkan perhatian dan penanganan yang tepat agar proses persalinan berjalan lancar.

Dalam proses persalinan normal, ada kalanya komplikasi mungkin terjadi. Oleh karena itu, kami turut mengupas komplikasi yang mungkin terjadi selama persalinan normal dan bagaimana cara mengatasinya dengan pendekatan yang cepat dan tepat.

Pada bagian berikutnya, kami membahas pentingnya pemulihan pasca persalinan, terutama penanganan luka episiotomi dan perawatan vagina. Pemulihan ibu pasca melahirkan merupakan tahap yang tak kalah penting untuk mendukung kesehatan ibu dalam jangka panjang.

Kami juga mengangkat topik pendekatan holistik dalam persalinan normal, yang mencakup keseimbangan fisik, mental, dan spiritual ibu selama proses persalinan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman persalinan yang lebih nyaman dan bermakna bagi ibu, dengan melibatkan dukungan emosional serta pengelolaan stres.

Dalam perkembangan dunia medis, peran teknologi dalam memantau persalinan normal semakin besar. Buku ini membahas bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memastikan bahwa kondisi ibu dan bayi tetap terpantau dengan baik sepanjang proses persalinan, sehingga dapat mendeteksi masalah sejak dini.

Pemantauan kesehatan ibu dan janin selama persalinan juga dibahas dalam buku ini, dengan tujuan untuk memastikan kesejahteraan keduanya dengan cara yang terukur dan efisien. Selain itu, kami juga mengupas keputusan laparotomi dan indikasi operasi caesar, yang menjadi alternatif dalam beberapa kondisi tertentu yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat, memberikan pengetahuan yang lebih dalam, serta memperkaya wawasan bagi siapa saja yang terlibat dalam dunia kebidanan dan kesehatan ibu serta anak. Kami berharap buku ini dapat meningkatkan kualitas perawatan persalinan dan membantu ibu melahirkan dengan lebih aman, nyaman, dan penuh harapan. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Maret, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v

CHAPTER 1 MANAJEMEN NYERI PERSALINAN DENGAN TEKNIK NON FARMAKOLOGIS	1
Bdn. Dede Waslia, SST., MKM.	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Konsep Nyeri Persalinan	2
C. Teknik Non Farmakologis	14
D. Keimpulan.....	33
E. Referensi.....	33

CHAPTER 2 FASE – FASE PERSALINAN NORMAL DAN PENGELOLAANNYA	35
Zumrotul Ula, S.ST., M.Kes.	35
A. Pendahuluan/Prolog	35
B. Fase-fase persalinan Normal	36
C. Pengelolaan atau intervensi pada Fase Laten dalam persalinan Normal	41
D. Pengelolaan atau intervensi pada Fase Aktif dalam persalinan Normal.....	43
E. Pengelolaan atau intervensi pada Fase Ekspulsi dalam persalinan Normal	44
F. Referensi.....	46

CHAPTER 3 KOMPLIKASI YANG MUNGKIN TERJADI SELAMA PERSALINAN NORMAL	49
Umu Qonitun, S.ST., M.Keb., M.M.....	49
A. Pendahuluan/Prolog	49
B. Komplikasi Pada Persalinan Normal	49
C. Simpulan.....	55
D. Referensi.....	56
E. Glosarium.....	56

CHAPTER 4 PEMULIHAN PASCA PERSALINAN: PENANGANAN LUKA EPISIOTOMI DAN PERAWATAN VAGINA	57
Anisah Tifani Maulidyanti, S.Tr.Keb., M.Keb.....	57
A. Pendahuluan/Prolog	57
B. Perubahan-Perubahan Yang Terjadi Pasca Persalinan (Puerperium).....	59

C. Kebutuhan Dasar Ibu Pemulihan Pasca Persalinan.....	61
D. Peran Keluarga Pada Ibu Pasca Bersalin.....	65
E. Tanda Bahaya Pasca Persalinan.....	66
F. Penanganan Luka Episiotomi.....	67
G. Pencegahan Komplikasi pada Luka Episiotomi.....	69
H. Perawatan Vagina.....	72
I. Kesimpulan.....	74
J. Referensi.....	74

CHAPTER 5 PENDEKATAN HOLISTIK DALAM PERSALINAN NORMAL

KESEIMBANGAN FISIK, MENTAL, DAN SPIRITUAL 77

Anisah Tifani Maulidyanti, S.Tr.Keb., M.Keb.....	77
A. Pendahuluan/Prolog.....	77
B. Filosofi persalinan.....	78
C. Pendekatan holistic dalam persalinan.....	79
D. Keseimbangan fisik dalam pertolongan persalinan.....	81
E. Keseimbangan mental dalam pertolongan persalinan.....	82
F. Keseimbangan spiritual dalam pertolongan persalinan.....	84
G. Hambatan dalam pemberian pelayanan holistic.....	86
H. Strategi meningkatkan.....	88
I. Kesimpulan.....	88
J. Referensi.....	89
K. Glosarium.....	90

CHAPTER 6 PERAN TEKNOLOGI DALAM MEMANTAU PERSALINAN

NORMAL 93

Wira Meiriza, S.ST., M.Keb.....	93
A. Pendahuluan.....	93
B. Manfaat Teknologi Dalam Pelayanan Kesehatan.....	94
C. Tantangan Dalam Implementasi Pemanfaatan Teknologi Digital.....	94
D. Peran Teknologi Dalam Memantau Persalinan Normal.....	96
E. Simpulan.....	104
F. Referensi.....	104
G. Glosarium.....	105

CHAPTER 7 PEMANTAUAN KESEHATAN IBU DAN JANIN SELAMA

PERSALINAN..... 107

Bdn. Pipih Salanti, SST., MKM.....	107
A. Pendahuluan /Prolog.....	107
B. Pemantauan Kesehatan Ibu Selama Persalinan.....	107
C. Asuhan Kebidanan Pada Ibu selama Melahirkan.....	109
D. Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Ibu Selama Persalinan.....	110

E. Partograf.....	110
F. Pemantauan Janin Selama Persalinan.....	113
G. Penilaian Bayi Waktu Lahir	114
H. Faktor Risiko yang Memerlukan Pemantauan Janin Lebih Intensif.....	115
I. Cara Mengatasi Rasa Tidak Nyaman Selama Pemantauan Janin.....	115
J. Pembahasan	116
K. Referensi.....	116

CHAPTER 8 KEPUTUSAN LAPAROTOMI DAN INDIKASI OPERASI

CAESAR117

Resta Betaliani Wirata, S.Kep., Ns., MSN.....	117
A. Pendahuluan/Prolog	117
B. Indikasi Laparotomi	118
C. Proses Pengambilan Keputusan	120
D. Indikasi Operasi Caesar	123
E. Keuntungan dan Risiko Operasi Caesar	124
F. Komplikasi Operasi Caesar	125
G. Simpulan	126
H. Referensi.....	126

PROFIL PENULIS.....129

CHAPTER 1

MANAJEMEN NYERI PERSALINAN DENGAN TEKNIK NON FARMAKOLOGIS

Bdn. Dede Waslia, SST., MKM.

A. Pendahuluan/Prolog

Persalinan adalah proses keluarnya hasil konsepsi yang sudah dapat hidup dari dalam rahim ke dunia luar melalui jalan lahir, dengan bantuan tenaga medis (Prawirohardjo, 2020). Proses ini mempengaruhi kondisi ibu, terutama jika persalinan berlangsung lama. Kondisi tersebut dapat meningkatkan tingkat emosional ibu, seperti kecemasan dan ketakutan, yang pada akhirnya menambah kelelahan dan memperkuat persepsi terhadap nyeri.

Pengalaman melahirkan setiap wanita sangat bervariasi. Menjelang persalinan, ibu hamil akan merasakan nyeri akibat kontraksi rahim yang semakin kuat. Kontraksi ini bertujuan untuk membuka jalan lahir dan membantu pengeluaran janin. Nyeri biasanya dirasakan di area perut, punggung, atau sekitar paha dan panggul. Nyeri persalinan merupakan proses fisiologis yang alami, namun intensitasnya berbeda pada setiap individu.

Menurut Suddarth & Brunner (dalam Smeltzer, 2002), nyeri adalah pengalaman sensorik atau emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan aktual atau potensial. Persepsi nyeri ini berbeda pada setiap ibu bersalin. Jika nyeri tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat memicu masalah lain, seperti meningkatnya kecemasan, terutama pada ibu yang kurang memiliki pengetahuan atau pengalaman mengenai persalinan. Oleh karena itu, nyeri selama persalinan perlu ditangani melalui manajemen nyeri (Bobak, Lowdermilk & Jensen, 2005).

Nyeri persalinan merupakan pengalaman subjektif tentang sensasi fisik yang terkait dengan kontraksi uterus, dilatasi dan penipisan serviks, serta penurunan janin selama persalinan. Respon fisiologis terhadap nyeri meliputi peningkatan tekanan darah, denyut nadi, pernapasan, keringat, diameter pupil, dan ketegangan otot (Arifin, 2021).

Nyeri persalinan ditandai dengan adanya kontraksi rahim, kontraksisebenarnya telah terjadi pada minggu ke-30 kehamilan yang disebut kontraksi Braxton Hicks akibat perubahan-perubahan dari hormone estrogen dan progesterone tetapi sifatnya tidak teratur, tidak nyeri dan kekuatan kontraksinya sebesar 5mmHg, dan kekuatan kontraksi Braxton Hicks ini akan menjadi kekuatan

his dalam persalinan dan sifatnya teratur. Kadang kala tampak keluarnya cairanketuban yang biasanya pecah menjelang pembukaan lengkap, tetapi dapat jugakeluar sebelum proses persalinan. Dengan pecahnya ketuban diharapkan persalinan dapat berlangsung dalam waktu 24 jam (Gadysa, 2009).

Saat ini, banyak metode yang dapat digunakan untuk mengatasi nyeri persalinan. Manajemen nyeri tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan farmakologis maupun nonfarmakologis. Sebagian ibu mampu menghadapi nyeri persalinan secara normal tanpa menggunakan obat, sementara sebagian lainnya memerlukan bantuan obat penghilang rasa sakit atau anestesi dari tenaga medis.

Metode nonfarmakologis dalam mengurangi nyeri memiliki berbagai keunggulan, seperti minimnya efek samping bagi ibu dan bayi. Selain itu, metode ini juga dapat memberikan pengalaman menyenangkan selama proses persalinan. Karena memiliki efek samping yang rendah dan biaya yang lebih terjangkau, metode nonfarmakologis menjadi pilihan yang semakin populer. Beragam teknik nonfarmakologis kini tersedia untuk membantu mengurangi rasa nyeri selama persalinan.

B. Konsep Nyeri Persalinan

1. Definisi

Nyeri persalinan adalah kontraksi miometrium merupakan proses fisiologis dengan intensitas yang berbeda pada masing-masing individu (Orshan, 2008). Rasa nyeri yang dialami selama persalinan bersifat unik pada setiap ibu dapat dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain budaya, takut, kecemasan, pengalaman persalinan sebelumnya, persiapan persalinan dan dukungan (Potter, 2009; (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)). Rasa nyeri pada persalinan adalah manifestasi dari adanya kontraksi (pemendekan) otot rahim. Kontraksi inilah yang menimbulkan rasa sakit pada pinggang, daerah perut dan menjalar ke arah paha. Kontraksi ini menyebabkan adanya pembukaan mulut rahim (serviks). Dengan adanya pembukaan servik ini maka akan terjadi persalinan

2. Faktor Predisposisi

Persalinan menghadirkan tantangan fisiologis dan psikologis untuk perempuan. Ketika persalinan menjadi semakin dekat, ini bisa menjadi saat yang bertentangan dengan emosi; ketakutan dan kecemasan bisa ditambah dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Nyeri yang berhubungan dengan persalinan telah terjadi digambarkan sebagai salah satu bentuk rasa sakit yang paling intens alami meskipun beberapa wanita tidak mengalami nyeri hebat selama persalinan (Melzack, 1984; (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).

Beberapa faktor yang dianggap memberikan kontribusi langsung pada

timbulnya nyeri persalinan yang hebat di antaranya:

a. Fisiologi

Wanita dengan riwayat dismenore dapat mengalami nyeri pada saat melahirkan akan meningkat sebagai akibat dari tingkat prostaglandin yang lebih tinggi. Faktor fisik lain yang memengaruhi intensitas nyeri termasuk interval dan durasi kontraksi, ukuran janin dan posisi, kecepatan penurunan janin, dan posisi ibu. Proses persalinan membutuhkan energi yang besar, jika ibu mengalami kelelahan selama persalinan, maka rasa nyeri yang dirasakan akan semakin tinggi. Jika ibu mengalami penurunan kondisi fisik seperti malnutrisi dan kelelahan maka dapat menyebabkan peningkatan intensitas nyeri persalinan.

b. Psikologi

1) Takut dan Cemas

Perasaan cemas dan takut selama persalinan memicu sistem saraf simpatik dan parasimpatik, sehingga lebih meningkatkan intensitas nyeri yang dirasakan. Cemas mengakibatkan perubahan fisiologis yaitu spasme otot, vasokonstriksi dan menyebabkan pengeluaran substansi penyebab nyeri (kortekolamin), sehingga cemas dapat meningkatkan intensitas nyeri yang dirasakan. Ketegangan dalam otot polos dan pembuluh darah seperti kekakuan leher rahim dan hipoksia rahim disebabkan oleh perasaan takut menghadapi persalinan.

2) Arti Nyeri

Bagi Individu Setiap orang memiliki penilaian yang berbeda terhadap nyeri persalinan yang dirasakan. Dengan intensitas nyeri yang sama, belum tentu ditanggapi yang sama oleh tiap individu. Nyeri persalinan bersifat individual dan subjektif.

3) Kemampuan Kontrol Diri

Suatu kepercayaan bahwa seseorang mempunyai sistem kontrol terhadap suatu permasalahan sehingga dapat mengendalikan diri dan dapat mengambil tindakan guna menghadapi masalah yang muncul, hal inilah yang disebut kemampuan kontrol. Agar tidak terjadi respon psikologis yang berlebihan seperti ketakutan dan kecemasan yang dapat mengganggu proses persalinan, ibu bersalin memerlukan kemampuan untuk mengontrol dirinya.

4) Percaya Diri

Setiap ibu melahirkan harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Percaya diri disini diartikan sebagai keyakinan pada ibu bahwa ia mampu menghadapi permasalahan dengan tindakan atau perilaku yang akan

dilakukan. Ibu bersalin yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi maka dia akan mampu mengontrol persalinan, sehingga nyeri yang dirasakan tidak akan berlebihan.

c. Kognitif

Kognitif atau pengetahuan terbukti memengaruhi persepsi ibu tentang nyeri selama persalinan, pada ibu bersalin dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang rendah dalam memahami proses persalinan adalah hal fisiologis maka kemungkinan akan lebih intens merasakan nyeri persalinan. Namun selain kognitif ternyata kecemasanpun menjadialah satu faktor penentu terhadap timbulnya nyeri persalinan. Jika seorang perempuan memiliki tingkat kecemasan yang tinggi maka otak akan lebih cenderung mempersepsikan nyeri persalinan sebagai ancaman sehingga nyeri tersebut akan lebih sering muncul. Wanita dengan tingkat self-assessment yang lebih rendah akan mengalami self-efficacy rasa sakit lebih intens dan mengancam (Whitburn LY, Jones LE, Davey M-A, Small R, 2014; (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).

Keyakinan seorang ibu bahwa dia bisa mengatasi nyeri persalinan akan sangat memberikan pengaruh terhadap otak dalam mempersepsikan nyeri. keyakinan efikasi diri yang lebih kuat berkorelasi dengan penurunan rasa sakit dan kesusahan tenaga saat mengejan. (Berentson-Shaw J, Scott KM, Jose PE, 2009; (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).

d. Sosial Lingkungan

Sosial seorang ibu, termasuk keberadaan orang-orang tertentu, tindakan dan perkataan, serta dukungan selama proses persalinan sangat memainkan peran penting pada timbulnya nyeri persalinan. Seorang pendamping persalinan (bidan) yang memberikan dukungan dan membimbing ibu melalui persalinannya akan mampu merubah pemahaman ibu tentang tujuan rasa sakit menjadi positif dan nyeri yang produktif (Wang E, 2017; (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).

Beberapa ibu secara eksplisit menyatakan efek lingkungan sosial tentang rasa sakit yang dirasakan saat bersalin, misalnya: —jika bidan berhati lembut dan hangat maka ibu akan merasakan lebih sedikit rasa sakitll. (Beigi NMA, Broumandfar K, Bahadoran P, Abedi HA, 2010; (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).

Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa keterlibatan penolong/pendamping persalinan yang dapat membina hubungan baik (seperti berbicara dengan teknik tertentu) pada ibu bersalin, hal tersebut dapat membuat ibu keluar dari 'rasa sakit yang parah dan/atau keadaan tertekan, nyeri tingkat rendah dan/atau kesusahan dalam melalui proses

persalinannya.

e. Lingkungan

Pengalaman seorang wanita tentang nyeri persalinan tidak dapat sepenuhnya dipahami tanpa pertimbangan perspektif budaya dan filosofis dari letak geografis tempat bersalin, serta karakteristik fisiknya. Hasil beberapa penelitian memaparkan bahwa nyeri persalinan juga sangat ditentukan dari lingkungan tempat bersalin. Nyeri yang tidak tertahankan akan memicu ibu bersalin untuk memilih sesar sebagai satu-satunya jalan terakhir yang akan dipilih meskipun hal tersebut tidak diinginkannya. (Chuahorm U, Sripichyakarn K, Tungpunkom P, Klunklin A, Kennedy P, 2007 ; (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).

f. Budaya

Pemahaman tentang keyakinan, nilai-nilai, harapan, dan praktek berbagai budaya akan mempersempit kesenjangan budaya dan membantu bidan menilai pengalaman nyeri wanita yang melahirkan. bidan dapat memberikan asuhan peka budaya yang sesuai dengan langkah-langkah dalam mengontrol kepercayaan diri dalam menghadapi nyeri pada saat melahirkan. Misalnya, budaya sekitar menanggapi bahwa melahirkan perlu adanya pendampingan suami untuk memberikan tenaga kepada istrinya pada saat melahirkan Faktor lain yang menjadi pemicu nyeri persalinan yaitu: (Simkin, 2008 ; (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)):

- 1) Kebutuhan Oksigen ke Kandungan/Uterus akan mengalami penurunan (terjadinya nyeri persalinan jika kontraksi bertambah kuat dan frekuensinya lebih cepat, sehingga kebutuhan oksigen ke uterus berkurang).
- 2) Uterus akan terjadi peregangan (penipisan dan pembukaan); effacement dan pelebaran).
- 3) Dorongan bagian terendah janin akan memberikan tekanan Uterus dan Vagina.
- 4) Terjadinya kontraksi uterus akan mengakibatkan pembukaan pada Rahim bagian bawah sehingga janin akan mengalami penurunan.
- 5) Dorongan presentasi terendah janin akan memberikan kekuatan tekanan pada kandung kemih dan anus.
- 6) Bagian dasar panggul dan vagina akan terjadi peregangan
- 7) Hormone stress akan keluar dalam jumlah besar (epinefrin, norepinefrin, dll), bila seorang wanita dalam proses persalinan mengalami ketakutan dan kecemasan yang berlebihan akan mengakibatkan terjadinya nyeri persalinan dengan intensitas yang lama dan lebih berat.

3. Klasifikasi nyeri persalinan

a. Nyeri Viseral

Pada awal proses persalinan, nyeri timbul dari organorgan internal di dalam rongga perut dan panggul. Hal ini dapat menyebar ke daerah lain dan diteruskan di sepanjang jaringan saraf. Nyeri ini bersifat lambat dan tidak terlokalisir. Rasa nyeri yang dialami ibu karena perubahan serviks dan iskemia uterus pada persalinan kala I. Kala I fase Laten lebih banyak mengalami penipisan di serviks sedangkan pembukaan serviks dan penurunan bagian terendah janin terjadi pada fase aktif dan transisi. Ibu akan merasakan nyeri yang berasal dari bagian bawah abdomen dan menyebar ke daerah lumbar punggung dan menurun ke paha. Ibu biasanya mengalami nyeri hanya selama kontraksi dan bebas dari rasa nyeri pada interval antar kontraksi. (Alghatis, Faheem and Sijeeni, 2020; (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).

b. Nyeri somatik dialami ibu pada akhir kala I dan kala II persalinan.

Nyeri ini disebabkan oleh peregangan perineum dan vulva, tekanan uteri servikal saat kontraksi, penekanan bagian terendah janin secara progresif pada fleksus lumboskral, kandung kemih, usus dan struktur sensitif panggul yang lain. Nyeri somatik pada persalinan terjadi dari "jaringan ikat, otot, tulang, dan kulit" dan sering digambarkan sebagai nyeri hebat yang memiliki asal yang jelas dan mudah diidentifikasi. Nyeri somatik adalah hasil dari peregangan ligamen, tulang rawan, dan rileksasi tulang. (Alghatis, Faheem and Sijeeni, 2020; (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).

4. Tingkat Nyeri Persalinan

Setiap proses persalinan berakibat rasa nyeri. Rasa nyeri dari seseorang dalam proses persalinan sangat bervariasi, tergantung dari bagaimana individu dan bagaimana ia menggambarkan rasa nyeri tersebut.

a. Nyeri merupakan pengalaman subyektif: Nyeri dalam proses persalinan merupakan pengalaman subyektif yang timbul dari akibat perubahan fungsi organ tubuh yang terlihat dalam menentukan kemajuan proses persalinan melalui jalan lahir (Maryunani, 2010; (Rejeki, Nurullita, & Krestanti, 2013; (Purnomo Wahyudi, 2019)).

b. Intensitas rasa nyeri yang dipersepsikan: Tingkat nyeri persalinan digambarkan dengan intensitas nyeri yang dipersepsikan oleh ibu saat proses persalinan. Intensitas nyeri tergantung dari sensasi keparahan dari nyeri itu sendiri (Kozier, 2011; (Purnomo Wahyudi, 2019)).

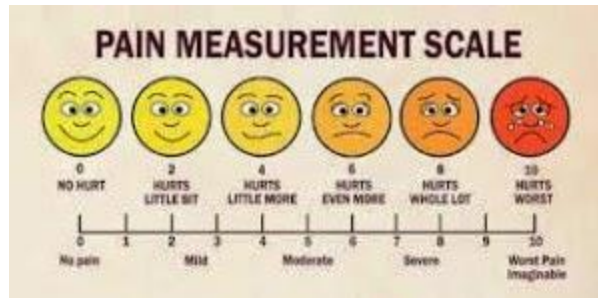
c. Intensitas nyeri yang diukur dengan skala nyeri yang dirasakan oleh seseorang: Intensitas rasa nyeri persalinan dapat ditentukan dengan cara menanyakan kepada pasien tentang tingkatan intensitas atau merujuk pada

skala nyeri. Hal ini dilakukan ketika ibu tidak dapat menggambarkan rasa nyeri. Contohnya, skala 0-10 (skala numeric), skala deskriptif yang menggambarkan intensitas tidak nyeri sampai nyeri yang tidak tertahankan, skala dengan gambar kartun profil wajah dan sebagainya.

- d. Intensitas nyeri rata-rata ibu bersalin kala I fase aktif digambarkan dengan skala VAS sebesar 6,7 sejajar dengan intensitas berat pada skala deskriptif.

5. Pengkajian Persepsi Nyeri

- a. Pengkajian nyeri berdasarkan PQRST



Gambar 1.1 Cara pengkajian nyeri berdasarkan PQRST

Cara pengkajian nyeri berdasarkan PQRST ini digunakan untuk mengkaji keluhan nyeri pada pasien yang meliputi :

- 1) *Provokes/palliates* : Pengkajian provokatif/paliatif dapat dikaji dengan menanyakan apa yang menyebabkan nyeri? Apa yang membuat nyerinya lebih baik? apa yang menyebabkan nyerinya lebih buruk? apa yang anda lakukan saat nyeri? apakah rasa nyeri itu membuat anda terbangun saat tidur?.
- 2) *Quality* : Mengkaji Kualitas/ quantitas rasa nyeri dapat dilakukan dengan mengkaji Seberapa berat keluhan nyeri yang dirasakan pasien? bisakah anda menggambarkan rasa nyerinya? apakah seperti diiris, tajam, ditekan, ditusuk tusuk, rasa terbakar, kram, kolik, diremas? (biarkan pasien mengatakan dengan kata-katanya sendiri.
- 3) *Region and Radiates*: *Region* atau radiasi merupakan lokasi dimana keluhan nyeri tersebut dirasakan atau ditemukan. Radiasi dilihat dengan menanyakan apakah nyeri juga dirasakan menyebar ke daerah lain, atau menyebar ke daerah yang lebih luas apakah nyerinya menyebar? Menyebar kemana? Apakah nyeri terlokalisasi di satu titik atau bergerak?.
- 4) *Scale / Severity* : Skala/*Severity* diartikan sebagai skala kegawatan yang dapat dilihat menggunakan CPOT untuk gangguan kesadaran atau skala nyeri ukuran lain yang berkaitan dengan keluhan pasien seberapa parah nyerinya? Dari rentang skala 0-10 dengan 0 tidak ada nyeri dan 10 adalah nyeri hebat.

5) *Time : Timing* merupakan catatan waktu dimana kita akan menanyakan kapan keluhan nyeri tersebut mulai ditemukan / dirasakan, seberapa sering keluhan nyeri tersebut dirasakan / terjadi. Ditanyakan juga apakah terjadi secara mendadak atau bertahap kapan nyeri itu timbul? apakah onsetnya cepat atau lambat? berapa lama nyeri itu timbul? apakah terus menerus atau hilang timbul? apakah pernah merasakan nyeri ini sebelumnya? apakah nyerinya sama dengan nyeri sebelumnya atau berbeda?

b. Skala *Wong-Baker FACES Pain Rating Scale*

Wong-Baker FACES Pain Rating Scale adalah cara mengkaji tingkat nyeri dengan melihat ekspresi wajah saat nyeri dirasakan. Skala nyeri yang satu ini tergolong mudah untuk dilakukan karena hanya dengan melihat ekspresi wajah pasien pada saat bertatap muka tanpa kita menanyakan keluhannya (Loretz, 2005; (Muttaqin, 2024). Penilaian skala nyeri ini dianjurkan untuk usia 3 tahun ke atas.



Gambar 1.2 Skala Wong-Baker FACES Pain Rating Scale

Berikut skala nyeri yang kita nilai berdasarkan ekspresi wajah: skala nyeri Skala nyeri berdasarkan ekspresi wajah Penilaian Skala nyeri dari kiri ke kanan

- 1) Wajah Pertama : Sangat senang karena ia tidak merasa sakit sama sekali.
- 2) Wajah Kedua : Sakit hanya sedikit.
- 3) Wajah ketiga : Sedikit lebih sakit.
- 4) Wajah Keempat : Jauh lebih sakit.
- 5) Wajah Kelima : Jauh lebih sakit banget.
- 6) Wajah Keenam : Sangat sakit luar biasa sampai-sampai menangis

c. *Comparative Pain Scale* (Skala Nyeri 0-10)

Rasa nyeri seseorang berbeda-beda antar satu dengan lainnya. Nyeri yang dirasakan seseorang memiliki tingkatan, yaitu nyeri ringan, nyeri sedang, atau nyeri berat. Lebih lanjut kita istilahkan sebagai Skala Nyeri (Loretz, 2005; (Muttaqin, 2024). Praktisi kesehatan harus dapat mengetahui tingkat nyeri atau seberapa besar nyeri dirasakan oleh pasien.

Skala nyeri ini akan membantu praktisi kesehatan dalam menentukan seberapa besar nyeri dirasakan oleh pasien, membedakan tingkat beratnya suatu penyakit sehingga dapat membantu menegakkan diagnosis yang

akurat, membantu merencanakan intervensi keperawatan atau pengobatan yang tepat, dan mengevaluasi pengobatan yang telah diberikan.

Penilaian tingkat nyeri dengan menggunakan Skala Nyeri 0-10 (*Comparative Pain Scale*) (Loretz, 2005; (Muttaqin, 2024).

- 1) 0 = Tidak ada rasa sakit. Merasa normal.
- 2) 1 nyeri hampir tak terasa (sangat ringan) = Sangat ringan, seperti gigitan nyamuk. Sebagian besar waktu Anda tidak pernah berpikir tentang rasa sakit. 2 (tidak menyenangkan) = nyeri ringan, seperti cubitan ringan pada kulit.
- 3) 3 (bisa ditoleransi) = nyeri Sangat terasa, seperti pukulan ke hidung menyebabkan hidung berdarah, atau suntikan oleh dokter.
- 4) 4 (menyedihkan) = Kuat, nyeri yang dalam, seperti sakit gigi atau rasa sakit dari sengatan lebah.
- 5) 5 (sangat menyedihkan) = Kuat, dalam, nyeri yang menusuk, seperti pergelangan kaki terkilir
- 6) 6 (intens) = Kuat, dalam, nyeri yang menusuk begitu kuat sehingga tampaknya sebagian mempengaruhi sebagian indra Anda menyebabkan tidak fokus, komunikasi terganggu.
- 7) 7 (sangat intens) = Sama seperti 6 kecuali bahwa rasa sakit benar-benar mendominasi indra pasien. Hal ini menyebabkan pasien tidak dapat berkomunikasi dengan baik dan tak mampu melakukan perawatan diri.
- 8) 8 (benar-benar mengerikan) = Nyeri begitu kuat sehingga Anda tidak lagi dapat berpikir jernih, dan sering mengalami perubahan kepribadian yang parah jika sakit datang dan berlangsung lama.
- 9) 9 (menyiksa tak tertahankan) = Nyeri begitu kuat sehingga Anda tidak bisa mentolerirnya dan sampai-sampai menuntut untuk segera menghilangkan rasa sakit apapun caranya, tidak peduli apa efek samping atau risikonya.
- 10) (sakit tak terbayangkan tak dapat diungkapkan) = Nyeri begitu kuat tak sadarkan diri. Kebanyakan pasien tidak pernah mengalami skala rasa sakit ini. Karena biasanya pasien sudah keburu pingsan. Sebagai contoh pada pasien yang mengalami kecelakaan parah, tangan hancur, dan kesadaran akan hilang sebagai akibat dari rasa sakit yang luar biasa parah.

Untuk kemudahan penilaian dapat dilakukan dengan pengelompokkan, yaitu:

- 1) Skala nyeri 1-3 berarti Nyeri Ringan (masih bisa ditahan, aktifitas tak terganggu)
- 2) Skala nyeri 4-6 berarti Nyeri Sedang (mengganggu aktifitas fisik)

3) Skala nyeri 7-10 berarti Nyeri Berat. Biasanya pasien tidak dapat melakukan aktifitas secara mandiri.

d. *Verbal Rating Scale (VRS)*

Verbal Rating Scale (VRS) merupakan cara pemeriksaan intensitas nyeri dengan menggunakan angka pada setiap kata yang sesuai. Umumnya penilaian diberikan dengan angka pada setiap kata sifat sesuai dengan intensitas nyeri yang dirasakan oleh pasien. VRS juga merupakan alat ukur yang menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tingkat rasa nyeri pada setiap intensitas yang berbeda. Cara penilaian yaitu dari range dari "*none/no pain*" hingga "*extrem pain/nyeri hebat/very severe*" (Loretz, 2005; (Muttaqin, 2024).

Penilaian	Score
1) <i>None</i> (tidak adanya nyeri)	0
2) <i>Mild</i> (kurang nyeri)	1
3) <i>Moderate</i> (rasa nyeri yang sedang)	2
4) <i>Severe</i> (Nyeri yang berat/hebat)	3
5) <i>Very severe</i> (nyeri yang tidak tertahankan/sangat hebat)	4

Gambar 1.3 *Verbal Rating Scale (VRS)*

Kelemahan/keterbatasan dari VRS yaitu adanya ketidakmampuan pasien untuk menghubungkan kata sifat yang tepat untuk menilai rasa nyerinya. Selain itu juga apabila pasien buta huruf/mengenal angka yang dapat digunakan untuk mewakili rasa nyeri.

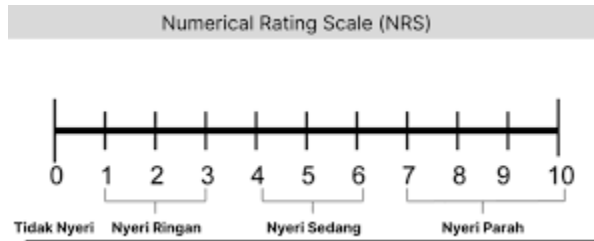
e. *Visual Analogue Scale (VAS)*

Visual Analogue Scale (VAS) merupakan alat pengukuran rasa nyeri yaitu untuk mengukur intensitas/tingkat nyeri yang dirasakan pasien. VAS dilakukan dengan cara khusus yaitu membuat 10-15 cm garis, dimana setiap ujungnya ditandai dengan level intensitas nyeri. Ujung sebelah kiri diberi tanda tidak ada nyeri/ "*no pain*" dan ujung kanan diberi tanda nyeri hebat/ "*bad pain*". Pasien diminta untuk menandai garis tersebut sesuai dengan level nyeri yang dirasakan. Selanjutnya jarak penandaan diukur dari batas kiri hingga pada tanda yang dibuat oleh pasien (ukuran mm), dan ini merupakan score yang menunjukkan level nyeri yang dirasakan oleh pasien (Loretz, 2005; (Muttaqin, 2024).

f. *Numerical Rating Scale (NRS)*

Numerical Rating Scale (NRS) adalah alat ukur tingkat nyeri dimana cara penilaian dengan meminta pasien untuk menilai rasa nyeri yang dirasakan sesuai dengan level/tingkatan rasa nyerinya. Pada metode ini intensitas nyeri akan ditanyakan kepada pasien, kemudian pasien diminta untuk menunjuk

angka sesuai dengan derajat/tingkat nyeri yang dirasakan. Derajat nyeri diukur dengan skala 0-10 (Loretz, 2005). Tingkat nyeri diukur atas dasar: tidak nyeri (*none*: 0), sedikit nyeri (*mild*: 1-3), nyeri sedang (*moderate*: 4-6) dan nyeri hebat (*severe*: 7-10).

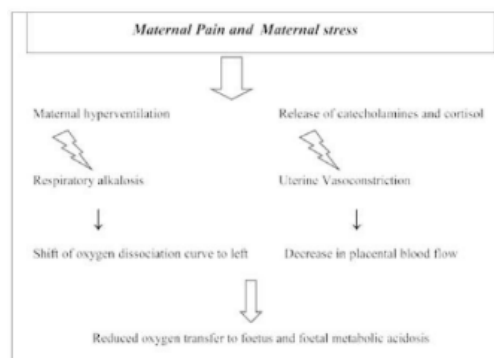


Gambar 1.4 Numerical Rating Scale (NRS)

6. Mekanisme nyeri persalinan

Rasa nyeri dan ketidaknyamanan pada saat persalinan meliputi nyeri viseral dan somatik. Pada kala I persalinan, kontraksi uterus menyebabkan pembukaan dan penipisan serviks. Iskemia uterus (penurunan aliran darah dan mengakibatkan kekurangan oksigen lokal) merupakan hasil dari adanya kompresi/penekanan arteri yang mensuplai miometrium selama kontraksi rahim. Rasa nyeri dari distensi segmen bawah rahim, peregangan jaringan serviks karena penipisan dan melebarkan, tekanan dan traksi pada struktur yang berdekatan (misalnya:uterus, ovarium, ligamen) dan saraf, dan iskemia uterus selama kala I persalinan bersifat viseral.

Nyeri ini terletak di bagian bawah perut. Rasa nyeri berasal dari uterus yang menyebar ke dinding perut, daerah lumbosakral bagian belakang, puncak iliaka, daerah gluteal, paha, dan punggung bawah. Sebagian besar pada kala I persalinan, ibu biasanya merasa ketidaknyamanan ketika ada kontraksi dan tidak nyeri di antara kontraksi. Beberapa ibu, terutama yang janinnya berada dalam posisi posterior, mengalami nyeri pinggang pada saat kontraksi secara terus menerus, bahkan dalam interval antara kontraksi. Ketika nyeri menjadi lebih intens dan terus-menerus, ibu menjadi lelah dan putus asa, sering mengalami kesulitan menghadapi kontraksi.



Gambar 1.5 Mekanisme nyeri dan stress pada ibu secara umum

Tabel 1.1 Nyeri persalinan; Sumber, mekanisme, tempat kerja

Sumber Nyeri	Mekanisme	Tempat kerja
Uterus, serviks	Distorsi, peregangan, dan robekan pada serabut otot	Abdomen atas, dan sela paha tengah belakang
Jaringan periuterus daerah lumbosacral	Tekanan yang sering dihubungkan dengan malposisi janin atau panggul platypelloid	Punggung bawah, paha
Kandung kemih, uretra, rectum	Tekanan oleh bagian terbawah	Tekanan oleh bagian terbawah
Vagina	Distensi, robekan	Tidak menyebar
Perineum	Distensi, robekan	Tidak menyebar
Kandung kemih	Overdistensi	Suprapubik

7. Efek nyeri persalinan

a. Efek Nyeri terhadap Kemajuan Persalinan

Nyeri saat persalinan dapat memengaruhi proses persalinan. Rasa sakit atau nyeri saat persalinan akan meningkat karena adanya aktivitas sistem saraf simpatik yang menyebabkan konsentrasi plasma menjadi lebih tinggi dari katekolamin, terutama epinefrin. (Labor and Maguire, 2008) Persalinan akan memberikan tekanan pada sistem kardiovaskuler dan sistem pernapasan. Konsentrasi plasma katekolamin yang meningkat selama nyeri persalinan dapat meningkatkan curah jantung ibu, resistensi pembuluh darah perifer dan penurunan perfusi uteroplasenta. Bahkan stres atau kecemasan dalam persalinan dikaitkan dengan peningkatan drastis dari konsentrasi plasma norepinefrin dan kemudian menyebabkan penurunan aliran darah ke uterus. Konsentrasi epinefrin plasma pada wanita yang mengalami persalinan dengan tingkat yang tinggi telah diteliti dan hasilnya sama dengan yang wanita yang telah diberikan epinefrin 15 mg per bolus. Dan hal ini secara signifikan dapat menurunkan aliran darah ke uterus. (Pan and Eisenach, 2008)(Hamdiah Ahmar, dkk, 2021).

Lain berefek pada sistem kardiovaskuler, nyeri pada saat kontraksi yang intermiten dapat menstimulasi sistem pernapasan dan memengaruhi periode dari hiperventilasi yang intermiten. Dengan tidak adanya tambahan oksigen yang masuk, kompensasi pada sistem pernapasan menjadi tidak baik dan akhirnya dapat menyebabkan hipoksia pada ibu maupun janin. Seperti yang

diteliti oleh Brownridge, terdapat 12 efek fisiologis dari nyeri persalinan seperti peningkatan konsumsi oksigen dan hiperventilasi, hypocarbia dan alkalosis pernapasan, stimulasi otonom dan pelepasan katekolamin, penghambatan kerja lambung dan meningkatkan keasaman lambung, lipolisis, peningkatan resistensi pembuluh darah perifer, jantung output, dan tekanan darah, penurunan perfusi plasenta, dan aktivitas uterus tidak koordinatif.

Kondisi-kondisi ini akan menyebabkan asidemia pada metabolisme ibu, asidosis janin dan disfungsional persalinan. Untuk itu, pemberian asuhan yang tepat untuk mengurangi nyeri sangat diperlukan untuk meminimalisir peningkatan konsumsi oksigen. Secara umum, perubahan pada sistem kardiovaskuler maupun sistem pernapasan yang terjadi akibat adanya nyeri masih dapat di toleransi pada ibu bersalin normal begitu juga bayinya.

b. Efek Nyeri terhadap Psikologis Ibu

1) Pola pikir

Pola pikir ibu yang positif terhadap persalinan sangat memengaruhi proses persalinannya. Ibu bersalin yang memiliki pemahaman yang baik tentang proses persalinan dan mempunyai pola pikir yang positif, dapat mengontrol rasa sakit yang dirasakan. Hal ini tentunya mempunyai dampak baik terhadap kemajuan persalinan. Nyeri yang dirasakan ibu bersalin dipengaruhi oleh psikologis ibu dan lingkungan sekitar ibu bersalin.

2) Kecemasan

Nyeri dalam persalinan berkontribusi dengan kecemasan dapat berdampak pada terjadinya komplikasi pada persalinan. Jolic, dkk melakukan penelitian tentang sensitivitas kecemasan dan kecemasan sebagai korelasi dari yang diharapkan, mengalami dan nyeri persalinan yang diingat

c. Efek Nyeri terhadap Janin

Secara teori, tidak ada koneksi saraf secara langsung dari ibu ke janin, maka dari itu nyeri persalinan yang dialami oleh ibu tidak langsung memiliki efek pada janin. Namun, nyeri persalinan yang dialami ibu dapat memengaruhi sistem-sistem yang menentukan perfusi uteroplasenta yaitu:

- 1) Frekuensi kontraksi uterus dan intensitasnya, efek nyeri pada pelepasan oksitosin dan epinefrin.
- 2) Vasokonstriksi arteri rahim, efek nyeri pada pelepasan norepinefrin dan epinefrin.

- 3) *Maternal oxyhemoglobin desaturation*, yang mungkin timbul dari intermiten hiperventilasi diikuti oleh hipoventilasi. (Pan and Eisenach, 2008(Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).

C. Teknik Non Farmakologis

1. Metode pernafasan

a. Definisi

Pernapasan adalah peristiwa memasukkan dan mengeluarkan udara dari dan kedalam paru-paru. Pernapasan erat kaitannya dengan oksigen dan karbon dioksida. Pada saat bernapas maka kita akan menghirup oksigen untuk keperluan metabolisme tubuh dan menghasilkan karbon dioksida sebagai salah satu hasil dari metabolisme. Manajemen nyeri persalinan telah dilakukan dengan berbagai metode baik farmakologis maupun nonfarmakologis. Salah satu terapi nonfarmakologis yang paling umum di gunakan adalah Teknik bernapas efektif.

b. Teknik

Dalam melakukan pernapasan, terlebih dahulu harus diketahui dasar-dasar dari pernapasan di antaranya:

1) Membersihkan Napas (*Cleansing Breathe*)

Desahan dalam yang mengembangkan paru-paru secara penuh saat menghirup udara dan melepaskannya saat mengembuskan napas. Pernapasan ini dilakukan saat kontraksi dimulai dan saat kontraksi selesai.

2) Pernapasan perut

Tarik napas dengan lembut dan perlahan dengan mulut tertutup, rasakan dinding perut naik setinggi mungkin, keluarkan napas dari mulut dan dinding perut turun perlahan. Dada tetap dalam keadaan diam. Posisi tangan dapat diletakkan pada bagian perut dan coba rasakan dinding perut mengembang saat menarik napas dan rileks saat mengembuskan napas.

3) Pernapasan Dada

Letakkan tangan pada sisi tulang rusuk, perut dalam keadaan diam dan rasakan dinding dada bergerak saat menarik napas dan mengeluarkan napas.

4) Bernapas Pendek dan Cepat

Buka mulut dan ambil napas pendek dan cepat, Gerakan ini dilakukan pada masa transisi ketika terjadi kontraksi atau saat di perlukan. Yang perlu di perhatikan adalah apabila di temukan gejala hiperventilasi yaitu pusing dan tangan kesemutan apa bila terlalu lama mempraktikkan teknik

ini.

5) Bernapas Pendek dan Cepat

Buka mulut dan ambil napas pendek dan cepat, Gerakan ini dilakukan pada masa transisi ketika terjadi kontraksi atau saat di perlukan. Yang perlu di perhatikan adalah apabila di temukan gejala hiperventilasi yaitu pusing dan tangan kesemutan apa bila terlalu lama mempraktikkan teknik ini.

6) Menahan Napas

Teknik pernapas ini dapat digunakan selama kala 2 persalinan, selama kontraksi. Pernapasan akan memberikan tekanan kebawah pada diafragma dan rongga perut saat menahan napas dapat membantu mendorong bayi keluar. Saat Latihan teknik ini, jangan lakukan dorongan (mendedan) sebelum masuk kala 2 persalinan. Teknik relaksasi yang digunakan dalam pernapasan terkontrol akan memberi kendali yang lebih baik selama persalinan. Kemampuan membuat tubuh lebih rileks akan membantu menghemat energi selama kala 1 persalinan. Relaksasi secara sadar di antara kontraksi membuat istirahat lebih tenang dan membuat energi tersimpan untuk persiapan memasuki persalinan kala 2. Untuk membuat tubuh lebih rileks gunakan pakaian longgar, kosongkan kandung kemih, nyalakan music yang menenangkan, temukan posisi yang nyaman. (Smith et al. 2018)(Hamdiah Ahmar, dkk, 2021).

2. Teknik ***Counter-Pressure*** dalam Mengurangi Tingkat Nyeri Persalinan

a. Definisi

Counter Pressure adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengurangi nyeri persalinan (Pasongli, Rantung, & Pesak, 2015).Counter Pressure terdiri dari dorongan kuat tetap yang diberikan pada titik di punggung bawah selama kontraksi, dengan menggunakan kepalan tangan, pangkal telapak tangan, atau benda yang kuat atau tekanan yang dilakukan pada kedua paha bagian samping dengan menggunakan tangan yang dilakukan oleh penolong persalinan atau pemberi pelayanan kesehatan (Lowdermilk et al., 2016)

b. Posisi *Counter Pressure*

Beberapa posisi yang dapat dilakukan ketika memberikan Counter Pressure antara lain ibu dapat berdiri atau membungkuk dan bersandar ke depan (Pasongli et al., 2015).Ibu juga dapat duduk di bangku, bersandar di tempat tidur atau tumpukan bantal atau melakukan posisi sidelying. Ibu dianjurkan untuk posisi tangan menyentuh lutut.



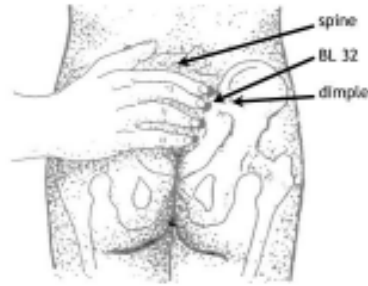
Gambar 1.6 Counter-pressure dengan posisi pasien berdiri dan meletakkan kepala di bantal

c. Metode *Counter Pressure*

Counter Pressure diberikan pada daerah yang nyeri atau tidak nyaman ketika kontraksi dimulai. Counter Pressure biasanya dilakukan pada atau di atas sakrum. Ibu biasanya meminta untuk berpindah lebih ke atas atau bawah, tetapi biasanya banyak yang meminta untuk lebih menekan dengan kuat (Hamlin & Robertson, 2017; (Pasongli et al., 2015 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).

Penolong persalinan dapat memberikan secara tetap dengan tekanan yang sangat kuat menggunakan pangkal salah satu telapak tangan atau kepala tangan, pada salah satu titik pada sakrum (Pearce, 2016 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).

Ibu memberi tahu penolong persalinan titik yang tepat dan besarnya tekanan yang dia inginkan (biasanya titik terletak di dekat pusat di atas salah satu persendian sakroiliaka). Tekanan yang diberikan tergantung dari tingkat kenyamanan ibu, dimana dapat dikira-kira sesuai kemajuan persalinan. Jenis tekanan yang meringankan nyeri di awal persalinan mungkin akan mengganggu pada waktu berikutnya. Penolong persalinan dapat menentukannya dengan bertanya pada ibu mengenai respon yang diterimanya, atau hanya memahami bagaimana ibu merasa, dengan melihat seberapa banyak ibu tegang atau rileks melalui tekanan yang diberikan. Ibu akan mengekspresikannya dengan bahasa tubuhnya ketika dia tidak dapat mengungkapkan keinginannya, karena itu mengetahui perubahan dan reaksi ibu adalah penting (Carole, 2005(Hamdiah Ahmar, dkk, 2021))



Gambar 1.7 Posisi penekanan pada regio sakralis



Gambar 1.8 Counter pressure regiosakralis dalam mengurangi tingkat nyeri salin

3. Teknik Hypnobirthing

a. Definisi

Hypnobirthing adalah salah satu teknik autohipnosis (self-hipnosis) merupakan upaya untuk menanamkan maksud/sugesti positif ke dalam alam bawah sadar selama seseorang menjalani masa kehamilan serta persiapan dalam menghadapi persalinan. Sehingga setiap ibu hamil dapat merasakan kebahagiaan selama masa kehamilan serta proses persalinan dapat berlangsung dengan lancar. (Kuswandi 2014; Mongan 2016 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).

Penerapan hypnosis dalam mempersiapkan persalinan didasarkan asumsi bahwa prosedur tersebut dapat menurunkan kecemasan, membuat toleransi nyeri menjadi lebih baik, mengurangi komplikasi persalinan, dan meningkatkan proses pemulihan pasca salin. Hypnosis mampu membuat klien mengontrol ketidaknyamanan serta kecemasan fisik yang dirasakan. (Azizmohammadi 2019; Steel et al. 2016 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).

Hypnobirthing lebih merupakan sebuah filosofi dari metode persalinan fisiologis dengan keyakinan bahwa —setiap wanita memiliki kekuatan di dalam dirinya sehingga dapat menghadirkan naluri keibuan alaminya untuk dapat menjalani proses persalinan penuh dengan kebahagiaan dan kenyamanan dengan cara yang paling alamill Hal ini didasarkan pada teori bahwa persalinan merupakan proses yang fisiologis dan sehat (Aprillia 2013; Atis & Rathfisch 2018b; Mongan 2016; Varner 2015 (Hamdiah Ahmar, dkk,

2021).

Dapat disimpulkan definisi hypnobirthing adalah salah satu teknik *self-hypnosis* yang digunakan selama masa kehamilan dan persalinan, dengan cara relaksasi yang dalam sehingga ibu memiliki kemampuan dalam memprogram ulang (sugesti) pikiran menjadi positif bahwa hamil dan melahirkan merupakan proses alamiah yang penuh dengan kebahagiaan, fisiologis serta sehat.

b. Manfaat

1) Manfaat untuk Ibu

Wanita yang menggunakan hypnosis selama periode antenatal dan inrapartum berdasarkan hasil penelitian memiliki manfaat sebagai berikut:

- a) Mengurangi rasa takut, nyeri dan kecemasan selama persalinan, serta tidak ada perbedaan tingkat nyeri persalinannya dengan penggunaan epidural. (Azizmohammadi 2019; Sariati 2016; Steel et al. 2016 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).
- b) Wanita yang menerapkan self-hypnosis juga merasakan lebih tenang, percaya diri dan merasa berdaya diri selama proses persalinan. (Finlayson et al. 2015 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).
- c) Teknik *hypnobirthing* berperan penting juga dalam mempercepat kemajuan persalinan fase laten pada primigravida. (Mudihayati et al. 2018 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).
- d) Mengurangi komplikasi persalinan dan mempercepat proses pemulihan pasca salin. (Azizmohammadi 2019 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).
- e) Teknik pernapasan dalam hypnobirthing dapat menghemat energi selama kala I persalinan, selain itu pernapasan lambat juga dapat membantu melembutkan dan membuka serviks, yang dapat mempersingkat durasi atau lamanya persalinan. (Jones & Handford 2016; Mongan 2016; Sariati 2016 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).
- f) Hypnobirthing tidak mengandung risiko pada ibu atau janin, menjadi alasan pendekatan yang menyenangkan dengan potensi hasil yang lebih baik. (Farnham 2020 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).
- g) Meningkatkan kadar hormon endorphen yang dapat menurunkan sensasi nyeri pada saat his persalinan. Kekuatan yang dimiliki hormon endorphen 200 kali lipat lebih besar dari morphin sehingga dapat menekan sensasi nyeri saat persalinan. (Jones & Handford 2016; Kuswandi 2014; Mongan 2016 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).
- h) Ketika stres maka tubuh merespon dengan menghasilkan kortisol dan kortisol memberikan feed back negative sehingga dapat menekan

hormone endorfin. Hypnobirthing membantu mengurangi stress emosional sehingga dapat menekan pelepasan kortisol selama persalinan tanpa konsekuensi jangka panjang. (Miller 2019; Werner et al. 2020 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).

- i) Mengurangi intervensi pembedahan dan persalinan instrumental. (Atis & Rathfisch 2018b; Jones 2015 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).

2) Manfaat untuk Janin

- a) Hypnobirthing membantu menjaga sirkulasi oksigen kepada bayi selama dalam proses persalinan. (Kuswandi 2014; Mongan 2016 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).
- b) Tindakan resusitasi neonatus menjadi lebih rendah. (Atis & Rathfisch 2018 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).
- c) Energi ibu yang penuh dengan ketenangan akan dapat dirasakan oleh janin sebagai pondasi dalam perkembangan jiwa janin (Spiritual Question). (Hypnobirthing 2019; Mongan 2016 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).
- d) Pertumbuhan dan perkembangan janin menjadi lebih sehat karena ibu hamil yang tenang akan mengurangi pengeluaran hormon kortisol sebaliknya tubuh ibu akan menstimulasi pengeluaran hormon yang seimbang ke janin melalui plasenta. (Hermina & Wirajaya 2015; Hypnobirthing 2019; Werner et al. 2020 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).
- e) Mengurangi potensi terjadinya komplikasi pada kehamilan dan persalinan dengan mencegah kejadian kelahiran premature dan BBLR. (Atis & Rathfisch 2018b; Azizmohammadi 2019 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).

3) Manfaat untuk pendamping

- a) Selama melakukan pendampingan proses persalinan menjadi lebih tenang.
- b) Dampak dalam kehidupan sehari-hari, emosi suami cenderung menjadi lebih stabil.
- c) Membantu memperbaiki dan memperkuat bonding attachment antara istri, suami serta janin yang dikandung.
- d) Energi positif dan ketenangan pada suami/pendamping persalinan dapat memancarkan energi positif kepada ibu bersalin serta orang-orang yang berada disekitarnya.

4) Manfaat untuk penolong

- a) Lebih tenang dan fokus dalam menghadapi ibu bersalin dengan emosi yang labil.

- b) Lebih tenang dalam memberikan pertolongan dalam proses persalinan.
 - c) Emosi akan menjadi lebih stabil di dalam kehidupan sehari-hari.
 - d) Energi positif dan ketenangan yang dirasakan oleh penolong persalinan akan sangat memengaruhi energi ibu bersalin dan orang-orang yang berada disekitarnya.
 - e) Menjadi keunggulan dari pelayanan asuhan yang diberikan di klinik/RS/RB.
 - f) Dapat digunakan sebagai anasthesi dalam melakukan tindakan invasif ringan/sedang kepada klien dengan tetap memberikan rasa nyaman klien.
- c. Prinsip *hypnobirthing*

Metode *hypnobirthing* sebagai persiapan dalam menghadapi kehamilan dan persalinan secara holistik (menyeluruh) yang meliputi *body, mind, and spirit*, sehingga pada saat proses persalinan, ibu serta pendamping persalinan (suami) mampu melalui rangkaian proses persalinan yang aman, nyaman, rileks serta minim trauma, sehingga dapat menjadi pengalaman positif bagi ibu dan suami. (Kuswandi 2014 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).

Self-hypnosis digunakan untuk melepaskan rasa takut yang dapat meyakinkan pikiran bahwa persalinan itu menyakitkan, agar calon ibu dalam melalui proses persalinannya dapat berpikiran secara positif dengan keyakinan bahwa proses melahirkan merupakan proses yang menyenangkan dan tidak harus menyakitkan. (Mongan 2016 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).

Untuk calon ibu dan pasangan. pelajari teknik relaksasi agar dapat memberikan sambutan yang tenang, lembut, dan aman kepada bayi, dapatkan persalinan yang terjaga serta waspada dalam keadaan pikiran dan tubuh yang benar-benar rileks serta minim trauma.

4. Metode *Warm & Cold Water Therapy*

a. Definisi

Aplikasi panas dan dingin adalah tren yang berkembang untuk metode penghilang rasa sakit nonfarmakologi karena potensial terjadi risiko untuk ibu dan janin rendah. Intervensi ini juga mempromosikan dukungan emosional kepada ibu. Terapi nonfarmakologis ini akan membantu memutus siklus ketakutan-nyeri-ketegangan, yang dapat mengurangi sensasi fisik dan respons emosional terhadap nyeri, serta kebutuhan dan permintaan obat-obatan (Sugandary, Dash, & Chitra, 2018 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).

Terapi compres air hanga dan air dingin merupakan salah satu metode yang efektif untuk menghilangkan rasa Aplikasi panas dan dingin adalah tren yang berkembang untuk metode penghilang rasa sakit nonfarmakologi karena

potensial terjadi risiko untuk ibu dan janin rendah. Intervensi ini juga mempromosikan dukungan emosional kepada ibu. Terapi nonfarmakologis ini akan membantu memutus siklus ketakutan-nyeri-ketegangan, yang dapat mengurangi sensasi fisik dan respons emosional terhadap nyeri, serta kebutuhan dan permintaan obat-obatan (Sugandary, Dash, & Chitra, 2018 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)). Terapi compres air hangat dan air dingin merupakan salah satu metode yang efektif untuk menghilangkan rasa.

b. Mekanisme

Proses pengalihan nyeri persalinan dimulai saat saraf mengirimkan sinyal nyeri melalui sumsum tulang belakang ke otak. Nyeri rangsangan melintasi gerbang tulang belakang terbuka ke reseptor dan masuk otak, di mana respon nyeri yang sesuai diarahkan. Gangguan dengan transmisi vektor ini dapat menghasilkan pereda nyeri yang efektif (Warren, 2010 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).

Terapi air dingin dapat menyebabkan penurunan rasa sakit melalui berbagai mekanisme termasuk induksi rasa kebal secara timbal balik, menghambat persepsi rasa sakit dengan stimulasi reseptor saraf tepi, memfasilitasi aliran energi di titik-titik akupunktur, penurunan ketegangan otot, perubahan kecepatan transmisi saraf, perlambatan transmisi sinyal nyeri ke pusat sistem saraf, dan juga gangguan dari rasa sakit (Ernst E, 1994; Simkin P, 2004 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).

Mengenai efek dingin pada penurunan kecemasan, (Tootoonchi M, Aein F, Hasanpour M, 1999 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)) tampaknya dingin dapat menurunkan kadar katekolamin dan karenanya meningkatkan kadar endorfin dan akibatnya mengurangi keparahan nyeri. Secara keseluruhan, tampak bahwa berdasarkan teori, air dingin dapat secara efektif memblokir transmisi saraf pada serat sensorik dan meningkatkan ambang nyeri. (AB, 1992; AD, 2001; Curkovic B, Vitulic V, Babić-Naglić D, 1993; Melzack R, 1965; Waters L, 2003 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).

Selain mekanisme yang disebutkan oleh terapi air dingin, air panas dapat merangsang reseptor panas di kulit dan jaringan yang lebih dalam dan impuls yang berbeda menetralkan diri pada tingkat sumsum tulang belakang dan menyebabkan penutupan saluran dan kemudian menghambat impuls saraf untuk mencapai otak. Sirkulasi darah yang ditingkatkan panas juga mengurangi kram otot yang disebabkan oleh stres. Fokus kehangatan pada jaringan tertentu lebih jauh meningkatkan metabolisme dan elastisitas jaringan yang akan meningkatkan efektivitas ambang nyeri (Benfield et al., 2001, 2010 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).

Sinyal yang dihasilkan oleh stimulasi air hangat dari termoreseptor epidermis mencapai otak lebih cepat daripada yang dikirim oleh reseptor nyeri, secara efektif memblokir transmisi yang terakhir dan mengurangi rasa sakit yang dirasakan ibu (Huang, 2010; Lane & Latham, 2009 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).

c. Tata laksana

Penerapan terapi panas sederhana, murah, tersedia selama persalinan, tidak memerlukan keterampilan sebelumnya, dan memiliki beberapa efek samping jika diterapkan dengan benar (Jones L, Othman M, Dowswell T, Alfirevic Z, Gates S, Newburn M, 2012 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).

Efek panas untuk mengurangi rasa sakit dijelaskan oleh teori gerbang nyeri. Teori ini menunjukkan bahwa ada mekanisme gerbang di sumsum tulang belakang yang menghambat penyilangan sinyal rasa sakit dengan menutup sistem gerbang di sumsum tulang belakang (Ropero Pelaez FJ, 2016 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).

Salah satu penelitian dengan teknik panas dan dingin yang dilakukan oleh Sugandry et al terhadap 60 wanita inpartu dengan menggunakan Wong Baker FACES Pain Rating Scale untuk menilai rasa sakit. Kantong air panas karet digunakan untuk aplikasi panas. Ukuran kantong air panas-20 x15 cm. $\frac{3}{4}$ tas diisi dengan air panas dan ditutup dengan sumbat. Suhu air panas dipertahankan antara 38 hingga 40 C yang diukur dengan termometer laboratorium. Kantong air panas diperiksa untuk setiap kebocoran air. Tas ditutupi dengan handuk dan ditempatkan di atas perut, perut bagian bawah dan punggung. Kantong plastik dingindigunakan untuk aplikasi dingin. Ukuran kantong dingin berukuran 18 x 12 cm. Air keran biasa dituangkan ke dalam kantong dan disimpan di lemari es. Suhu cold pack dipertahankan antara 15 hingga 18 C yang diukur dengan termometer laboratorium. Bungkus dingin ditutupi dengan handuk dan ditempatkan di atas perut, perut bagian bawah dan punggung. Peneliti memberikan panas dan dingin secara bergantian pada ibu intranatal. Aplikasi panas 30 menit diterapkan pada perut (10 menit), perut bagian bawah (10 menit) dan punggung (10 menit). Aplikasi dingin 10 menit diberikan pada perut (3 menit), perut bagian bawah (3 menit) dan punggung (4 menit). Intervensi ini diulangi pada interval setengah jam sepanjang tahap pertama persalinan (dari 5 hingga 10 cm dilatasi serviks). (Al-Battawi, Mahmoud, & Essa, 2018; Fahami F, Behmanesh F, Valiani M, 2011 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).

Pemanasan lokal dengan cold pack intermiten adalah metode yang efektif untuk mengurangi nyeri persalinan dalam berbagai fase, selain

memperpendek tahap pertama dan ketiga persalinan. Selain itu, metode ini tidak memiliki efek negatif pada hasil persalinan seperti kesehatan janin, persalinan instrumental, perinea dan kontraksi uterus. Oleh karena itu, diharapkan metode ini akan meningkatkan kepuasan ibu, jadi dorong mereka untuk memilih persalinan alami. Terapi panas dan dingin adalah metode penghilang rasa sakit/nyeri nonfarmakologis yang murah, sederhana, aman, dan efektif sehingga penerapannya tidak memerlukan keahlian khusus, dan khususnya tersedia ketika metode farmakologis tidak dapat diakses (Ganji et al., 2013).

5. *Massage Effleurage*

a. Definisi

Kata *Massage* berasal dari bahasa Inggris yang berarti Pijatan. Pijatan itu sendiri merupakan suatu gerakan yang dapat memberikan rangsangan berupa tekanan pada saraf tubuh manusia, biasanya pemijatan akan memberikan tekanan pada titik tangan. Rangsangan yang diberikan melalui pijatan tersebut direspon oleh reseptor saraf (saraf pusat yang menerima rangsangan). Sedangkan *Effleurage* merupakan bahasa perancis yang memiliki arti *Skimming the Surface*, sedangkan jika diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu memberikan sentuhan Permukaan. *Effleurage* yaitu suatu tata cara pemijatan yang menimbulkan efek relaksasi berupa usapan atau gosokan lembut, lambat, dan tidak terputus-putus.

Ada beberapa prinsip yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan *Massage Effleurage* agar terapi bisa berjalan dengan efektif dan efisien serta terhindar dari komplikasi yang tidak diinginkan. Adapun prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan *Massage Effleurage* yaitu dengan melihat indikasi dan kontra indikasinya sebagai berikut:

1) Indikasi

Pasien yang mengalami gangguan rasa nyaman yaitu rasa nyeri pada ibu bersalin.

2) Kontra Indikasi

- a) Nyeri tekan didaerah yang akan dilakukan pemijatan.
- b) Luka terbuka pada tubuh yang akan dilakukan pemijatan.
- c) Memiliki penyakit kulit (alergi, bisul, melanoma, herpes).
- d) Tumor (tidak boleh melakukan pemijatan pada daerah tumor).
- e) Luka memar, ekimosis atau lebam.
- f) Klien yang mengalami inflamasi.
- g) Tromboplebitis.

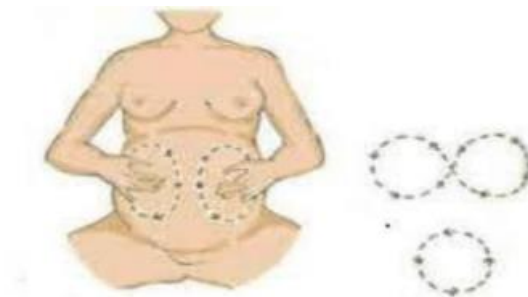
h) Mengalami gangguan sensasi nyeri maupun hiperanastesia (Mander 2004 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).

b. Teknik

Teknik *Massage Effleurage* adalah satu di antara metode terapi nonfarmakologis yang dapat di berikan pada ibu inpartu persalinan kala 1 fase aktif dan fase laten untuk mengurangi nyeri persalinan. Pijatan yang diberikan berupa usapan atau gosokan yang lembut, perlahan-lahan, dan tidak terputus-putus serta tanpa tekanan yang terlalu kuat.

1) Teknik Pemijatan Menggunakan Dua Tangan

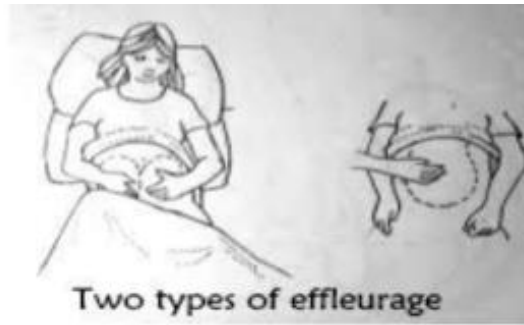
Teknik ini dapat dilakukan sendiri oleh ibu inpartu kala I persalinan dengan cara menggosok-gosok bagian abdomen secara konstan, lembut, dan tegas menggunakan kedua telapak tangan dengan tehnik gerakan melingkari bagian bawah perut, dimulai dari bagian bawah perut atau di atas tulang simpisis pubis, kemudian mengarah ke samping kiri dan kanan perut ibu, terus ke bagian atas perut (fundus uteri) lalu turun lagi ke pusat kembali lagi ke perut bagian bawah di samping simpisis pubis. Tehnik pemijatan ini dapat dilakukan secara berulang-ulang sampai ibu merasa nyaman, rileks dan rasa nyeri berkurang (Bobak et al. 2005(Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).



Gambar 1.9 Teknik Pemijatan Effleurage menggunakan Dua Tangan Oleh Ibu bersalin

2) Teknik Pemijatan Menggunakan Satu Tangan

Teknik pemijatan ini dapat diberikan dengan bantuan orang lain (suami, keluarga atau Bidan). Tehnik pemijatan satu tangan memberikan usapan pada perut ibu bersalin secara lembut, tegas, terus menerus dan perlahan-lahan yang membentuk suatu pola seperti angka delapan menggunakan ujung-ujung jari telapak tangan (Bobak et al. 2005(Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).



Gambar 1.10 Teknik Pemijatan *Effleurage* Dengan Satu Tangan

3) Teknik Pijat pada Punggung

Teknik pemijatan pada punggung dilakukan dengan menggunakan kedua telapak tangan untuk memberikan tekanan pada area kedua sisi punggung ibu dari daerah tulang lumbal 5 ke sisi atas punggung, lakukan gerakan naik turun dan berirama secara berulang-ulang. (Iburmoyo 2013(Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).

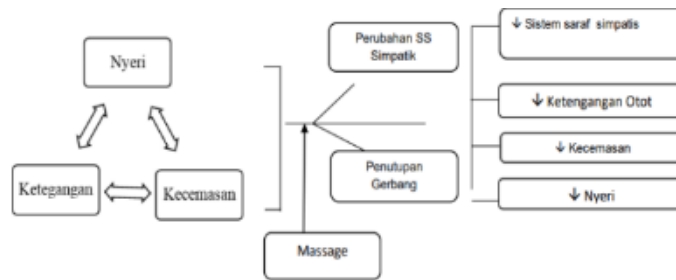


Gambar 1.11 Teknik Pijat *Effleurage* pada bagian punggung

4) Cara kerja

Teori dasar *Massage Effleurage* merupakan bentuk aplikasi dari teori gate control yang disebutkan oleh Melzack dan Wall (1965). Teori ini memberi penjelasan tentang dua jenis struktur jaringan syaraf yang memiliki diameter kecil dan struktur jaringan syaraf yang memiliki diameter besar, masing-masing struktur jaringan syaraf ini memiliki fungsi yang berbeda. Rangsangan rasa nyeri yang dialirkan oleh struktur jaringan syaraf yang berdiameter kecil memberikan efek gate control terbuka di susunan syaraf sumsum tulang belakang dan rangsangan ini diteruskan ke susunan syaraf pusat sehingga kita bisa merasakan rasa nyeri. Tetapi rangsangan nyeri ini dapat dihambat yaitu dengan memberikan pemijatan pada syaraf yang memiliki diameter besar sehingga menyebabkan gate control akan tertutup dan rasa nyeri tidak dapat diteruskan kembali ke susunan syaraf pusat. (Purwaningsih & Fatmawati 2010 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).

Bagan Hubungan Antara Massage & Nyeri Berdasarkan Teori Gate Control (Mander, 2012 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).



Gambar 1.12 Teori Gate Control

6. Terapi 3 R “Relaksasi, Ritme Dan Ritual”

Diluar berbagai macam cara yang digunakan oleh masing–masing wanita untuk menghadapi persalinan, ada beberapa kemiripan dasar di antara para wanita yang mampu menghadapi dengan baik, yang kami artikan - menghadapi dengan baikll adalah mereka yang dapat melalui kontraksinya tanpa merasa hal itu memberi pengaruh berlebihan padanya. Ada tiga hal umum pada perilaku mereka ini: relaksasi, ritme, ritual. Kita menyebutnya 3 R, yang merupakan deskripsi dari perilaku essensial, universal dan naluriah dari wanita dalam persalinan. Teknik relaksasi, tindakan kenyamanan dan latihan pernapasan akan meningkatkan kemampuan seseorang yang akan menghadapi persalinan dengan penerapan 3 R. (Simkin, 2008 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).

a. Relaksasi

Relaksasi merupakan salah satu gaya yang digunakan untuk mengurangi ketegangan otot dalam tubuh yang berfungsi sebagai pusat ketenangan selama persalinan berlangsung. Sangatlah penting untuk tetap relaks selama kontraksi pada awal persalinan karena di saat inilah relaksasi biasanya mudah dilakukan. Jika ibu secara sadar berusaha untuk tetap relaks selama kontraksi awal ini, ibu sudah membangun kebiasaan yang baik yang akan berlanjut sampai tahap persalinan lanjut.

b. Manfaat

Menerapkan tehnik relaksasi selama persalinan akan memberikan manfaat, di antaranya; (Simkin, 2008 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).

- 1) Menyimpan Energi dan Menurunkan Keletihan
- 2) Meredakan Pikiran dan Menurunkan Stres
- 3) Menurunkan Nyeri

c. Ritme

1) Lingkup ritme

Wanita yang mampu menghadapi dengan baik bergantung pada ritme dalam berbagai bentuk. Misalnya mereka bernapas, merintih atau bernyayi dengan irama. Mereka mengetuk atau membelai sesuatu atau seseorang secara berirama. Mereka mengayun, bergoyang atau bahkan

berdansa dengan berirama. Mereka bahkan menekuk dan membuka tekukan ibu jari kaki secara berirama atau mereka mungkin menginginkan seseorang mengajaknya berbicara, membelai atau bersama-sama merintih bersamanya. Aktivitas ritmis dapat menenangkan pikiran melalui efek peredanya. (Simkin, 2008 (Hamdiah Ahmar, dkk, 2021)).

2) Memusatkan Perhatian

Selama kontraksi persalinan, perhatian ibu sebaiknya dipusatkan pada sesuatu, banyak wanita lebih menyukai fokus internal. Sebagai contoh, beberapa wanita menutup matanya dan serta membuka leher rahim membayangkan efek kontraksi sampai dengan otot-otot Rahim membuka leher Rahim dan bayi menekan ke bawah serta membuka leher Rahim lebih besar. Juga akan membantu bila ibu memusatkan diri pada sesuatu. Fokus Visual sering disebut dengan titik focus eksternal. Ibu mungkin ingin memusatkan diri pada wajah pasangan, sebuah gambar di dinding, barang yang mengingatkan akan si bayi (sebuah mainan), sebuah obyek yang ada di ruangan, bunga, atau pemibungan diluar jendela.

Banyak wanita merasa terbantu saat mereka memusatkan diri pada sentuhan. Contoh dari fokus taktil ini mencakup pijatan berirama dari pasangan ibu, usapan pada salah satu daerah tubuh atau pelukan yang erat.

Wanita lain memusatkan diri pada suara. Contoh dari fokus Auditori mencakup mendengarkan rekaman music kesayangan, suara pasangan yang menenangkan, irama yang berulang, atau rekaman dari bunyi-bunyi luar seperti ombak, hujan atau aliran air.

Teknik pemusatan perhatian lainnya yang digunakan wanita untuk melalui kontraksi mencakup melakukan aktivitas fisik tertentu. Contohnya mencakup bernapas dengan pola yang rumit, relaks dengan pemeriksaan tubuh, dan bergerak dengan mengayun, mondar-mandir, berjalan, berdansa, pijat, atau mengusap-usap.

3) Ritual

Meskipun kata ritual biasanya digunakan pada aktivitas keagamaan atau budaya atau kebiasaan tingkah laku (seperti ritual pagi hari), dalam konteks persalinan ritual mengacu pada pengulangan aktivitas ritmis yang bermakna. Untuk menghadapi kontraksi pengajar kursus melahirkan (bidan dalam kelas ibu hamil) mengajarkan ritual yang meliputi relaksasi, pernapasan dan memusatkan perhatian.

Ritual semacam ini membantu wanita pada awal persalinan untuk membentuk gaya pengendalian yang efektif. Namun, sewaktu persalinan

berkembang dan menjadi lebih hebat sebagian besar wanita menyesuaikan atau menambah ritual yang telah dipelajarinya dengan cara-cara yang mencerminkan gaya pengendalian pribadi dan membantu mereka menghadapi tantangan spesifik dari persalinan.

7. Metode *Acupressure*

Acupressure adalah pijat yang berlandaskan ilmu akupunktur dengan seperangkat keilmuannya antara lain teori yin yang, gejala kelainan fungsi organ. *Acupressure* disebut juga akupunktur tanpa jarum, atau pijat akupunktur. Teknik ini menggunakan teknik ini menggunakan teknik penekanan, pemijatan, dan pengurutan sepanjang meridian tubuh atau garis ukuran energy (Hamlin & Robertson, 2017; (Rejeki & Hartiti, 2017).

Titik *Acupressure* untuk nyeri persalinan, antara lain :

a. Titik Cien Cing

Titik ini dapat diketahui dengan cara menarik garis khayal antara C7 menuju prosesus acromion, titik cien cing terletak pada pertengahan garis tersebut. Akupresuris dapat menemukan titik ini pada tubuh sendiri dengan mengangkat tangan diagonal melewati dada dan palpasi sendiri dengan menggunakan jari telunjuk sepanjang garis khayal tersebut. Titik ini berguna pada fase pertama dan kedua persalinan untuk menstimulasi kontraksi uterus. Titik ini merupakan titik terbaik digunakan saat menyusui, membuat rileks otot pundak dan meningkatkan suplay ASI.

Teknik akupresur: Lakukan penekanan kebawah pada titik cien cing tersebut menggunakan ibu jari, atau siku. Ketika menggunakan ibu jari, berikan tekanan yang berasal dari lengan bukan tekanan yang berasal dari sendi ibu jari. Pada titik ini sebaiknya dilakukan pada kedua bahunya, namun dapat juga dilakukan sendiri pada satu bahu. Tekanan dapat dilakukan pada setiap permulaan kontraksi atau lakukan penekanan lembut secara terus-menerus untuk mengintensifkan kontraksi.

b. Titik BL 32 (Pang Kuang Su)

Lokasi titik ini kira-kira sepanjang jari telunjuk wanita diatas lipat pantat selebar ibu jari disisi tulang belakang. Saat persalinan mulai, awali teknik akupresur dengan melakukan penekanan pada titik ini dengan menggerakkan jari menuruni tulang belakang (kira-kira selebar ibu jari) sejalan dengan kemajuan persalinan.



Gambar 1.13 Titik BL 32 (Pang Kuang Su)

Teknik akupresur: Tempatkan jari pada titik akupresur dan lakukan tekanan yang lembut. Tekanan dapat ditingkatkan dengan melakukan penekanan kearah belakang pada awal kontraksi. Titik ini sering digunakan karena memiliki efek "anestesi" pada kontraksi kuat, yang hilang saat penekanan dihentikan. Penekanan menimbulkan rasa hangat, geli, dan agak sakit. Jika terlalu sakit, tekan area di sekitar tulang. Penekanan kuat pada titik BL32 dapat dilakukan pada wanita bersalin yang selalu ingin mendedan sedangkan serviks belum cukup berdilatasi.

c. Titik pantat

Titik ini berada pada garis horisontal dari puncak lipatan pantat. Jika melakukan tekanan pada sepanjang garis ini akan terasa lembut kira kira dua pertiga antara lipatan pantat dann tulang pinggul.

Teknik akupresur: Tempatkan tangan pada pinggul pasien dan lakukan dorongan kedalam titik ini dengan menggunakan ibu jari dan bantu ibu untuk bergerak saat kontraksi. Dua samapai 3 hari sebelum tanggal persalinan, BL 32 dan titik pantat dapat digunakan bersamaan dengan masage pada sakral, lakukan penekanan kebawah dan mengelilingi pantat. Tujuannya adalah memberikan energi pada serviks agar persalinan berjalan secara optimal.

d. Titik pada tangan

Titik ini terletak sepanjang lipatan tangan ketika jari-jari menyatu pada telapak tangan. Titik ini membantu pelepasan endorphen ke dalam tubuh.

Teknik akupresur: Pegang sisir kecil dengan kencang. Pasien dapat menggenggam sisir tersebut saat kontraksi dan anjurkan pada pasien untuk melakukan tindakan ini bila terasa bermanfaat. Titik ini sangat membantu untuk menurunkan nyeri saat kontraksi

e. Titik K1

Titik ini terletak pada 1/3 bagian atas telapak kaki, ketika telapak kaki fleksi (menarik jari kaki kedepan kearah telapak kaki).



Gambar 1.14 Titik K1

Teknik akupresur: Lakukan penekanan yang kuat kedalam dan kedepan kearah jempol kaki. Titik ini mempunyai efek relaksasi dan dapat digunakan kapan saja saat persalinan dan sangat efektif dilakukan selama fase kedua persalinan. Penekanan pada titik ini juga dapat berguna saat pasien panik (misal mempunyai pengalaman yang tidak menyenangkan pada persalinan sebelumnya). Titik ini berguna untuk membantu perineum relaksasi selama fase kedua persalinan.

f. Titik Co4 (He Kuk)

Titik ini terletak antara tulang metakarpal pertama dan kedua (antara ibu jari dan jari telunjuk) pada bagian distal lipatan pada kedua tangan.



Gambar 1.15 Titik Co4 (He Kuk)

Teknik akupresur: Berikan penekanan pada titik ini dengan menggunakan ibu jari. Penekanan pada titik ini berguna untuk mengintensifkan kontraksi, saat kontraksi ireguler.

g. Titik Sp6 (San Yin Ciao)

Titik Spleen Point 6 (SP6) dianggap sebagai salah satu poin yang lebih serbaguna dan umum digunakan. Itu digunakan untuk banyak kondisi, termasuk induksi persalinan. Dikenal sebagai Sanyinjiao - atau persimpangan tiga yin. SP6 terletak di atas pergelangan kaki, di bagian belakang tulang kering (betis bawah), titik ini penting untuk membantu dilatasi serviks dan dapat digunakan ketika serviks tidak efektif berdilatasi selama persalinan. Titik ini terletak empat jari diatas mata kaki dalam.



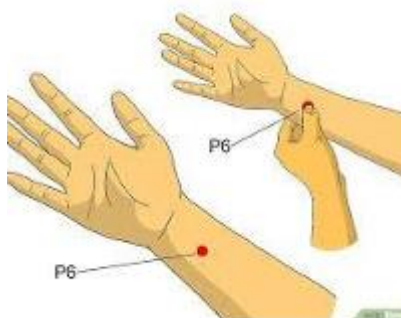
Gambar 1.16 Titik Sp6 (San Yin Ciao)

Teknik Akupresur:

- 1) Lakukan tekanan langsung pada titik ini dengan telunjuk atau ibu jari.
- 2) Gunakan titik ini pada satu kaki kira-kira satu menit (hitung perlahan sampai 60)
- 3) Kemudian gunakan titik ini pada kaki yang lain setelah 20-30 menit.
- 4) Setelah dilakukan penekanan pada titik ini, beberapa wanita akan merasakan serviks meregang dan kontraksi semakin kuat.
- 5) Teknik ini sebaiknya tidak digunakan saat persalinan berjalan normal, persalinan bukan berapa jam dapat melahirkan, namun bagaimana menikmati proses melahirkan.
- 6) Ketika ketuban telah pecah dan persalinan tidak mengalami kemajuan dapat dilakukan penekanan pada BL32 dan Sp 6 untuk membantu persalinan.

h. Titik P6

Titik ini terletak 3 jari diatas pergelangan tangan segaris dengan jari tengah.



Gambar 1.17. Titik P6

Teknik akupresur : Titik ini dapat digunakan pada mual ringan sampai muntah. Lakukan penekanan pada titik ini dan pertahankan sampai terasa efektif, biasanya selama 5 menit. Penekanan ini dapat dilakukan pada satu pergelangan tangan atau keduanya.

8. Teknik Moxibustion

Moxibustion adalah pengobatan tradisional Cina untuk memperbaiki presentasi sungsang dengan merangsang acupuncture point (acupoint) Zhiyin (Bladder67/BL-67). (9) Terapi ini dapat meningkatkan aktivitas janin sehingga diharapkan janin mampu memutar dari presentasi bokong menjadi presentasi kepala (Waslia, 2021).

Cara kerja moxibustion dapat dijelaskan dengan menggunakan Fisiologi Barat dan Pengobatan Tradisional Cina (TCM). Menurut TCM, Moxibustion adalah praktik pembakaran daun mugwort (stik moxa) pada titik-titik akupunktur BL 67 atau Zhi Yin di kaki menghasilkan energi YANG (energi pemanasan) pada dasar panggul. Adanya stimulus panas pada titik akupunktur BL 67 bisa menghasilkan stimulasi adrenocortical mengakibatkan peningkatan dalam estrogen plasenta. Adanya sensitivitas yang lebih besar dari miometrium dan perubahan prostaglandin maka akan terjadi peningkatan energi kontraktilitas uterus, sehingga akan menyebabkan stimulasi gerakan janin berupa gerakan dan probabilitas yang lebih tinggi untuk versi janin, sehingga efeknya bayi bergerak memutar serta berbalik (Waslia, 2021).

Prosedur Moxibustion, antara lain :

a) Moxibustion pada titik BL-67

Ibu hamil diinstruksikan untuk berbaring. Panas dari pembakaran stik moxa dialirkan di titik acupoint BL-67, samping sudut luar kuku kecil (kuku jari kelingking kaki). Panas diterapkan dari jarak 1,5-3 cm. Intervensi dilakukan di rumah dan dibantu oleh anggota keluarga yang lain. Teknik ini dilakukan selama ± 20 menit sehari selama 2 minggu. Penerapan teknik ini juga dapat dilakukan 2 kali sehari, selama ± 15 menit selama 1 minggu.



Gambar 1.18 Moxibustion pada titik BL-67

b) Moxibustion pada titik lain

Prosedur yang dilakukan identik dengan moxibustion pada titik BL-67, hanya saja pada teknik ini titik yang dirangsang adalah acupoint Yinbai (SP-1), terletak di samping sudut bagian dalam kuku besar (kuku jari jempol kaki)

c) Perawatan biasa

Pemeriksaan kehamilan dilakukan oleh dokter umum dan perawat bidan selama minimal enam kali kunjungan yang dijadwalkan. Risiko kehamilan dikaji setiap kali kunjungan, pemeriksaan USG dilakukan setiap tiga bulan dan cardiotocography non-stress dilakukan di minggu ke-40. Pada pemeriksaan USG yang menunjukkan adanya presentasi janin sungsang maka ibu direkomendasikan untuk melakukan teknik knee-chest.

D. Keimpulan

Nyeri merupakan suatu proses alamiah dalam persalinan. Nyeri juga merupakan pengalaman sensori atau emosional yang tidak menyenangkan yang diakibatkan dari kerusakan. Nyeri disebabkan oleh beberapa factor yang mempengaruhi seperti arti nyeri, persepsi nyeri, dan reaksi terhadap nyeri. Nyeri yang dialami dapat dipersepsikan berbeda oleh orang, sehingga perlu beberapa pengkajian persepsi yang dapat dilakukan seperti dengan menggunakan PQRST, *Skala Wong-Baker FACES Pain Rating Scale, Comparative Pain Scale, Verbal Rating Scale, Visual Analogue Scale dan Numeral Rating Scale*.

Rasa nyeri yang dialami selama persalinan bersifat unik pada setiap ibu dan dapat dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain budaya, takut, kecemasan, pengalaman persalinan sebelumnya, persiapan persalinan dan dukungan persalinan. Metode untuk mengurangi nyeri tidak hanya diatasi dengan cara farmakologis, namun cara non farmakologis mampu mengurangi rasa nyeri persalinan yaitu dengan teknik pernafasan, *Counter Pressure, Hypnobirthing, Warm & Cold Water Therapy, Massage Effleurage*, Terapi 3 R "Relaksasi, Ritme dan Ritual", Teknik *Acupressure*, dan Teknik *Moxibustion*.

E. Referensi

- Ahmad Darel Fadlil. 2019. *Manajemen Nyeri*. Diakses pada tanggal 30 Desember 2024 melalui https://id.scribd.com/embeds/515931094/content?start_page=1&view_mode=sgulung&access_key=key-fFexxf7MbzfWu3HKwf
- Aprillia, Y. 2012. Moxibution & Hypnobirthing untuk Kehamilan Sungsang. Diakses pada tanggal 7 Januari 2025 melalui http://www.bidankita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=493:moxibution-a-hypnobirthing-untukkehamilan-sungsang&catid=44:naturalchildbirth&Itemid=56
- Bobak, Lowdermilk dan Jensen. 2005. Buku Ajar Keperawatan Maternitas. Jakarta: Penerbit buku Kedokteran EGC*

- Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse, Spong CY. Obstetri Williams. 23rd ed. United States of America: The McGraw Hill Companies.; 2014
- Dede Waslia. (2021). Moxibustion Sebagai Alternatif Penanganan Letak Sungsang. *Jurnal Kesehatan Kartika*, 1907-3879. <https://doi.org/10.26874/jkkes.v16i1.162>
- Gadysa, 2009, *Persepsi Ibu Tentang Metode Masase*. Diakses 10 Januari 2025, dari <http://luluvikar.wordpress.com>
- Hamdiah Ahmar, dkk. 2021. *Manajemen Nyeri Persalinan Nonfarmakologis*. Malang. Ahlimedia Press.
- Indrayani, dkk. (2016). Update Asuhan Persalinan dan bayi Baru Lahir. Jakarta: CV. Trans Info Media
- Kusuma, P. D. (2013). *Moxibustion Sebagai Terapi Untuk Membantu Versi / Pemutaran Pada Janin Dengan Presentasi Sungsang : Studi Literatur*.
- Kuswandi, Lanny. (2013). *Hypnobirthing, A Gentle Way to Give Birth*. Jakarta: Pustaka Bunda
- Manuaba, Ida Ayu. 2010. Ilmu Kebidanan, Penyakit kandungan dan KB. Edisi 2. EGC. Jakarta.
- Mellysa. 2020. *LAPORAN PENDAHULUAN PRAKTIKUM MANAJEMEN NYERI PERSALINAN*. Diakses pada tanggal 30 Desember 2024 melalui https://id.scribd.com/embeds/376800449/content?start_page=1&view_mode=sgulung&access_key=key-ffexxf7MbzfWu3HKwf Sri Rejeki. 2020. *Buku Ajar Manajemen Nyeri Dalam Proses Persalinan (Non Farmaka)*. Semarang. Unimus Press.
- Neri, I., Pace, V.D., Venturini, P., Facchinetti, F. 2007. Effects of Three Different Stimulations (Acupuncture, Moxibustion, Acupuncture Plus Moxibustion) of BL.67 Acupoint at Small Toe on Fetal Behavior of Breech Presentation. *The American Journal of Chinese Medicine*, Vol. 35, No. 1, 27–33
- Orshan, Susan A. 2008. *Maternity, and Women's Health Nursing : Comprehensive. Care Across The Lifespan*. Wolters Kluwer : USA
- Vas J, Aranda JM, Aranda JM, Modesto M, Ramos M, Baron M, Using moxibustion in primary healthcare to correct non-vertex presentation: a multicentre randomized controlled trial. *Acupunct Med* 2013; 31-38.

CHAPTER 2

FASE – FASE PERSALINAN NORMAL DAN PENGELOLAANNYA

Zumrotul Ula, S.ST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Persalinan adalah salah satu momen paling penting dalam kehidupan seorang ibu, menandai lahirnya seorang bayi yang dinantikan. Proses ini, meskipun alami, memerlukan pemahaman yang mendalam untuk memastikan kelancaran dan keselamatan bagi ibu maupun bayi. Persalinan normal terdiri dari serangkaian fase yang terstruktur dengan baik, mulai dari pembukaan awal serviks hingga kelahiran bayi dan plasenta (Siregar et al., 2023).

Tahap pertama persalinan dimulai dengan fase laten dan fase aktif, di mana pembukaan serviks berlangsung untuk mempersiapkan jalur kelahiran. Ini adalah masa ketika tubuh ibu mulai merespons dengan kontraksi yang teratur dan bertahap menjadi lebih intens. Setelah itu, tahap kedua persalinan, yaitu fase ekspulsi, terjadi. Pada fase ini, bayi didorong keluar melalui jalan lahir dengan bantuan kontraksi rahim yang kuat dan dorongan mengejan dari ibu. Tahap terakhir, fase pengeluaran plasenta, adalah saat plasenta dan jaringan lain dikeluarkan untuk menyelesaikan proses persalinan (Yulizawati et al., 2019).

Setiap fase persalinan memerlukan pengelolaan yang tepat untuk mendukung proses alami tubuh ibu sambil memastikan keselamatan ibu dan bayi. Pengelolaan ini melibatkan pengamatan terus-menerus terhadap tanda vital ibu, detak jantung janin, dan kemajuan pembukaan serviks. Dukungan emosional, panduan teknik pernapasan, dan posisi yang nyaman juga menjadi bagian penting dalam mendampingi ibu selama persalinan. Dalam beberapa kasus, intervensi medis seperti pemberian oksitosin, episiotomi, atau penanganan nyeri mungkin diperlukan sesuai indikasi (Kunang & Sulistianingsih, 2023).

Pemahaman yang mendalam tentang fase-fase persalinan normal dan pengelolaannya tidak hanya membantu tenaga medis dalam memberikan pelayanan terbaik, tetapi juga memberdayakan ibu dan keluarga untuk menghadapi proses persalinan dengan kesiapan fisik dan mental. Pengetahuan ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan pengalaman kelahiran yang aman, bermakna, dan penuh dukungan (K & Cholifah, 2019).

B. Fase-fase persalinan Normal

Menurut (Kunang & Sulistianingsih, 2023) persalinan dapat diartikan bahwa terjadinya kelahiran bayi, plasenta, dan selaput ketuban dari rahim ibu. Kejadian ini dianggap normal jika terjadi pada masa kehamilan yang cukup bulan, antara 37 sampai 40 minggu, tanpa disertai dengan komplikasi. Proses ini dibagi menjadi beberapa fase, yaitu:

1. Fase Laten pada persalinan normal

Kala I dalam persalinan berawal dari fase laten yaitu dari pertama kali mengalami kontraksi sampai terjadinya pembukaan serviks mendekati 4 cm, kemudian walaupun tidak terlalu mules tetapi kontraksi berangsur teratur namun dengan durasi antara 20-30 detik (Indryani, 2024).

Fase laten adalah tahap awal dalam proses persalinan, yang ditandai oleh kontraksi rahim yang teratur dan perubahan pada serviks. Pada fase ini, serviks mulai menipis (efacement) dan perlahan-lahan membuka (dilatasi) hingga mencapai 3-4 cm.

a. Ciri-ciri fase laten

1) Kontraksi pada fase laten

- a) Mulai teratur, tetapi masih ringan hingga sedang.
- b) Durasi kontraksi sekitar 30-45 detik.
- c) Frekuensi kontraksi setiap 5-20 menit.

2) Perubahan Serviks pada fase laten

- a) Serviks mulai menipis (efasemen) dan membuka hingga 3-4 cm.
- b) Proses ini berlangsung perlahan.

3) Durasi yang biasanya terjadi pada fase laten

- a) Pada ibu primigravida (kehamilan pertama), fase laten dapat berlangsung hingga 20 jam.
- b) Pada ibu multigravida (kehamilan kedua atau lebih), fase laten biasanya lebih singkat, sekitar 14 jam.

b. Tanda-Tanda yang muncul pada fase laten

1) Kontraksi Rahim

Nyeri yang ringan hingga sedang, menyerupai kram menstruasi.

2) Keluarnya Lendir atau Darah

Bisa terjadi "*bloody show*," yaitu keluarnya lendir bercampur darah akibat perubahan pada serviks.

3) Ketuban Utuh, pada fase laten, ketuban umumnya masih utuh (Putri et al., 2022)

c. Pendekatan dan Manajemen

1) Pemantauan di Rumah

- a) Jika kontraksi belum terlalu kuat atau teratur, ibu dapat tetap di rumah dengan melakukan aktivitas ringan.
- b) Pastikan ibu mendapatkan cukup istirahat, makan, dan minum untuk menjaga energi.

2) Teknik Relaksasi

- a) Latihan pernapasan dalam.
- b) Relaksasi otot untuk mengurangi ketegangan.

3) Kapan Harus ke Rumah Sakit

- a) Jika kontraksi menjadi lebih teratur (setiap 5 menit sekali selama 1 jam pada ibu primigravida, atau setiap 10 menit sekali pada ibu multigravida).
- b) Jika terjadi pecahnya ketuban.
- c) Jika ada tanda bahaya seperti perdarahan banyak atau nyeri hebat yang tidak hilang di antara kontraksi.

d. Peran Tenaga Kesehatan

1) Edukasi

Memberikan informasi kepada ibu hamil tentang fase laten dan apa yang diharapkan.

2) Pemantauan

- a) Melakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan kondisi ibu dan janin.
- b) Mengevaluasi perubahan pada serviks.

3) Dukungan Emosional

Membantu ibu tetap tenang dan percaya diri menghadapi proses persalinan.

Fase laten adalah tahap penting yang mempersiapkan tubuh ibu untuk memasuki fase aktif persalinan. Dukungan yang tepat selama fase ini dapat meningkatkan pengalaman persalinan yang positif dan mengurangi risiko komplikasi (Lestari et al., 2024).

2. Fase Aktif pada persalinan normal

Fase aktif adalah tahap kedua dalam proses persalinan normal, yang dimulai sejak adanya pembukaan serviks 4 cm dan berlangsung sampai pembukaan penuh (10 cm). Pada fase ini, kontraksi rahim menjadi lebih kuat, teratur, dan intens, yang bertujuan mendorong janin lebih jauh ke dalam jalan lahir.

a. Ciri-Ciri Fase Aktif

1) Kontraksi

- a) Frekuensi: kontraksi terjadi setiap 2–5 menit.
- b) Durasi: setiap kontraksi berlangsung selama 45–60 detik.
- c) Intensitas: kuat dan lebih menyakitkan dibandingkan fase laten.

2) Perubahan Serviks

- a) Dilatasi serviks bertambah cepat, dari 4 cm hingga 10 cm.
- b) Kecepatan dilatasi

Pada ibu primigravida 1 cm/jam sedangkan pada ibu multigravida 1,5–2 cm/jam.

3) Durasi Fase Aktif, pada primigravida biasanya berlangsung antara 4-8 jam, sedangkan pada multigravida biasanya berlangsung antara 2-5 jam.

4) Ketuban Pecah

Ketuban dapat pecah secara spontan pada fase ini jika belum pecah sebelumnya.

5) Perasaan Ibu

- a) Rasa nyeri meningkat.
- b) Tekanan pada area panggul lebih terasa, terkadang disertai keinginan mengejan (Subagio, 2022).

b. Tahapan dalam Fase Aktif

1) Tahap Percepatan Awal

- a) Adanya pembukaan serviks dari 4 cm hingga sekitar 7 cm.
- b) Terjadinya peningkatan kontraksi dan lebih teratur.

2) Tahap Percepatan Maksimal

- a) Adanya pembukaan serviks dari 7 cm sampai 10 cm.
- b) Kontraksi mencapai puncak intensitasnya.

c. Tanda-Tanda Fase Aktif

1) Nyeri dan Tekanan Panggul

Nyeri kontraksi yang terasa di perut, punggung bawah, atau panggul.

2) Perubahan Pola Pernapasan

Ibu mungkin kesulitan mengatur napas akibat intensitas kontraksi.

3) Perasaan Tidak Nyaman

Beberapa ibu merasa cemas, tidak nyaman, atau lelah.

d. Pendekatan dan Manajemen

1) Pendampingan oleh Tenaga Kesehatan

- a) Pemantauan intensif terhadap kondisi ibu dan janin.
- b) Pemeriksaan dalam untuk mengevaluasi dilatasi serviks.

2) Teknik Relaksasi dan Pernapasan

Mengajarkan ibu teknik pernapasan dalam dan teratur untuk mengelola nyeri.

3) Edukasi dan Dukungan Psikologis

Memberikan dorongan dan edukasi tentang tahapan yang sedang berlangsung.

4) Manajemen Nyeri

a) Tanpa obat (teknik relaksasi, hipnoterapi).

b) Dengan obat (analgesia epidural atau injeksi opioid jika diperlukan).

5) Pemantauan Janin

Evaluasi detak jantung janin setiap 15–30 menit (Zaharoh et al., 2021).

e. Peran Tenaga Kesehatan

1) Memastikan Keamanan

Memantau tanda vital ibu dan janin secara berkala.

2) Dukungan Emosional

Membantu ibu tetap tenang dan percaya diri menghadapi kontraksi.

3) Tindakan Medis

Melakukan intervensi jika terjadi komplikasi seperti persalinan macet atau tanda gawat janin.

Fase aktif adalah tahap krusial dalam proses persalinan karena menjadi penentu kesiapan ibu untuk mengejan pada fase berikutnya. Manajemen yang baik selama fase ini dapat meminimalkan risiko komplikasi dan membantu proses persalinan berlangsung lancar (Marsilia & Tresnayanti, 2021).

3. Fase Ekspulsi

Fase ekspulsi adalah tahap kedua dalam proses persalinan, yang dimulai setelah pembukaan serviks mencapai 10 cm (pembukaan lengkap) dan berakhir dengan lahirnya bayi. Fase ini ditandai dengan keinginan ibu untuk mengejan akibat tekanan kepala bayi pada dasar panggul.

a. Ciri-Ciri Fase Ekspulsi

1) Kontraksi

a) Frekuensi: Setiap 2–3 menit.

b) Durasi: Setiap kontraksi berlangsung 60–90 detik.

c) Intensitas: Sangat kuat, dengan tujuan mendorong bayi keluar melalui jalan lahir.

2) Keinginan Mengejan

Ibu merasa dorongan yang sangat kuat untuk mengejan, disebabkan oleh tekanan kepala bayi pada otot dasar panggul dan rektum.

3) Posisi Kepala Bayi

Kepala bayi mulai terlihat di introitus vagina saat kontraksi (crowning).

- 4) Durasi Fase Ekspulsi, pada primigravida biasanya berlangsung antara 1-2 jam, dan pada multigravida antara 30 menit-1 jam.
- 5) Pengeluaran Lendir dan Darah:
Lendir bercampur darah lebih banyak terlihat akibat peregangan jaringan dan proses kelahiran.
- b. Tahapan dalam Fase Ekspulsi
 - 1) Tahap Dorongan Aktif
 - a) Ibu mulai mengejan seiring dengan kontraksi.
 - b) Kepala bayi turun lebih jauh melalui jalan lahir.
 - 2) Tahap Crowning
 - a) Kepala bayi terlihat di introitus vagina dan tidak masuk kembali meskipun kontraksi selesai.
 - b) Proses ini sering menyebabkan sensasi "panas" atau "terbakar" pada perineum.
 - 3) Tahap Lahirnya Bayi
Setelah kepala bayi keluar, bahu dan tubuh bayi lahir secara bertahap.
- c. Tanda-Tanda Fase Ekspulsi
 - 1) Tekanan Panggul dan Rektum
Tekanan kuat pada perineum dan rektum, sering disertai keinginan buang air besar.
 - 2) Sensasi Crowning
Rasa meregang atau panas pada perineum ketika kepala bayi mulai keluar.
 - 3) Nyeri dan Tekanan
Rasa nyeri akibat kontraksi rahim dan peregangan jaringan (Siregar et al., 2023).
- d. Pendekatan dan Manajemen
 - 1) Pendampingan oleh Tenaga Kesehatan
 - a) Memberikan arahan kepada ibu untuk mengejan dengan teknik yang benar.
 - b) Mendukung posisi yang nyaman dan efektif bagi ibu (misalnya posisi semi-duduk, miring, atau jongkok).
 - 2) Teknik Mengejan
 - a) Ibu diarahkan untuk mengejan hanya saat kontraksi terjadi.
 - b) Pernapasan diatur untuk menghindari kelelahan berlebihan.
 - 3) Perlindungan Perineum
Melakukan teknik seperti pijatan perineum atau episiotomi jika diperlukan untuk mencegah robekan besar.
 - 4) Pemantauan Janin

Memastikan detak jantung janin tetap stabil selama proses ekspulsi.

5) Tindakan Medis

Jika persalinan terhambat (distosia), dokter atau bidan dapat melakukan intervensi seperti penggunaan forceps atau vakum ekstraksi.

e. Peran Tenaga Kesehatan

1) Memastikan Proses Aman

Memantau kondisi ibu dan bayi selama fase ini.

2) Memberikan Dukungan Psikologis

Mendorong ibu untuk tetap tenang dan fokus selama mengejan.

3) Mengelola Komplikasi

Menangani potensi komplikasi seperti gawat janin atau distosia bahu.

Fase ekspulsi adalah tahap kritis dalam persalinan normal, di mana ibu memerlukan dukungan fisik dan emosional yang optimal. Manajemen yang baik selama fase ini dapat mencegah komplikasi seperti trauma perineum berat dan meningkatkan keselamatan bayi. Fase ekspulsi berakhir ketika bayi lahir sepenuhnya, dengan tali pusat yang masih terhubung dengan plasenta. Setelah itu, persalinan masuk ke fase ketiga (fase kelahiran plasenta).

C. Pengelolaan atau intervensi pada Fase Laten dalam persalinan Normal

Fase laten merupakan tahap awal persalinan normal yang ditandai dengan kontraksi ringan hingga sedang yang mulai mempersiapkan serviks untuk dilatasi lebih lanjut. Dalam fase ini, pengelolaan yang tepat diperlukan untuk memberikan kenyamanan, mengurangi kecemasan, dan memastikan proses persalinan berjalan fisiologis.

1. Tujuan Pengelolaan Fase Laten

- a. Mendukung kenyamanan fisik dan emosional ibu.
- b. Mengidentifikasi kemungkinan komplikasi sejak dini.
- c. Mengoptimalkan persiapan tubuh ibu menuju fase aktif.

2. Pengelolaan Fase Laten

Pengelolaan pada fase laten berfokus pada pendekatan non-invasif dan suportif untuk memastikan proses persalinan berlangsung alami.

a. Edukasi dan Informasi

1) Berikan penjelasan kepada ibu:

a) Fase laten adalah bagian normal dari persalinan, dan durasinya bervariasi.

b) Anjurkan ibu untuk tidak terlalu cemas jika proses terasa lambat.

2) Ajarkan teknik relaksasi:

a) Latihan pernapasan dalam (deep breathing).

- b) Teknik visualisasi positif.
- b. Dukungan Psikologis
 - 1) Pastikan ibu merasa didukung secara emosional oleh tenaga kesehatan dan pendamping persalinan.
 - 2) Berikan suasana yang nyaman dan menenangkan, seperti ruangan dengan pencahayaan lembut.
- c. Aktivitas Fisik
 - 1) Anjurkan ibu untuk tetap aktif:
 - a) Berjalan-jalan perlahan untuk membantu proses persalinan.
 - b) Posisi tegak (berdiri, duduk di bola yoga) untuk memanfaatkan gravitasi.
 - 2) Hindari kelelahan berlebihan:
Beri waktu untuk istirahat di antara kontraksi.
- d. Nutrisi dan Hidrasi

Berikan minuman ringan seperti air putih, teh, atau jus untuk mencegah dehidrasi. Dan konsumsi makanan ringan seperti buah-buahan atau roti jika ibu merasa lapar.
- e. Pemantauan
 - 1) Pantau kondisi ibu, dengan memeriksa tanda vital (tekanan darah, denyut nadi, suhu) serta frekuensi dan intensitas kontraksi.
 - 2) Pantau janin, dengarkan denyut jantung janin setiap 30–60 menit menggunakan Doppler.
- f. Manajemen Nyeri

Gunakan metode non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, seperti:

 - 1) Kompres hangat di punggung bawah.
 - 2) Pijatan lembut di area punggung.
 - 3) Teknik mandi air hangat (water immersion).
- g. Intervensi Medis (Jika Diperlukan)

Hindari intervensi medis kecuali ada indikasi khusus seperti:

 - 1) Ketuban pecah dini (PROM).
 - 2) Tanda gawat janin.
 - 3) Progresi persalinan yang terlalu lambat (fase laten berkepanjangan).

3. Indikasi Rujukan

Rujukan atau tindakan lebih lanjut diperlukan jika ditemukan:

- a. Fase laten berlangsung lebih dari 20 jam (primigravida) atau lebih dari 14 jam (multigravida).
- b. Tanda gawat janin (denyut jantung janin abnormal).
- c. Ketuban pecah dengan cairan hijau (mekonium).
- d. Tidak ada progres dilatasi serviks setelah observasi yang memadai.

Pengelolaan fase laten persalinan normal bertujuan untuk mendukung ibu secara fisik dan emosional serta memantau perkembangan proses persalinan tanpa intervensi yang tidak perlu. Dukungan psikologis, pemberian edukasi, dan pendekatan non-farmakologis merupakan kunci keberhasilan dalam fase ini.

D. Pengelolaan atau intervensi pada Fase Aktif dalam persalinan Normal

Fase aktif merupakan bagian dari tahap pertama persalinan, di mana pembukaan serviks berlangsung lebih cepat, dari 4 cm hingga pembukaan penuh (10 cm). Pada fase ini, kontraksi menjadi lebih kuat, lebih teratur, dan intens. Pengelolaan yang tepat sangat penting untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi serta mendukung proses persalinan yang fisiologis.

1. Tujuan Pengelolaan Fase Aktif

- a. Memastikan kemajuan persalinan berjalan sesuai dengan norma fisiologis.
- b. Mendukung kenyamanan ibu selama kontraksi yang semakin intens.
- c. Mendeteksi dini komplikasi ibu atau janin.

2. Pengelolaan Fase Aktif

Pengelolaan pada fase aktif bertujuan mendukung progres persalinan secara fisiologis dengan pemantauan ketat dan dukungan penuh (Herni, 2021).

a. Pemantauan Progres Persalinan

1) Pemeriksaan Dalam

Lakukan pemeriksaan setiap 4 jam untuk mengevaluasi pembukaan serviks dan posisi janin, pembukaan serviks bertambah sekitar 1 cm/jam pada primigravida, lebih cepat pada multigravida.

2) Pantau Kontraksi, frekuensi, durasi, dan intensitas kontraksi.

3) Pantau Janin, dengarkan denyut jantung janin (DJJ) setiap 15-30 menit menggunakan Doppler atau CTG, denyut jantung janin normal antara 110-160 kali/menit.

b. Dukungan Psikologis

1) Berikan dukungan emosional kepada ibu, termasuk dorongan dari pendamping persalinan.

2) Pastikan ibu merasa aman dan nyaman di lingkungan persalinan.

c. Manajemen Nyeri

1) Non-Farmakologis

a) Pijat punggung bawah.

b) Posisi yang nyaman untuk ibu (jongkok, duduk, atau berdiri).

c) Teknik pernapasan terkontrol (pernapasan dalam saat kontraksi).

d) Penggunaan bola yoga atau mandi air hangat.

2) Farmakologis (Jika Diperlukan)

Analgesia epidural dapat dipertimbangkan atas permintaan ibu atau jika rasa nyeri sangat intens.

d. Nutrisi dan Hidrasi

- 1) Jika belum ada kontraindikasi, ibu dapat diberi makanan ringan dan cairan untuk menjaga energi dan hidrasi.
- 2) Jika ibu tidak dapat makan, pertimbangkan pemberian cairan intravena(Kunang & Sulistianingsih, 2023).

e. Posisi Aktif

- 1) Dorong ibu untuk tetap aktif selama fase aktif, seperti berjalan atau bergerak.
- 2) Hindari posisi terlentang untuk mengurangi tekanan pada vena cava.

f. Intervensi Minimal

- 1) Hindari intervensi medis kecuali ada indikasi.
- 2) Pecah ketuban buatan (amniotomi) dapat dilakukan jika progres persalinan lambat dan kepala janin sudah masuk panggul dengan baik.

3. Indikasi Intervensi atau Rujukan

a. Rujukan atau intervensi diperlukan jika ditemukan

Progres Lambat atau Tidak Ada Kemajuan, yang artinya tidak ada pembukaan serviks dalam 2 jam berturut-turut.

b. Tanda Gawat Janin

Denyut jantung janin abnormal (<110 atau >160 kali/menit) dan mekonium kental pada cairan ketuban.

c. Komplikasi Maternal

Adanya peningkatan tekanan darah yang signifikan dan ketuban pecah dini dengan tanda infeksi (demam, cairan berbau)(Huru et al., 2022).

Pengelolaan fase aktif persalinan normal melibatkan pemantauan ketat terhadap ibu dan janin, dukungan penuh untuk kenyamanan ibu, serta deteksi dini komplikasi. Intervensi medis hanya dilakukan jika ada indikasi, dengan tujuan mendukung proses persalinan alami dan memastikan keselamatan ibu dan bayi(Wahyuni et al., 2023) .

E. Pengelolaan atau intervensi pada Fase Ekspulsi dalam persalinan Normal

Fase ekspulsi adalah tahap kedua persalinan, dimulai setelah pembukaan serviks mencapai 10 cm dan diakhiri dengan lahirnya bayi. Pada fase ini, ibu melakukan usaha mengejan untuk membantu bayi keluar melalui jalan lahir. Pengelolaan yang tepat sangat penting untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi serta mengurangi risiko komplikasi.

1. Tujuan Pengelolaan Fase Ekspulsi

- a. Mendukung ibu dalam mengejan secara efektif.
- b. Mengoptimalkan kelahiran bayi secara fisiologis.
- c. Mencegah trauma pada ibu (robekan perineum) dan bayi.
- d. Mendeteksi dini tanda-tanda komplikasi.

2. Pengelolaan Fase Ekspulsi

Pengelolaan fase ekspulsi berfokus pada mendukung ibu secara fisik dan emosional, memastikan progres kelahiran bayi berjalan lancar, serta mencegah komplikasi.

a. Dukungan Psikologis dan Fisik

- 1) Berikan dukungan emosional dan dorongan kepada ibu untuk meningkatkan rasa percaya diri.
- 2) Pastikan pendamping persalinan (suami atau keluarga) hadir untuk memberikan dukungan.

b. Bimbingan Mengejan

- 1) Anjurkan ibu untuk mengejan hanya saat kontraksi berlangsung untuk menghemat energi.
- 2) Berikan instruksi teknik mengejan yang efektif
 - a) Tarik napas panjang sebelum mengejan.
 - b) Fokuskan tenaga ke bawah, seperti saat buang air besar.
 - c) Gunakan teknik pernapasan terkontrol di antara kontraksi untuk mengurangi kelelahan.

c. Posisi Persalinan

Berikan kebebasan kepada ibu untuk memilih posisi yang nyaman, seperti

- 1) Posisi setengah duduk.
- 2) Jongkok.
- 3) Berbaring miring (lateral).
- 4) Berlutut dengan tubuh condong ke depan (Justian, 2022).

d. Pemantauan Progres

- 1) Pantau Denyut Jantung Janin (DJJ), setiap 5 menit atau setelah setiap kontraksi. DJJ normal 110-160 kali/menit.
- 2) Pantau Progres Kepala Janin, observasi setiap kontraksi untuk memastikan kemajuan kelahiran.

e. Perlindungan Perineum

Gunakan teknik perlindungan perineum untuk mengurangi risiko robekan:

- 1) Counter-pressure, dengan cara tekan lembut kepala janin dengan tangan untuk mengontrol kelahiran.

- 2) Teknik perlahan yaitu dengan menganjurkan ibu untuk bernapas cepat saat kepala janin crowning untuk mencegah kelahiran terlalu cepat.
- f. Penanganan Kepala dan Tubuh Bayi
 Saat kepala janin keluar:
 - 1) Pastikan tidak ada lilitan tali pusat di leher.
 - 2) Jika ada lilitan tali pusat, longgarkan atau lepaskan dengan hati-hati.
 - 3) Bimbing bahu bayi keluar secara lembut tanpa menarik kepala.

3. Komplikasi yang Mungkin Terjadi dan Penanganannya

- a. Distosia Bahu (Shoulder Dystocia), Lakukan manuver McRoberts atau tekanan suprapubik jika bahu bayi tersangkut.
- b. Tali Pusat Melilit, lepaskan lilitan secara lembut sebelum tubuh bayi lahir.
- c. Gawat Janin, jika denyut jantung janin abnormal, percepat kelahiran dengan bantuan alat seperti vakum atau forceps jika diperlukan (Olii & Rasyid, 2021).

4. Indikasi Rujukan

- a. Proses fase ekspulsi berlangsung lebih dari 2 jam tanpa progres signifikan.
- b. Denyut jantung janin abnormal (<110 atau >160 kali/menit).
- c. Tali pusat melilit yang tidak dapat dilepaskan secara manual.

Pengelolaan fase ekspulsi persalinan normal melibatkan bimbingan mengejan yang efektif, pemilihan posisi yang nyaman, serta pemantauan ketat terhadap ibu dan janin. Pendekatan yang tepat dapat meminimalkan risiko komplikasi dan memastikan proses persalinan berjalan fisiologis dengan aman bagi ibu dan bayi (Nasution & Purwanti, 2024).

F. Referensi

- Herni, K. (2021). PENGARUH SQUATTING POSITION TERHADAP DURASI KALA II PADA PERSALINAN. *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung*, 13(2), 525–530.
- Huru, M. M., Boimau, S., Yulianti, H., & Boimau, A. (2022). Pemberdayaan Kader Posyandu dalam Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 6(16), 4714–4724.
- Indryani. (2024). *Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. SALNESIA.
- Justian, D. (2022). *Penerapan Tindakan Posisi Persalinan*. PT. Nasya Expanding Management.
- K, P. A., & Cholifah. (2019). *Buku Ajar Konsep Dasar Persalinan*. UMSIDA Press.
- Kunang, A., & Sulistianingsih, A. (2023). *Buku Ajar Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir dengan Evidence Based Midwifery*. Eureka Media Aksara.
- Lestari, R. M., Septiyaningsih, R., Sukandar, D. A., A.Seran, A., Murni, N. N. A., Komariyah, S., & Hafsah. (2024). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan*.

Persalinan. PT Nuansa Fajar Cemerlang.

- Marsilia, I. D., & Tresnayanti, N. (2021). Pengaruh Teknik Relaksasi Nafas Dalam terhadap Intensitas Nyeri pada Persalinan Kala I Fase Aktif di PMB Y Karawang. *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi*, 10(2), 385–393. <https://doi.org/10.36565/jab.v10i2.388>
- Nasution, W. M., & Purwanti, M. (2024). *Asuhan Persalinan Normal*. UMSU Press.
- Olii, N., & Rasyid, P. S. (2021). *Perencanaan Persalinan Terstandar & Pencegahan Komplikasi*. Penerbit NEM.
- Putri, P. D. A., Thamrin, H., & M, A. (2022). Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny. K dengan Kala I Fase Laten. *Window of Midwifery Journal*, 03(02), 125–135. <https://doi.org/10.33096/wom.vi.444>
- Siregar, S., Batubara, N. S., & Siregar, R. D. (2023). Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Primigravida Tentang Nyeri Persalinan Kala I. *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia*, 8(1), 170–176. <https://doi.org/10.51933/health.v8i1.1041>
- Subagio, S. U. (2022). Efektivitas Birth Ball Untuk Mengurangi Nyeri Persalinan Pada Ibu Bersalin Ny.Y Kala I Fase Aktif Di Klinik Mahabbah Prima Medika Kota Serang. *Journal Of Midwifery*, 10(1), 65–70. <https://doi.org/10.37676/jm.v10i1.2321>
- Wahyuni, S., Setyorini, D., Arisani, G., Nuraina, Sukriani, W., Meyasa, L., Pekabanda, K., H, A. R., Legawati, Rosdiana, Nara, A., Lailiyah, S. R., Sukartiningsih, M. E., & Sopiatus, S. (2023). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. CV. Science Techno Direct.
- Yulizawati, Insani, A. A., Sinta, L. El, & Andriani, F. (2019). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Persalinan*. Indomedia Pustaka.
- Zaharoh, A., NA, F. H., & Yanti, L. (2021). Teknik Counter Pressure untuk Mengurangi Nyeri Persalinan Kala 1 Fase Aktif. *Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1009–1013.

CHAPTER 3

KOMPLIKASI YANG MUNGKIN TERJADI SELAMA PERSALINAN NORMAL

Umu Qonitun, S.ST., M.Keb., M.M.

A. Pendahuluan/Prolog

Persalinan normal adalah proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar yang terjadi pada kehamilan yang cukup bulan (37–42 minggu) dengan ditandai adanya kontraksi uterus yang menyebabkan terjadinya penipisan, dilatasi serviks, dan mendorong janin keluar melalui jalan lahir dengan presentase belakang kepala tanpa alat atau bantuan (lahir spontan) serta tidak ada komplikasi pada ibu dan janin (Eka Puspita, 2014).

Penyebab terjadinya kematian bayi dan balita serta berbagai komplikasi yang tinggi pada masa neonatus, sebagian besar disebabkan karena gangguan pernapasan dan prematuritas. Prematuritas atau persalinan preterm adalah persalinan yang terjadi pada kehamilan 20 sampai 36 minggu. Mekanisme terjadinya persalinan preterm dimulai dengan adanya kontraksi uterus dan dilatasi serviks serta ketuban pecah, kejadian ini sebagai keadaan patologis (Nur Mukmin, 2016).

Angka kejadian persalinan preterm pada umumnya adalah sekitar 6-10%. Hanya 1,5% persalinan terjadi pada umur kehamilan kurang dari 32 minggu dan 0,5% pada kehamilan kurang dari 28 minggu. Secara biologis, mekanisme persalinan preterm disebabkan oleh hipoksia, stress oksidatif, dan infeksi maternal. Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization) menyatakan bahwa bayi premature adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan 37 minggu atau kurang. Adapun faktor penyebab langsung kematian ibu adalah perdarahan 40-60%, preeklampsia 20-30%, infeksi 20-30% serta kejadian ketuban pecah dini (KPD) yang tidak segera mendapatkan penanganan sehingga KPD menjadi masalah yang serius yang dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas perinatal serta menyebabkan infeksi pada ibu (Zainal Alim, Yeni Agus Safitri, 2016)

B. Komplikasi Pada Persalinan Normal

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin atau uri) yang telah cukup bulan (37-42 minggu) atau hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, dengan bantuan atau tanpa bantuan dengan presentasi

belakang kepala yang berlangsung dalam waktu 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Persalinan adalah proses alami yang akan berlangsung dengan sendirinya, tetapi persalinan pada manusia setiap saat terancam penyulit yang membahayakan ibu maupun janinnya sehingga memerlukan pengawasan, pertolongan, dan pelayanan dengan fasilitas yang memadai.

Persalinan berlangsung secara alamiah, tetapi tetap diperlukan pemantauan khusus karena setiap ibu memiliki kondisi kesehatan yang berbeda-beda, sehingga dapat mengurangi risiko kematian ibu dan janin pada saat persalinan. Selain itu, selama kehamilan ataupun persalinan dapat terjadi komplikasi karena kesalahan penolong dalam persalinan, baik tenaga non-kesehatan seperti dukun ataupun tenaga kesehatan khususnya bidan (Wahyuni, 2014).

Komplikasi yang mungkin terjadi selama persalinan normal dapat beragam, dan penting untuk mengenali kondisi-kondisi ini agar dapat ditangani dengan tepat. Berikut adalah beberapa komplikasi umum yang dapat terjadi:

1. Partus Lama

Partus lama merupakan proses kompleks yaitu ketika peristiwa psikologis dan fisiologis saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Sebagian ibu mengalami persalinan yang lebih lama dibandingkan dengan ibu – ibu yang lain. Beberapa persalinan berlangsung lambat karena ukuran janin yang besar dan letaknya yang tidak lazim. Partus lama adalah persalinan yang berlangsung lebih dari 24 jam pada primigravida, dan lebih dari 18 jam pada multigravida. Bila kemajuan persalinan tidak berlangsung baik selama periode itu, situasi tersebut harus segera dinilai, permasalahannya harus dikenali dan diatasi sebelum waktu 24 jam.

Secara umum, persalinan yang abnormal terjadi apabila terdapat permasalahan disproporsi antara bagian presentasi janin dan jalan lahir. Partus lama juga merupakan perlambatan kecepatan dilatasi serviks atau penurunan janin.

Hendricks et al melakukan observasi perubahan serviks pada 303 ibu hamil selama empat minggu, melaporkan bahwa rata – rata perubahan serviks 1,8 cm pada nulipara dan 2,2 cm pada multipara dengan 60% - 70% terjadi *effacement* pada beberapa hari sebelum persalinan terjadi.

Partus lama terjadi karena abnormalitas dari dilatasi serviks. Pembukaan serviks berlangsung lambat, karena tidak terjadinya penurunan kepala untuk menekan serviks tersebut. Pada saat yang sama terjadi edema pada serviks sehingga akan lebih sulit terjadi dilatasi serviks, hal ini dapat menyebabkan

meningkatnya tindakan *sectio secarea*.

Beberapa faktor yang berhubungan dengan partus lama antara lain:

a. Disproporsi Sefalopelvik

Merupakan kondisi dimana jika kepala bayi lebih besar dari pelvis, hal ini menjadi penyebab janin kesulitan melewati pelvis. Disproporsi sefalopelvik juga bisa terjadi akibat pelvis sempit dengan ukuran kepala janin normal, atau pelvis normal dengan janin besar, atau kombinasi antara bayi besar dan pelvis sempit

b. Malpresentasi dan malposisi

Mal presentasi adalah bagian terendah janin yang berada disegmen bawah rahim bukan belakang kepala. Sedangkan malposisi adalah penunjuk (presenting part) tidak berada di anterior. Dalam keadaan normal presentasi janin adalah belakang kepala dengan penunjuk ubun-ubun kecil dalam posisi transversal (saat masuk PAP), dan posisi anterior (setelah melewati PAP) dengan presentasi tersebut, kepala janin akan masuk panggul dalam ukuran terkecilnya. Sikap yang tidak normal akan menimbulkan mal presentasi pada janin dan kesulitan persalinan. Sikap ekstensi ringan akan menjadikan presentasi puncak kepala (dengan penunjuk ubun-ubun besar), ekstensi sedang menjadikan presentasi dahi (dengan penunjuk sinsiput), dan ekstensi maksimal menjadikan presentasi muka (dengan penunjuk dagu). Apabila janin dalam keadaan malpresentasi dan malposisi maka dapat terjadi persalinan yang lama atau bahkan macet. Pada penelitian yang dilakukan oleh Evy Soviyati menyatakan bahwa terdapat 65,4% ibu mengalami lama persalinan lebih dari 18 jam dengan malposisi sedangkan 60,7% ibu mengalami lama persalinan lebih dari 18 jam mengalami posisi normal. analisis Odd Ratio sebesar 1,2 artinya ibu yang mengalami malposisi saat bersalin beresiko 1,2 kali lebih besar mengalami partus lama.

c. Kerja uterus yang tidak efisien

Disfungsi uterus mencakup kerja uterus yang tidak terkoordinasikan, inersia uteri, dan ketidakmampuan dilatasi serviks menyebabkan partus menjadi lama dan kemajuan persalinan mungkin terhenti sama sekali. Keadaan ini sering sekali disertai disproporsi dan malpresentasi

d. Primigraviditas

Pada primigravida lama rata-rata fase laten adalah 8 jam, dengan batas normal sebelah atas pada 20 jam. Sedangkan fase aktif pada primigravida lebih dari 12 jam merupakan keadaan abnormal. Hal yang lebih penting dari fase ini adalah kecepatan dilatasi serviks. Laju yang kurang dari 1,2 cm per jam membuktikan adanya abnormalitas dan harus menimbulkan kewaspadaan

dokter yang akan menolong persalinan tersebut.

e. Ketuban pecah dini

Pecahnya ketuban dengan adanya serviks yang matang dan kontraksi yang kuat tidak pernah memperpanjang waktu persalinan, akan tetapi bila kantong ketuban pecah pada saat serviks masih keras, dan menutup maka sering terjadi periode laten yang lama, hal ini dikarenakan oleh ukuran Pintu Atas Panggul (PAP) yang sempit sehingga berpengaruh terhadap persalinan yaitu pembukaan serviks menjadi lambat dan seringkali tidak lengkap serta menyebabkan kerja uterus tidak efisien. Ketidakmampuan serviks untuk membuka secara lancar dan cepat serta kontraksi rahim yang tidak efisien inilah dapat menyebabkan terjadinya partus lama

2. Distosia Bahu

Distosia bahu adalah kondisi persalinan di mana bahu bayi gagal dilahirkan secara spontan setelah kepala lahir. Penyebab utama distosia bahu adalah ukuran bayi yang lebih besar daripada ukuran panggul ibu atau yang sering disebut *cephalopelvic disproportion* (CPD), ukuran diameter panggul ibu yang kecil, dan malpresentasi janin

Distosia bahu merupakan salah satu bentuk [distosia](#) (persalinan macet), yang termasuk dalam kegawatdaruratan obstetri sehingga dibutuhkan keterampilan dan kemampuan teknik persalinan yang tepat untuk menghindari komplikasi yang terjadi. Diagnosis distosia bahu berdasarkan tubuh bayi yang tidak kunjung lahir setelah kepala lahir, meskipun kontraksi uterus baik. Selain itu, ada *turtle sign* atau kepala bayi tertarik masuk kembali ke perineum setelah keluar dari vagina, disertai pipi bayi yang menonjol keluar. Faktor risiko distosia bahu yang harus diwaspadai di antaranya riwayat diabetes melitus pada ibu hamil, riwayat melahirkan bayi makrosomia (>4.000 gram), riwayat distosia bahu pada persalinan sebelumnya, dan [obesitas](#)

Penatalaksanaan yang tepat dan cepat sangat dibutuhkan dalam distosia bahu. Hal ini untuk mencegah timbulnya komplikasi bahkan kematian, baik pada bayi maupun ibu. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara dokter kandungan dan bidan dalam melakukan berbagai tindakan dan manuver untuk menolong persalinan dengan distosia bahu.

3. Asfiksia

Asfiksia Neonatorum adalah keadaan bayi tidak bernafas secara spontan dan teratur segera setelah lahir, seringkali bayi yang sebelumnya mengalami gawat janin akan mengalami Asfiksia sesudah persalinan. Gangguan ini mungkin berkaitan dengan keadaan ibu, tali pusat atau masalah pada bayi selama atau sesudah persalinan. Asfiksia Neonatorum merupakan salah satu sindrom distres

pernapasan dimana terjadi kegagalan napas pada bayi baru lahir. Asfiksia terjadi karena kurangnya aliran darah ataupun pertukaran gas dari atau ke janin pada bayi baru lahir. Jika keadaan ini tidak ditangani secara cepat dan tepat maka dapat menyebabkan kerusakan organ vital (otot, hati, jantung, dan paling parah otak).

Penyebab

1. Faktor ibu

- a. Preeklampsia dan eklampsia
- b. Perdarahan abnormal (*Plasenta Previa, Solutio Plasenta*)
- c. Partus lama
- d. Demam selama persalinan
- e. Mengalami infeksi berat kehamilan *post matur*
- f. Usia ibu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun
- g. Gravida empat atau lebih

2. Faktor bayi

- a. Bayi prematur
- b. Persalinan sulit
- c. Kelainan kongenital
- d. Air ketuban bercampur mekonium

3. Faktor tali pusat

- a. Lilitan tali pusat
- b. Tali pusat pendek
- c. Simpul tali pusat
- d. Prolapsus tali pusat

Faktor Risiko

1. Preeklampsia
2. Cairan ketuban terdapat mekonium
3. Persalinan lama lebih dari 24 jam
4. Gawat janin
5. Perdarahan selama kehamilan
6. Berat badan lahir rendah
7. Kelahiran prematur
8. Persalinan secara operasi *caesar*
9. Persalinan menggunakan alat bantu
10. *Diabetes Mellitus Gestasional*

Tanda dan Gejala

1. Asfiksia ringan

- a. *Takipnea* dengan nafas lebih dari 60 kali per menit

- b. Bayi tampak *Sianosis*
- c. Adanya retraksi sela iga
- d. Bayi merintih
- e. Bayi kurang aktivitas

2. Asfiksia sedang

- a. Frekuensi jantung menurun menjadi 60- 80 kali per menit
- b. Usaha nafas lambat
- c. Tonus otot biasanya dalam keadaan baik
- d. Bayi masih bisa bereaksi terhadap rangsangan yang diberikan
- e. Bayi tampak *Sianosis*
- f. Tidak terjadi kekurangan oksigen yang bermakna selama proses persalinan

3. Asfiksia berat

- a. Frekuensi jantung kecil yaitu kurang 40 kali per menit
- b. Tidak ada usaha nafas
- c. Tonus otot lemah bahkan hamper tidak ada
- d. Bayi tidak dapat memberikan reaksi jika diberikan rangsangan
- e. Bayi tampak pucat bahkan sampai berwarna kelabu
- f. Terjadi kekurangan oksigen yang berlanjut sebelum atau sesudah persalinan

Penanganan Asfiksia

1. Memberitahu ibu dan keluarga bahwa kondisi bayinya yang tidak menangis spontan saat lahir.
2. Melakukan tindakan penanganan Asfiksia yaitu resusitasi.
3. Melakukan asuhan pasca resusitasi.
4. Memberikan injeksi vitamin K.
5. Menghangatkan bayi, memakaikan pakaian bayi, bedong bayi, serta topi kemudian memasukkan bayi ke dalam *incubator*.
6. Menjelaskan pada ibu dan keluarga bahwa bayinya dalam kondisi baik namun belum bisa di rawat gabung karena bayi perlu dipantau lebih lanjut.
7. Melakukan observasi tanda-tanda vital bayi setiap 1 jam.
8. Mengganti pakaian, popok bayi setiap kali kotor dan basah.

Pencegahan

Tidak semua kejadian Asfiksia Neonatorum dapat dicegah. Ibu hamil disarankan untuk melakukan kontrol secara teratur ke dokter kandungan. Kontrol teratur bisa membantu memastikan kondisi kehamilan dan kesehatan janin dalam kondisi baik. Dengan demikian risiko bayi mengalami Asfiksia Neonatorum dapat menurun.

1. Perdarahan

Perdarahan postpartum atau perdarahan pasca persalinan adalah

keluarnya darah dari jalan lahir segera setelah melahirkan. Perdarahan setelah melahirkan dengan jumlah wajar merupakan hal yang normal terjadi dan hal ini disebut *lochea* atau nifas. Namun, kondisi ini bisa menjadi kondisi yang perlu dikhawatirkan ketika darah yang keluar sangat banyak melebihi 500 cc dalam 24 jam setelah melahirkan

Penyebab Perdarahan Postpartum :

a. Tonus / Kekuatan Otot

Keadaan ketika uterus tidak dapat berkontraksi atau disebut atonia uteri yang menyebabkan darah yang keluar dari uterus tidak dapat berhenti secara alamiah. Ini bisa memicu volume darah yang keluar semakin banyak sehingga harus segera mendapatkan penanganan

b. Trauma / Cedera

Bisa terjadi karena adanya robekan jalan lahir karena bayi terlalu besar, atau karena penggunaan obat pacu persalinan yang tidak sesuai dengan aturan dapat menyebabkan kontraksi terlalu kuat sehingga robeknya jalan lahir

c. Keberadaan Jaringan

Sisa jaringan plasenta yang masih menempel pada uterus dapat menyebabkan sumber perdarahan dari jalan lahir

d. Faktor Pembekuan Darah

Perdarahan yang sangat banyak dapat menyebabkan hilangnya faktor-faktor yang dibutuhkan darah untuk membantu penutupan luka. Selain itu, pengidap hemofilia, yaitu ketika darah sukar membeku, juga bisa menyebabkan kelainan perdarahan pasca melahirkan

C. Simpulan

Komplikasi persalinan merupakan penyebab utama kematian ibu yang tinggi di Indonesia. Upaya strategis untuk mencegah komplikasi persalinan adalah antenatal care.

Komplikasi kehamilan dan persalinan merupakan gangguan kesehatan yang dapat

dialami oleh ibu selama kehamilan dan persalinan (BKKBN et al., 2018). Komplikasi

tersebut dapat berdampak pada kesehatan ibu maupun janin atau bayi baru lahir (BKKBN et al., 2018). Tingginya komplikasi persalinan menyumbang angka kematian ibu dan bayi, terutama di negara-negara dengan pendapatan menengah-ke bawah. Di Indonesia sendiri, angka kematian ibu pada tahun 2017 sebanyak 177 per kelahiran hidup (The World Bank, 2019), lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata di seluruh Asia Tenggara (152 per 100.000

kelahiran hidup) (World Health Organization, 2020).

Upaya strategis untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi, deteksi dini dan mencegah komplikasi dan kematian adalah Antenatal Care (ANC) (World Health Organization, 2016). Antenatal care terus digalakkan di Indonesia sebagai strategi utama untuk mengupayakan tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) ketiga mengenai penjaminan kesehatan semua kalangan, terutama kesehatan ibu dan bayi. Antenatal care dilaksanakan agar dapat meningkatkan kesehatan ibu dan janin selama kehamilan dan mendeteksi serta mencegah komplikasi yang dapat terjadi saat kehamilan dan persalinan, bahkan hingga masa nifas.

D. Referensi

- Akbar, H. Prabowo, AY. Rodiani. Kehamilan Aterm dengan Distosia Bahu. *Medula*. 2017; 7(4): 1-7.
- BKKBN, BPS, Kemenkes, & USAID. (2018). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017*
- Dhamayanti Mutia. 2018. *Hubungan Preeklampsia dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum pada Bayi Baru Lahir di RSUD Wonosari Tahun 2017*. Skripsi Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta.
- Hamidi Septiani Meri. 2018. *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum di Ruang Perinatologi RSUD DR. M Yunus Bengkulu Tahun 2018*. Skripsi Prodi DIV Kebidanan Bengkulu Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Miarnasari, E. Prijatna, A. Shoulder Dystocia. *CME FK UMS*. 2022: 252-264
- World Health Organization. (2020). *World Health Statistics 2020: A Visual Summary*. World Health Organization. <https://www.who.int/data/gho/whs-2020-visual-summary>

E. Glosarium

sectio secarea : tindakan pembedahan untuk mengeluarkan bayi dari rahim ibu dengan membuat sayatan pada dinding perut dan rahim

CHAPTER 4

PEMULIHAN PASCA PERSALINAN: PENANGANAN LUKA EPISIOTOMI DAN PERAWATAN VAGINA

Anisah Tifani Maulidyanti, S.Tr.Keb., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Siklus kehidupan perempuan dipengaruhi oleh kesehatan reproduksinya, baik kehamilan, persalinan dan nifas, oleh karena itu diperlukan kepedulian serta kemauan untuk tetap sehat dan sejahtera. Sekitar 830 wanita meninggal karena komplikasi kehamilan dan persalinan dengan angka 99% terjadi di negara berkembang. Hampir 75% dari semua kematian ibu yang terjadi akibat perdarahan hebat setelah melahirkan, infeksi, tekanan darah tinggi selama kehamilan (pre-eklampsia dan eklampsia), komplikasi dari persalinan, dan aborsi yang tidak aman (Sudayasa, Rusli, & Mubarak, 2022).

Pemulihan pasca persalinan adalah proses yang berlangsung setelah seorang ibu melahirkan, di mana tubuhnya mulai kembali ke kondisi sebelum hamil. Periode ini dikenal sebagai masa nifas (puerperium) dan biasanya berlangsung sekitar enam minggu. Pemulihan pasca persalinan mencakup aspek fisik, psikologis, dan emosional yang sangat penting untuk mendukung kesejahteraan ibu dan bayi (Yohana Sitorus, Martini, & Mahanani Mulyaningrum, 2023).

Pasca Persalinan merupakan masa kritis dimana terjadi serangkaian perubahan pada ibu yang berdampak pada fisik, psikis dan sosial. Ketidaknyamanan yang biasa terjadi selama pasca persalinan adalah sembelit, infeksi luka perineum, sakit kepala, ketidaknyamanan saat buang air kecil, kelelahan, puting susu lecet, bendungan air susu ibu (ASI), perdarahan pasca persalinan, kecemasan dan depresi pada pasca persalinan. Sebagian besar kematian ibu terjadi pada 24 jam pasca persalinan, sehingga menjadi masa kritis dalam kehidupan ibu. World Health Organization (WHO) menyarankan bahwa setelah persalinan, ibu dan bayi harus mendapat perawatan 6-8 jam pasca persalinan, enam hari pasca persalinan, dua minggu pasca persalinan, dan enam minggu pasca persalinan untuk memastikan kesejahteraan fisik serta mental ibu dan bayi (Wijaya, Limbong, & Yulianti, 2023).

Untuk mengoptimalkan kesehatan ibu dan bayi, perawatan pasca persalinan harus menjadi proses yang berkelanjutan, dengan perawatan dan dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap ibu Pasca Persalinan sehingga asuhan yang

diberikan bisa membantu ibu melalui masa nifasnya. Penilaian awal ini harus ditindaklanjuti dengan perawatan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan ibu, kunjungan pasca persalinan yang komprehensif harus mencakup penilaian kesejahteraan fisik, sosial, psikologis, teknik menyusui, keluarga berencana, nutrisi, imunisasi, perawatan perineum, efek kesehatan dari pemberian makan bayi, faktor resiko kesulitan dalam pemberian laktasi, dan tumbuh kembang anak. Dalam mengoptimalkan perawatan dan dukungan untuk keluarga pasca melahirkan akan membutuhkan perubahan kebijakan. Perubahan dalam ruang lingkup perawatan pasca persalinan harus difasilitasi oleh kebijakan yang mendukung perawatan pasca persalinan sebagai proses yang berkelanjutan (Nursyafitri & Syahda, 2023).

Perawatan pasca persalinan merupakan waktu yang penting bagi ibu dan keluarga. Perawatan pasca persalinan awalnya harus berfokus pada kebutuhan dan resiko morbiditas dan mortalitas kemudian beralih ke pemeliharaan kesehatan Ibu yang didiagnosis diabetes saat hamil harus menjalani tes glukosa oral puasa 75 gram pasca persalinan. Karena ibu hamil dengan riwayat diabetes memiliki resiko lebih tinggi dan bisa mengidap diabetes seumur hidup. Jika ibu dengan diabetes hamil lagi, maka kehamilan itu bisa beresiko mengalami komplikasi kehamilan yang berbahaya bagi ibu dan janin. Ibu dengan gangguan hipertensi kehamilan harus melakukan pemeriksaan tekanan darah dalam rutin selama tiga bulan setelah persalinan. Karena diharapkan tidak ada hipertensi pasca persalinan, karena diagnosis akan menjadi hipertensi kronis. Kematian ibu yang didefinisikan sebagai kematian yang terjadi selama kehamilan dan 42 hari pasca persalinan. Kunjungan pasca persalinan dini harus mengevaluasi komplikasi dari kehamilan serta komplikasi pada masa nifas (Nursyafitri & Syahda, 2023).

Pasca persalinan merupakan waktu yang rentan untuk mendukung ibu dan bayi karena sering menghadapi kebutuhan utama yang tidak terpenuhi. Pada awal pasca persalinan, mereka merasakan kurangnya pemeriksaan dan dukungan kesehatan mental. Ibu masih merasa tidak mampu untuk memberikan perawatan kepada anak. Menurut WHO, mortalitas dan morbiditas menjadi perhatian utama, karena sebagian besar kematian dan kesakitan ibu dapat dicegah selama satu minggu pertama pasca persalinan. Sebanyak 45% kematian ibu pasca persalinan terjadi dalam 24 jam pertama, dan 66% terjadi pada minggu pertama pasca persalinan. Mengingat tingginya angka kematian ibu pada masa nifas, penting untuk mengembangkan tindakan yang efisien untuk memenuhi kebutuhan ibu pada masa nifas (Wijaya et al., 2023).

B. Perubahan-Perubahan Yang Terjadi Pasca Persalinan (Puerperium)

1. Perubahan sistem reproduksi

Perubahan pada sistem reproduksi secara keseluruhan disebut proses involusi, disamping itu juga terjadi perubahan-perubahan penting lain yaitu terjadinya hemokonsentrasi dan timbulnya laktasi. Organ dalam system reproduksi yang mengalami perubahan yaitu:

a. Uterus

Uterus adalah organ yang mengalami banyak perubahan besar. Pada masa pasca persalinan uterus mengalami involusi. Involusi atau pengerutan uterus merupakan suatu proses dimana uterus kembali ke kondisi sebelum hamil dengan berat sekitar 60 gram.

Uterus hamil (diluar berat bayi, plasenta, cairan dll) memiliki berat sekitar 1000 gram. Setelah 6 minggu pascapersalinan, beratnya akan berkurang hingga mendekati ukuran sebelum hamil yaitu sekitar 50-100 gram. Segera setelah melahirkan, fundus uterine akan teraba setinggi umbilikus. Setelah itu, mengecilnya uterus terutama terjadi pada 2 minggu pertama pascapersalinan, dimana pada saat itu uterus akan masuk ke dalam rongga pelvis. Pada beberapa minggu setelah itu, uterus perlahan-lahan akan kembali ke ukurannya sebelum hamil, meskipun secara keseluruhan ukuran uterus tetap akan sedikit lebih besar sebelum hamil.

Lapisan endometrium akan mengalami regenerasi dengan cepat, sehingga pada hari ke-7 kelenjar endometrium sudah mulai ada. Pada hari ke-16. lapisan endometrium telah pulih di seluruh uterus kecuali di tempat implantasi plasenta.

b. Vulva dan Vagina

Pada sekitar minggu ketiga, vagina mengecil dan timbul rugae kembali. Vagina yang semula sangat teregang akan kembali secara bertahap seperti ukuran sebelum hamil pada minggu ke 6-8 setelah melahirkan. Rugae akan terlihat kembali pada minggu ke 3 atau ke 4.

c. Perineum

Jalan lahir mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan bayi, sehingga menyebabkan mengendurnya organ ini bahkan robekan yang memerlukan penjahitan, namun akan pulih setelah 2-3 minggu.

d. Perubahan Payudara

Persiapan payudara untuk siap menyusui terjadi sejak awal kehamilan. Laktogenesis sudah terjadi sejak usia kehamilan 16 minggu. Pada saat itu

plasenta menghasilkan hormon progesteron dalam jumlah besar yang akan mengaktifkan sel-sel alveolar matur di payudara yang dapat mensekresikan susu dalam jumlah kecil. Setelah plasenta lahir, terjadi penurunan kadar progesteron yang tajam yang kemudian akan memicu mulainya produksi air susu disertai dengan pembengkakan dan pembesaran payudara pada periode post partum.

Proses produksi air susu sendiri membutuhkan suatu mekanisme kompleks. Pengeluaran yang reguler dari air susu (pengosongan air susu) akan memicu sekresi prolaktin. Penghisapan puting susu akan memicu pelepasan oksitosin yang menyebabkan sel-sel mioepitel payudara berkontraksi dan akan mendorong air susu terkumpul di rongga alveolar untuk kemudian menuju duktus laktoferus. Jika ibu tidak menyusui, maka pengeluaran air susu akan terhambat yg kemudian akan meningkatkan tekanan intramamae (Khasanah & Sulistyawati, 2017).

2. Perubahan Sistem Pencernaan

Ibu menjadi lapar dan siap untuk makan pada 1-2 jam setelah bersalin. Konstipasi dapat menjadi masalah pada awal puerperium akibat dari kurangnya makanan dan pengendalian diri terhadap BAB. Ibu dapat melakukan pengendalian terhadap BAB karena kurang pengetahuan dan kekhawatiran lukanya akan terbuka bila BAB.

3. Perubahan Sistem Perkemihan

Terjadi diuresis yang sangat banyak dalam hari-hari pertama puerperium. Pelebaran (dilatasi) dari pelvis renalis dan ureter akan kembali ke kondisi normal pada minggu ke dua sampai minggu ke 8 pasca persalinan.

4. Perubahan Sistem Hormonal

a. Hormon Plasenta

Pengeluaran plasenta menyebabkan penurunan hormon yang diproduksi plasenta. Hormon plasenta akan menurun dengan cepat pasca persalinan. Penurunan hormon plasenta (human placental lactogen) menyebabkan kadar gula darah menurun pada masa nifas. HCG menurun dengan cepat dan menetap sampai 10% dalam 3 jam hari ke 7 pasca persalinan dan sebagai onset pemenuhan payudara pada hari ke 3 pasca persalinan.

b. Hormon Hipofisis

Hormon pituitary antara lain hormon prolaktin, FSH dan LH. Hormon prolaktin darah meningkat dengan cepat, dan pada wanita yang tidak menyusui akan menurun dalam waktu 2 minggu. Hormon prolaktin berperan dalam pembesaran payudara untuk merangsang produksi susu. FSH dan LH meningkat pada fase konsetrasi folikuler pada minggu ke-3 dan LH tetap

rendah hingga ovulasi terjadi.

c. Hormon Hipotalamik pituitary ovarium

Hormon ini akan mempengaruhi lamanya mendapatkan menstruasi pada wanita menyusui maupun tidak menyusui. Pada wanita menyusui, 16% wanita akan mendapatkan menstruasi pada 6 minggu pasca persalinan, dan 45% wanita setelah 12 minggu pasca persalinan. Sedangkan pada wanita tidak menyusui, 40% wanita akan mendapatkan menstruasi pada 6 minggu pasca persalinan, serta 90% wanita setelah 24 minggu.

d. Hormon Oksitosin

Hormon oksitosin disekresikan dari kelenjar otak bagian belakang, bekerja terhadap otot uterus dan jaringan payudara. Selama kala tiga persalinan, hormon oksitosin berperan dalam pelepasan plasenta dan mempertahankan kontraksi, sehingga mencegah perdarahan. Isapan bayi dapat merangsang produksi ASI dan sekresi oksitosin sehingga dapat membantu involusi uteri.

e. Hormon estrogen dan progesterone

Volume darah normal selama kehamilan akan meningkat. Hormon estrogen yang tinggi memperbesar hormon antidiuretik yang dapat meningkatkan volume darah. Sedangkan hormon progesteron mempengaruhi otot halus yang mengurangi perangsangan dan peningkatan pembuluh darah. Hal ini mempengaruhi saluran kemih, ginjal, usus, dinding vena, dasar panggul, perineum, vulva serta vagina (Khasanah & Sulistyawati, 2017).

5. Perubahan Sistem Integumen

Perubahan kulit yang terjadi pada waktu hamil yaitu adanya hiperpigmentasi kulit pada beberapa tempat karena pengaruh faktor hormonal. Hiperpigmentasi ini berupa cloasma gravidarum pada pipi, hiperpigmentasi kulit sekitar payudara, hiperpigmentasi kulit pada dinding perut (striae gravidarum). Setelah persalinan, faktor hormonal berkurang dan hiperpigmentasi pun akan berangsur-angsur akan menghilang. Striae gravidarum pada dinding perut yang awalnya berwarna hitam akan berubah menjadi putih mengkilap yang disebut dengan striae albican (Khasanah & Sulistyawati, 2017).

C. Kebutuhan Dasar Ibu Pemulihan Pasca Persalinan

Ibu yang baru melahirkan atau kita sebut masa nifas memerlukan berbagai macam kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Kebutuhan seorang ibu pasca persalinan berbeda dengan kebutuhan seorang ibu pada saat masih dalam masa kehamilan. Bidan sebagai tenaga profesional yang memberikan asuhan pada ibu masa pasca persalinan dan menyusui, diharapkan dapat memahami kebutuhan ibu agar dapat memberikan asuhan berdasarkan kebutuhan ibu pasca persalinan dan

menyusui bukan berdasarkan keinginan pemberi atau penerima asuhan. Kebutuhan ibu masa pasca persalinan dan menyusui dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebutuhan cairan dan nutrisi

Nutrisi adalah zat yang diperlukan oleh tubuh untuk keperluan metabolisme tubuh. Kebutuhan gizi pada ibu pasca persalinan terutama bila menyusui akan meningkat 25% lebih banyak, karena hal tersebut berguna untuk proses kesembuhan ibu sehabis melahirkan dan juga untuk memproduksi air susu yang cukup dan berkualitas untuk menyehatkan bayi. Semua kebutuhan tersebut akan meningkat tiga kali dari kebutuhan yang biasa.

Wanita dewasa memerlukan 2.200 kilo kalori sedangkan Ibu menyusui memerlukan kalori yang sama dengan wanita dewasa ditambahkan 700 kilo kalori pada 6 bulan pertama lalu kemudian ditambahkan 500 kilo kalori pada bulan selanjutnya. Diet harus sangat mendapat perhatian dalam nifas karena makanan yang baik mempercepat penyembuhan ibu, dan sangat mempengaruhi susunan air susu.

2. Kebutuhan ambulasi dini

Yang dimaksud dengan ambulasi dini (early ambulation) ialah: Kebijakan untuk secepat mungkin membimbing penderita keluar tempat tidurnya dan membimbingnya secepat mungkin berjalan. Sekarang tidak perlu lagi menahan ibu postpartum terlentang di tempat tidurnya selama 7-14 hari setelah melahirkan. Ibu sudah diperbolehkan bangun dari tempat tidur dalam waktu kurang lebih 24-48 jam postpartum. Keuntungan dari ambulasi dini antara lain:

- a. Penderita merasa lebih sehat dan lebih kuat dengan early ambulation.
- b. Faal usus dan kandung kemih lebih baik.
- c. Early ambulation memungkinkan kita mengajar ibu memelihara anaknya; memandikan, mengganti pakaian, memberi makan, dll. selama ibu masih di rumah sakit.
- d. Lebih sesuai dengan keadaan Indonesia (sosial ekonomis).

Menurut penelitian-penelitian yang seksama early ambulation tidak mempunyai pengaruh yang buruk; tidak menyebabkan perdarahan yang abnormal, tidak mempengaruhi penyembuhan luka episiotomi atau luka perut, tidak memperbesar kemungkinan prolapsus atau retroflexio uteri.

Ibu pasca persalinan memerlukan waktu untuk memulihkan Kembali staminanya yang telah ibu keluarkan pada saat proses persalinan. Ibu pasca persalinan disarankan agar tetap berbaring dan istirahat terlentang minimal 8 jam di tempat tidur, hal ini dianjurkan agar tidak terjadi perdarahan pada ibu pasca persalinan. Ibu disarankan agar tidak langsung turun dari tempat tidur,

karena sirkulasi darah ibu pasca persalinan yang belum normal sehingga dapat menyebabkan ibu terjatuh atau pingsan. Mobilisasi perlu dilakukan agar tidak terjadi pembengkakan akibat tersumbatnya pembuluh darah pada Ibu pasca persalinan (Khasanah & Sulistyawati, 2017).

Satu atau dua jam setelah melahirkan secara normal, jika pergerakan ibu tidak terhalang oleh karena adanya infus atau kateter dan tanda-tanda vital ibu juga normal, maka ibu pasca persalinan diperbolehkan untuk mandi dan pergi ke WC dengan bantuan namun sebelumnya ibu diminta untuk melakukan latihan menarik nafas yang dalam serta latihan miring ke kiri atau ke kanan dan latihan tungkai yang sederhana dan harus duduk sambil mengayunkan tungkainya dari tepi ranjang (Khasanah & Sulistyawati, 2017).

Pada ibu pasca persalinan dengan Sectio Caesarea biasanya "ambulasi" dimulai 24-36 jam sesudah melahirkan. Jika Pasien menjalani analgesia epidural, pemulihan sensibilitas yang total harus dilakukan dahulu sebelum ambulasi dimulai. Setelah itu Ibu bisa pergi ke kamar mandi. Dengan begitu sirkulasi darah di dalam tubuh akan berjalan dengan baik. Gangguan yang tidak diinginkan pun bisa dihindari. Mobilisasi hendaknya dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan gerakan miring ke kanan dan ke kiri. Pada hari kedua ibu telah dapat duduk, lalu pada hari ketiga Ibu telah dapat menggerakkan kaki yakni dengan jalan- jalan. Hari keempat dan kelima, Ibu boleh pulang. Mobilisasi ini tidak mutlak, bervariasi tergantung pada adanya komplikasi persalinan, nifas, dan sembuhnya luka (Khasanah & Sulistyawati, 2017).

3. Kebutuhan Eliminasi

a. Buang Air Kecil (BAK)

Tiap ibu postpartum agar dapat buang air kecil dalam waktu 6 jam postpartum. Diuresis yang nyata akan terjadi pada satu atau dua hari pertama setelah melahirkan dan kadang kala ibu sering mengalami kesulitan saat ingin buang air kecil. Ini dapat disebabkan oleh karena rasa sakit, memar, atau pun luka perineum. Ibu postpartum yang mengalami kesulitan untuk buang air kecil dapat dibantu dengan pispot atau kursi berlubang jika ibu belum dapat berjalan. Kalau dalam 8 jam postpartum ibu belum dapat buang air kecil atau sekali saja dan belum melebihi 100 cc, maka dilakukan kateterisasi. Akan tetapi kalau ternyata bahwa kandung kemih penuh, tidak perlu menunggu 8 jam untuk kateterisasi. Meskipun sedapat mungkin dihindarnya kateterisasi namun jika kateterisasi dilakukan maka jauh lebih baik daripada ibu mengalami infeksi saluran kemih akibat urin yang tertahan (Fitri Nurhayati et. al, 2023).

Jika penderita sesudahnya belum dapat buang air kecil atau banyaknya urine

belum memuaskan, maka kateterisasi dilakukan tiap 8 jam. Beberapa sebab retensio urine postpartum:

- 1) Tekanan intra abdominal berkurang.
- 2) Otot-otot perut masih lemah.
- 3) Edema dari uretra.
- 4) Dinding kandung kencing kurang sensitif.

b. Defekasi (BAB)

Penderita diharapkan dapat BAB setelah hari kedua postpartum karena semakin lama faeses tertahan di dalam usus maka akan semakin sulit bagi ibu untuk buang air besar secara lancar. Hal ini dikarenakan cairan yang terkandung di dalam feses diserap oleh usus. Faktor-faktor diet memegang peranan penting dalam memulihkan fungsi dan kerja usus, anjurkan ibu untuk makan makanan berserat dan banyak minum air putih (Fitri Nurhayati et. al, 2023).

Peran bidan sangat diharapkan dalam lancarnya proses eliminasi BAB ibu postpartum. Di mana bidan harus dapat meyakinkan pasien untuk tidak takut buang air besar karena buang air besar tidak akan menambah parah luka jalan lahir. Jika penderita hari ketiga belum juga BAB, maka perlu diberi obat pencahar (Fitri Nurhayati et. al, 2023).

4. Kebutuhan Kebersihan Diri dan Perineum

Karena lelah yang masih dialami ibu pada saat postpartum, biasanya ibu yang belum cukup aktif dalam menjaga dan memperhatikan kebersihan dirinya terutama pada daerah perineum. Bidan dalam hal ini sebagai sahabat ibu, dituntut untuk dapat mengarahkan dan memberikan motivasi kepada ibu postpartum agar dapat memelihara kebersihan dirinya. Dalam pelaksanaan perawatan kebersihan ibu juga dapat melibatkan suami atau keluarga terdekat untuk membantu ibu (Fitri Nurhayati et. al, 2023).

Beberapa langkah penting dalam perawatan kebersihan diri ibu dalam masa pasca persalinan:

- a. Anjurkan kebersihan seluruh tubuh, terutama perineum.
- b. Mengajarkan ibu bagaimana membersihkan daerah kelamin dengan sabun dan air. Pastikan bahwa ia mengerti untuk membersihkan area disekitar vulva terlebih dahulu, dari depan ke belakang, baru kemudian membersihkan area sekitar anus. Nasihatkan kepada ibu untuk membersihkan vulva setiap kali selesai buang air.
- c. Sarankan ibu untuk mengganti pembalut atau kain pembalut setidaknya dua kali sehari. Kain dapat digunakan ulang jika telah dicuci dengan baik dan dikeringkan di bawah matahari dan disetrika.

- d. Sarankan ibu untuk mencuci tangan dengan sabun dan air sebelum dan sesudah membersihkan daerah kelaminnya.
- e. Jika ibu mempunyai luka episiotomi atau laserasi, sarankan kepada ibu untuk menghindari menyentuh daerah luka.

5. Kebutuhan Istirahat

- a. Anjurkan ibu agar istirahat cukup untuk mencegah kelelahan yang berlebihan.
- b. Sarankan ia untuk kembali ke kegiatan-kegiatan rumah tangga secara perlahan-lahan, serta untuk tidur siang atau beristirahat selagi bayi tidur.
- c. Kurang istirahat akan mempengaruhi ibu dalam beberapa hal:
 - 1) Mengurangi jumlah ASI yang diproduksi.
 - 2) Memperlambat proses involusi uterus dan memperbanyak perdarahan.
 - 3) Menyebabkan depresi dan ketidakmampuan untuk merawat bayi dan dirinya sendiri

6. Kebutuhan Seksual

- a. Secara fisik aman untuk memulai hubungan suami istri begitu darah merah berhenti dan ibu dapat memasukkan satu atau dua jarinya ke dalam vagina tanpa rasa nyeri. Begitu darah merah berhenti dan ibu tidak merasa nyeri, aman untuk memulai melakukan hubungan suami isteri kapan saja ibu siap.
- b. Banyak budaya, yang mempunyai tradisi menunda hubungan suami isteri sampai masa waktu tertentu, misalnya setelah 40 hari atau 6 minggu setelah persalinan. Keputusan bergantung pada pasangan yang bersangkutan.
- c. Pada waktu 40 hari diharapkan organ-organ tubuh telah pulih kembali. Ibu mengalami ovulasi dan mungkin mengalami kehamilan sebelum haid yang pertama timbul setelah persalinan. Untuk itu bila senggama tidak mungkin menunggu sampai hari ke-40, suami/istri perlu melakukan usaha untuk mencegah kehamilan (Fitri Nurhayati et. al, 2023).

7. Kebutuhan KB

Kebutuhan kontrasepsi atau keluarga berencana pada ibu postpartum adalah aspek penting untuk merencanakan dan mengatur kehamilan di masa depan, serta untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan segera setelah melahirkan. Pilihan kontrasepsi harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan ibu, kebiasaan menyusui, dan preferensi pribadi (Kemenkes RI, 2020).

D. Peran Keluarga Pada Ibu Pasca Bersalin

Ada beragam gangguan pada ibu pasca bersalin. Ibu mengalami gangguan pasca bersalin sekitar 25- 85% ibu postpartum mengalami postpartum blues kemudian 10-20% mengalami depresi postpartum dan 5% menjadi psikosis.

Diperkirakan wanita melahirkan dan mengalami postpartum blues sekitar 10 per 1000 kelahiran hidup, dan depresi postpartum 30-200 per 1000 kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2020).

Aspek dukungan yang pertama dikaji oleh peneliti adalah dukungan emosional. Yang dimaksud dengan dukungan emosional adalah segala bentuk ekspresi kepedulian, perhatian dan empati yang diperoleh dari keluarga. Keluarga merupakan tempat yang aman dan damai untuk istirahat dan pemulihan serta membantu penguasaan terhadap emosi. Aspek-aspek dari dukungan emosional meliputi dukungan yang diwujudkan dalam bentuk afeksi, adanya kepercayaan, perhatian, mendengarkan dan didengarkan. Berdasarkan hasil temuan data dengan informan mengenai aspek dukungan emosional ditemukan bahwa mayoritas informan merasakan kebahagiaan atas kelahiran bayinya serta ibu bayi diberi karunia kesehatan (Kemenkes RI, 2020).

E. Tanda Bahaya Pasca Persalinan

Tanda Bahaya Pada Ibu Nifas

Sebagian besar kehamilan berakhir dengan persalinan dan masa nifas yang normal. Akan tetapi, 15-20% diperkirakan akan mengalami gangguan atau komplikasi. Gangguan tersebut dapat terjadi secara mendadak dan biasanya tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Karena itu, tiap tenaga kesehatan, ibu hamil, keluarga dan masyarakat perlu mengetahui dan mengenali tanda bahaya. Tanda bahaya pada ibu di masa nifas antara lain:

1. Perdarahan pasca persalinan

Perdarahan yang banyak, segera atau dalam 1 jam setelah melahirkan, sangat berbahaya dan merupakan penyebab kematian ibu paling sering. Keadaan ini dapat menyebabkan kematian dalam waktu kurang dari 2 jam. Ibu perlu segera ditolong untuk penyelamatan jiwanya. Perdarahan pada masa nifas (dalam 42 hari setelah melahirkan) yang berlangsung terus menerus disertai bau tak sedap dan demam, juga merupakan tanda bahaya.

2. Keluar cairan berbau dari jalan lahir

Keluarnya cairan berbau dari jalan lahir menunjukkan adanya infeksi. Hal ini bisa disebabkan karena metritis, abses pelvis, infeksi luka perineum atau karena luka abdominal.

3. Bengkak di wajah, tangan dan kaki, atau sakit kepala dan kejang-kejang.

Bengkak pada wajah, tangan dan kaki bila disertai tekanan darah tinggi dan sakit kepala (pusing).

4. Demam lebih dari 2 hari

Demam lebih dari 2 hari pada ibu nifas bisa disebabkan oleh infeksi.

Apabila demam disertai keluarnya cairan berbau dari jalan lahir, kemungkinan ibu mengalami infeksi jalan lahir. Akan tetapi apabila demam tanpa disertai keluarnya cairan berbau dari jalan lahir, perlu diperhatikan adanya penyakit infeksi lain seperti demam berdarah, demam tifoid, malaria, dsb.

5. Payudara bengkak, merah disertai rasa sakit

Payudara bengkak, merah disertai rasa sakit bisa disebabkan karena bendungan payudara, inflamasi atau infeksi payudara.

6. Gangguan psikologis pada masa pasca persalinan meliputi:

- a. Perasaan sedih pasca persalinan (postpartum blues)
- b. Depresi pasca persalinan (postpartum depression)
- c. Psikosis pasca persalinan (postpartum psychotic) (Fitri Nurhayati et. al, 2023)

F. Penanganan Luka Episiotomi

Luka episiotomi adalah pemotongan pada perineum yang dilakukan untuk memperbesar jalan lahir selama persalinan. Meskipun episiotomi dapat mengurangi risiko robekan yang lebih besar pada perineum, prosedur ini tetap menyebabkan luka yang memerlukan perawatan intensif. Tanpa penanganan yang tepat, luka episiotomi dapat berisiko mengalami infeksi, perdarahan berlebih, atau gangguan penyembuhan lainnya, yang dapat memperburuk kondisi ibu setelah melahirkan. Oleh karena itu, penanganan luka episiotomi yang baik adalah kunci untuk mendukung pemulihan pasca-persalinan yang cepat dan efektif (Yulizawati, Insani, Sinta, & Andriani, 2019).

Perawatan luka episiotomi melibatkan berbagai langkah medis, mulai dari pembersihan luka hingga pemantauan tanda-tanda infeksi. Luka episiotomi harus dijaga kebersihannya dengan antiseptik yang sesuai dan dilakukan secara teratur untuk mencegah infeksi (Nurhayati, 2020). Penanganan yang tidak tepat atau kelalaian dalam menjaga kebersihan dapat meningkatkan risiko infeksi, yang dapat memperlambat penyembuhan luka dan menyebabkan komplikasi serius, seperti abses atau sepsis. Oleh karena itu, penting bagi tenaga medis untuk melakukan pemantauan rutin dan memberikan perawatan yang sesuai dengan kondisi luka (Satriani, 2021).

Selain itu, manajemen rasa sakit juga menjadi aspek penting dalam penanganan luka episiotomi. Banyak ibu mengalami ketidaknyamanan atau nyeri yang cukup signifikan pada area luka episiotomi setelah melahirkan. Pengelolaan nyeri yang efektif menggunakan analgesik, baik obat oral maupun topikal, sangat membantu dalam mempercepat pemulihan (Satriani, 2021). Selain obat-obatan, teknik non-farmakologis seperti kompres hangat atau penggunaan bantal pelindung untuk mengurangi tekanan pada luka juga dapat memberikan bantuan

signifikan dalam mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kenyamanan ibu (Herinawati, Hindriati, & Novilda, 2019).

Penting untuk memberikan edukasi yang jelas kepada ibu mengenai perawatan luka dan tanda-tanda infeksi yang harus diwaspadai. Edukasi ini membantu ibu merasa lebih tenang dan mengurangi kecemasan terkait prosedur dan pemulihan setelah episiotomi. Dukungan psikologis dari tenaga medis maupun keluarga sangat penting untuk menciptakan rasa percaya diri ibu dalam merawat diri dan mengenali gejala komplikasi sedini mungkin. Dengan pendekatan yang menyeluruh, yang mencakup perawatan medis yang tepat dan dukungan emosional, proses penyembuhan luka episiotomi dapat berlangsung lebih lancar dan tanpa komplikasi (Herinawati et al., 2019).

Berikut teknik pelaksanaan episiotomi:

1. Persiapan Sebelum Prosedur

Sebelum melakukan episiotomi, persiapan yang tepat sangat penting untuk mencegah infeksi dan memastikan keberhasilan prosedur. Langkah-langkah persiapan antara lain:

- a. Pemeriksaan dan Penilaian: Tenaga medis melakukan penilaian terhadap kondisi ibu dan bayi untuk memastikan bahwa episiotomi memang diperlukan. Ini termasuk memeriksa posisi bayi, kekuatan kontraksi, serta keadaan perineum ibu.
- b. Sterilisasi: Area perineum harus dibersihkan dan disterilkan dengan antiseptik untuk mengurangi risiko infeksi. Ini meliputi pembersihan menggunakan larutan antiseptik seperti povidone iodine.
- c. Anestesi Lokal: Episiotomi dilakukan di bawah anestesi lokal untuk mengurangi rasa sakit. Beberapa rumah sakit juga mungkin menawarkan anestesi regional (misalnya, epidural) yang telah diberikan sebelumnya untuk proses persalinan (Yulizawati et al., 2019).

2. Jenis-Jenis Episiotomi

Ada dua jenis episiotomi yang paling umum dilakukan, yaitu episiotomi medial dan episiotomi mediolateral.

3. Episiotomi Medial

(Midline Episiotomy): Pemotongan dilakukan langsung di tengah perineum, dari bawah vagina ke arah anus. Keuntungan: Teknik ini lebih sederhana dan lebih mudah untuk dilakukan. Proses pemulihan umumnya lebih cepat dan risiko perdarahan lebih kecil. Kelemahan: Jika robekan terjadi setelah episiotomi, ada risiko robekan yang lebih luas hingga ke anus, yang dapat menyebabkan cedera pada sfingter anal dan masalah jangka panjang seperti inkontinensia.

4. Episiotomi Mediolateral

(Mediolateral Episiotomy): Pemotongan dilakukan secara miring, dari sisi vagina menuju perineum, sekitar 45 derajat ke arah paha. Pemotongan ini cenderung lebih besar dan lebih luas daripada episiotomi medial. Keuntungan: Risiko robekan ke anus lebih kecil, karena pemotongan dilakukan secara miring. Oleh karena itu, mediolateral sering dipilih pada kasus persalinan yang lebih rumit atau ketika ada risiko robekan yang lebih parah. Kelemahan: Proses penyembuhan bisa lebih lama dibandingkan dengan episiotomi medial, dan ada kemungkinan perdarahan yang lebih banyak (Yulizawati et al., 2019).

5. Langkah-Langkah Pelaksanaan Episiotomi

Setelah persiapan selesai, pelaksanaan episiotomi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Posisi Ibu: Ibu biasanya diminta untuk berbaring dengan posisi kaki terbuka lebar (lithotomy position) untuk memudahkan akses ke perineum. Terkadang, posisi ibu juga dapat disesuaikan dengan kenyamanan ibu dan kondisi persalinan.
- b. Penanda Lokasi Pemotongan: Sebelum memulai pemotongan, dokter atau bidan akan menandai area yang akan dipotong dengan menggunakan jari atau alat penanda, memastikan pemotongan dilakukan pada area yang tepat.
- c. Pemberian Anestesi: Anestesi lokal disuntikkan pada area perineum yang akan dipotong. Proses ini mengurangi rasa sakit dan memungkinkan prosedur dilakukan dengan lebih aman. Pada beberapa kasus, jika anestesi lokal tidak cukup, epidural dapat digunakan.
- d. Pemotongan: Setelah anestesi bekerja, dokter atau bidan akan memotong perineum sesuai dengan jenis episiotomi yang dipilih. Pemotongan dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari cedera pada struktur penting seperti uretra, sfingter anal, atau rektum.
- e. Penutupan Luka: Setelah kelahiran bayi, luka episiotomi akan dijahit dengan benang yang larut (resorbable sutures). Teknik menjahit harus dilakukan dengan teliti untuk memastikan penyembuhan yang optimal dan mengurangi kemungkinan komplikasi seperti infeksi atau robekan tambahan (Yulizawati et al., 2019).

G. Pencegahan Komplikasi pada Luka Episiotomi

Pencegahan komplikasi pada luka episiotomi sangat penting untuk memastikan pemulihan yang optimal dan menghindari masalah jangka panjang bagi ibu setelah persalinan. Meskipun episiotomi memiliki potensi komplikasi, tindakan pencegahan yang tepat dapat mengurangi risiko infeksi, perdarahan,

serta masalah lainnya. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah komplikasi pada luka episiotomi:

1. Pemilihan Indikasi yang Tepat

Salah satu langkah pertama dalam pencegahan komplikasi adalah memastikan bahwa episiotomi dilakukan hanya dalam indikasi yang benar dan tepat. Episiotomi tidak seharusnya dilakukan secara rutin, tetapi hanya jika ada indikasi medis yang jelas, seperti ketika bayi dalam posisi yang tidak menguntungkan, saat menggunakan alat bantu persalinan, atau jika ada risiko robekan perineum yang parah. Dengan pemilihan indikasi yang tepat, risiko cedera lebih lanjut pada ibu dapat diminimalkan.

2. Sterilisasi dan Kebersihan yang Ketat

Untuk mencegah infeksi pada luka episiotomi, penting untuk menjaga kebersihan yang ketat selama prosedur dan setelahnya. Sebelum episiotomi dilakukan, area perineum harus dibersihkan dengan antiseptik untuk mengurangi bakteri yang dapat menyebabkan infeksi. Setelah prosedur, ibu perlu diberikan instruksi yang jelas tentang cara merawat luka episiotomi, termasuk membersihkan area tersebut dengan hati-hati menggunakan larutan antiseptik dan mengganti pembalut secara rutin untuk menjaga kebersihan.

3. Pemberian Anestesi yang Cukup

Pengelolaan nyeri yang baik juga berperan dalam pencegahan komplikasi. Pemberian anestesi yang cukup, baik itu anestesi lokal atau epidural, penting untuk mengurangi rasa sakit selama prosedur episiotomi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan ibu, tetapi juga membantu mengurangi ketegangan otot yang bisa memperburuk proses penyembuhan luka.

4. Pemilihan Teknik Episiotomi yang Tepat

Pemilihan teknik episiotomi yang tepat juga mempengaruhi pencegahan komplikasi. Pemotongan yang tepat dan sesuai dengan kondisi ibu dan bayi, serta pilihan antara episiotomi medial atau mediolateral, sangat penting untuk mengurangi risiko cedera tambahan. Episiotomi mediolateral, meskipun lebih besar dan memerlukan waktu penyembuhan lebih lama, seringkali lebih aman pada kasus tertentu, seperti saat bayi besar atau posisi kepala bayi sulit.

5. Perawatan Luka yang Optimal

Setelah episiotomi, perawatan luka yang baik sangat penting untuk mencegah infeksi dan mempercepat penyembuhan. Luka episiotomi harus dijaga tetap kering dan bersih. Ibu dianjurkan untuk mengganti pembalut secara teratur dan melakukan kebersihan diri dengan hati-hati, menggunakan air bersih dan tidak menggosok luka secara langsung. Kompres dingin pada area perineum juga dapat membantu mengurangi pembengkakan dan mempercepat

proses pemulihan.

6. Menghindari Aktivitas Berat

Aktivitas fisik yang berat atau penggunaan otot panggul yang berlebihan dapat memperburuk luka episiotomi dan memperlambat proses penyembuhan. Oleh karena itu, ibu dianjurkan untuk menghindari aktivitas berat seperti mengangkat beban atau berlari setidaknya selama beberapa minggu setelah melahirkan. Menghindari hubungan seksual selama masa pemulihan juga disarankan agar luka episiotomi tidak teriritasi atau terbuka kembali.

7. Kontrol Nyeri yang Efektif

Mengontrol rasa sakit setelah episiotomi juga merupakan langkah pencegahan yang penting. Penggunaan obat penghilang rasa sakit yang tepat, baik yang diberikan secara oral atau topikal, dapat membantu ibu untuk mengurangi ketidaknyamanan dan mencegah ibu untuk mengubah posisi atau bergerak secara tidak alami, yang bisa menyebabkan luka lebih parah.

8. Pemeriksaan Rutin dan Pemantauan Luka

Pemeriksaan pasca-persalinan yang teratur oleh tenaga medis sangat penting untuk mendeteksi komplikasi sejak dini. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa apakah ada tanda-tanda infeksi atau masalah penyembuhan lainnya. Dengan pemeriksaan rutin, tenaga medis dapat segera memberikan penanganan lebih lanjut jika ditemukan masalah pada luka episiotomi, seperti infeksi atau perdarahan yang tidak terkontrol.

9. Pendidikan dan Dukungan Pasca Persalinan

Memberikan informasi dan dukungan kepada ibu mengenai perawatan diri setelah episiotomi sangat penting untuk mencegah komplikasi. Ini termasuk memberi tahu ibu tentang tanda-tanda infeksi atau komplikasi lainnya, serta kapan harus menghubungi tenaga medis. Selain itu, dukungan emosional dan fisik juga penting, terutama selama masa pemulihan, untuk membantu ibu merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam mengelola luka episiotomi.

10. Makanan Sehat dan Hidrasi yang Cukup

Nutrisi yang baik memainkan peran besar dalam proses penyembuhan. Ibu setelah melahirkan perlu menjaga asupan makanan yang kaya akan vitamin, mineral, dan protein untuk mendukung proses penyembuhan luka. Selain itu, hidrasi yang cukup juga penting untuk menghindari sembelit yang dapat memberikan tekanan tambahan pada luka episiotomi saat buang air besar (Irfana Tri Wijayanti, Baharika Suci Dwi Aningsih, Naomi Parmila Hesti, Syahrida Wahyu Utami, 2022).

H. Perawatan Vagina

Terdapat beberapa cara untuk merawat vagina usai melahirkan yaitu dengan melakukan step by step perawatan agar vagina dapat segera pulih dan normal seperti sebelumnya.

1. Pastikan Vagina Tetap Bersih dan Kering

Perawatan vagina setelah melahirkan yang dapat dilakukan pertama kali adalah dengan memastikan bahwa vagina selalu bersih dan kering. Ketika masa nifas, gantilah pembalut sesering mungkin dan selalu jaga kebersihannya. Mengganti pembalut secara teratur dapat meminimalisir terjadinya infeksi vagina setelah melahirkan. Ibu dapat menggunakan air hangat untuk membasuh area vagina setelah buang air. Rasa sakit akibat pembengkakan juga dapat teratasi dengan basuhan air hangat. Ibu sebaiknya menggunakan tisu kering setelah buang air agar vagina tidak lembab dan selalu kering. Lakukan cara ini terus menerus agar vagina tetap bersih dan terhindar dari infeksi.

2. Gunakan Pembalut Selama Nifas

Pendarahan yang terjadi setelah melahirkan atau nifas biasanya berlangsung lama. Darah yang keluar juga memiliki kuantitas yang lebih banyak untuk persalinan normal. Oleh karena itu gunakan pembalut selama proses ini terjadi, hindari menggunakan tampon. Ibu yang menggunakan tampon selama masa nifas berisiko tinggi mengalami infeksi pada area vagina. Padahal, infeksi tersebut menimbulkan efek buruk jangka panjang dan mengganggu aktivitas harian. Oleh karena itu pastikan Ibu menggunakan pembalut bukan tampon selama masa nifas.

3. Kompres Dingin

Vagina yang terasa nyeri dan bengkak dapat diatasi dengan menggunakan kompres dingin. Cobalah untuk menggunakan es atau ice pack untuk mengompres area vagina dalam waktu kurang lebih 30 menit. Hindari mengompreskan es langsung pada area vagina, lebih baik gunakan kain tipis untuk membalut es. Kompres dingin dipercaya mampu meringankan pembengkakan serta mengatasi rasa nyeri pada area vagina.

4. Berikan Cairan Antiseptik

Cara lain untuk melakukan perawatan vagina setelah melahirkan adalah dengan memberikan cairan antiseptik pada jahitan. Cairan antiseptik mampu mencegah infeksi pada bagian luka jahitan. Caranya adalah dengan melarutkan lotion antiseptik ke air lalu membersihkannya pada bagian vagina atau menuangkannya pada atas jahitan.

5. Latihan Panggul Dasar

Setelah rutin membersihkan area vagina dan memberikannya antiseptik, Ibu perlu memastikan bahwa tidak ada masalah dengan jahitan vagina. Jika memang tidak ada masalah dengan jahitan, Ibu dapat meneruskan perawatan dengan mencoba latihan dasar panggul. Latihan dapat membantu meningkatkan aliran darah ke vagina serta mempercepat fase penyembuhan. Latihan dasar panggul dapat mencegah infeksi vagina pasca melahirkan. Ibu dapat mengikuti latihan senam nifas untuk membantu merelaksasi otot dan mengembalikan bentuk tubuh.

6. Membersihkan Area Vital Setelah Buang Air

Setelah buang air, baik besar atau kecil, Ibu harus membersihkan area vagina dengan tuntas. Terlebih setelah buang air besar, area anus harus dibersihkan dengan maksimal untuk mencegah infeksi. Basuh dengan air dari depan ke belakang, bukan sebaliknya, untuk mencegah infeksi pada vagina setelah bersalin. Jangan lupa untuk mengelapnya dengan tisu kering setelah buang air.

7. Banyak Minum Air Putih

Keluhan lain yang banyak terjadi setelah persalinan normal adalah kondisi vagina yang kering. Vagina yang kering membuat aktivitas seksual menjadi tidak nyaman. Untuk perawatan vagina setelah melahirkan, Ibu bisa mengonsumsi air putih yang banyak untuk mengurangi tingkat kekeringan. Selain itu, untuk membantu aktivitas seksual supaya nyaman, Ibu dapat menggunakan bantuan pelumas atau mengoleskan pelembab vagina. konsultasikan dengan dokter mengenai masalah ini.

8. Senam Kegel

Perawatan vagina setelah melahirkan lain yang dapat Ibu lakukan adalah rutin melakukan senam kegel. Senam kegel berfungsi untuk mengencangkan otot panggul serta merapatkan kembali lubang vagina yangs empat longgar dan kendur pasca melahirkan.

9. Bantuan Medis

Jika Ibu merasakan sesuatu yang tidak normal pada jahitan vagina, seperti bengkak, nyeri yang tak tertahankan, atau keluar lendir berbau, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Sesuatu yang abnormal tersebut merupakan tanda-tanda infeksi yang harus segera ditangani oleh dokter agar tidak berkepanjangan. Tanda awal infeksi yang diketahui sejak dini dapat membantu proses perawatan dan pemulihan lebih cepat. Dokter dapat meresepkan antibiotik atau obat lain yang dapat mengobati infeksi pada bagian vagina (Fitri Nurhayati et. al, 2023).

I. Kesimpulan

Pemulihan pasca persalinan merupakan waktu yang penting bagi ibu dan keluarga. Perawatan pasca persalinan awalnya harus berfokus pada kebutuhan dan resiko morbiditas dan mortalitas kemudian beralih ke pemeliharaan kesehatan. Pasca persalinan merupakan waktu yang rentan untuk mendukung ibu dan bayi karena sering menghadapi kebutuhan utama yang tidak terpenuhi. Pada awal pasca persalinan, mereka merasakan kurangnya pemeriksaan dan dukungan kesehatan mental. Ibu masih merasa tidak mampu untuk memberikan perawatan kepada anak.

Menurut WHO, mortalitas dan morbiditas menjadi perhatian utama, karena sebagian besar kematian dan kesakitan ibu dapat dicegah selama satu minggu pertama pasca persalinan. Sebanyak 45% kematian ibu pasca persalinan terjadi dalam 24 jam pertama, dan 66% terjadi pada minggu pertama pasca persalinan. Mengingat tingginya angka kematian ibu pada masa nifas, penting untuk mengembangkan tindakan yang efisien untuk memenuhi kebutuhan ibu pada masa nifas.

Pasca melahirkan juga terjadi perubahan-perubahan pada rahim, vagina, dinding perut. Seorang wanita dapat kembali berolahraga ringan setelah dua minggu bagi yang melahirkan secara vaginal, dan enam minggu bagi yang melahirkan secara bedah caesar. Dua minggu pertama dapat melakukan latihan Kegel untuk menguatkan lubang vagina, berjalan, atau yoga yang paling halus. Setelah dua minggu dapat ditambah dengan peregangan dan jalan, bergoyang mengikuti irama musik dengan menggendong bayi. Perlu diperhatikan tanda-tanda dari tubuh jika latihan sudah terlalu berat, akan membahayakan bisa terjadi pendarahan, pusing, terasa ingin buang air kecil. Maka jangan ingin terlalu cepat ber-olahraga, lakukan secara bertahap hingga tubuh terasa nyaman.

J. Referensi

- Fitri Nurhayati et. al. (2023). Kebutuhan Dasar Ibu Bersalin Sesuai Kala Persalinan. In Oktavianis (Ed.), *Get Press Indonesia*. Padang: Get Press Indonesia.
- Herinawati, H., Hindriati, T., & Novilda, A. (2019). Pengaruh Effleurage Massage terhadap Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif di Praktik Mandiri Bidan Nuriman Rafida dan Praktik Mandiri Bidan Latifah Kota Jambi Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(3), 590. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i3.764>
- Irfana Tri Wijayanti, Baharika Suci Dwi Aningsih, Naomi Parmila Hesti, Syahrinda Wahyu Utami, W. D. I. (2022). Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada

- Persalinan. In *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Persalinan*. Yogyakarta: K-Media. Retrieved from e-repository-stikesmedistra-indonesia.ac.id
- Kemenkes RI. (2020). Pedoman Pelayanan Kontrasepsi Dan Keluarga Berencana. In *Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. Jakarta.
- Khasanah, N. A., & Sulistyawati, W. (2017). *Asuhan Nifas dan Menyusui* (R. Perdana, ed.). Surakarta: Kekata Publisher.
- Nurhayati, Y. (2020). Hubungan Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Vulva Hygiene Dengan Tingkat Kesembuhan Luka Perineum Pada Ibu Nifas. *Jurnal Keperawatan Dan Kebidanan*, 1(1), 12–20.
- Nursyafitri, R., & Syahda, S. (2023). Evidence midwifery journal. *Evidence Midwifery Journal*, 2(1), 21–26.
- Satriani. (2021). *Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui* (Y. Umay, ed.). Malang: Ahlimedia Press. Retrieved from <https://perpustakaan.poltektegal.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=27473&bid=4328312>
- Sudayasa, I. P., Rusli, & Mubarak. (2022). *Pengantar Kesehatan Reproduksi Wanita* (1st ed.; P. Sudaya, ed.). Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/362174268>
- Wijaya, W., Limbong, T. O., & Yulianti, D. (2023). Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas. In M. Nasrudin (Ed.), *Akademi Kebidanan Griya Husada Surabaya*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Yohana Sitorus, E., Martini, S., & Mahanani Mulyaningrum, F. (2023). Correlation Between the Use of Bengkung Towards Uterine Involution in Postpartum Mothers. *Jurnal Profesi Bidan Indonesia (JPBI)*, 3(1), 2798–8856.
- Yulizawati, Insani, A. A., Sinta, L. El, & Andriani, F. (2019). Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Persalinan. In *Asuhan Kebidanan Pada Persalinan*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.

CHAPTER 5

PENDEKATAN HOLISTIK DALAM PERSALINAN NORMAL KESEIMBANGAN FISIK, MENTAL, DAN SPIRITUAL

Anisah Tifani Maulidyanti, S.Tr.Keb., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Persalinan adalah hal yang fisiologis. Fisiologis dalam artian setiap makhluk hidup mamalia berkembangbiak dengan melahirkan.

Dalam proses persalinan melibatkan berbagai aspek dalam fisiologi dalam kehidupan manusia atau wanita pada khususnya. Aspek yang terlibat diantaranya keseimbangan fisik, mental dan spiritual. Bidan mengoptimalkan proses fisiologis normal dan mendukung situasi fisik, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual yang aman, bekerja untuk meningkatkan hasil yang positif dan mengantisipasi serta mencegah komplikasi (Crowther & Hall, 2015)

Aspek fisik melibatkan perubahan fisiologis dalam tubuh ibu. Aspek mental melibatkan kondisi psikis, cara pandang, pola pikir yang berhubungan dalam pengambilan keputusan oleh ibu.

Aspek spiritual melibatkan keyakinan-keyakinan yang ada dalam diri ibu yang dalam hal ini akan berperan dalam menyikapi berbagai permasalahan yang di hadapi. Hal ini biasanya erat hubungannya dengan keyakinan serta ketaatan dalam menjalankan kehidupan beragama.

Akan tetapi tidak semua tenaga kesehatan khususnya bidan menyadari bahwa perlunya pendekatan dalam pertolongan persalinan dengan memperhatikan aspek holistik ibu. Sehingga tidak jarang ibu merasa takut periksa ke tenaga kesehatan dan ke fasilitas kesehatan bahkan lebih memilih untuk bersalin ke dukun.

Ibu menilai dukun mampu memberikan pelayanan yang menyeluruh dan komprehensif. pelayanan yang komplit dimana tidak hanya fokus pada pertolongan kelahiran tapi juga memperhatikan kondisi emosional ibu dan dengan spiritual ibu.

Kondisi mental ini tampak dari ciri perawatan yang caring, peduli, telaten, keibuan, bisa mendengarkan keluhan ibu dengan baik, dan menunjukkan rasa empati dengan baik.

Kondisi spiritual ini biasanya tampak dari dukun turut melaksanakan dan memfasiliasi keinginan keluarga dalam menjalankan kegiatan spiritual

keagaamaan. Misalnya 4 bulanan, 7 bulanan, memandikan bayi hingga ibu dapat melakukannya dengan mandiri.

Kondisi ini yang menyebabkan dukun masih di hati masyarakat kita. Sebagai tenaga kesehatan khususnya bidan sebaiknya melakukan evaluasi berkaca pada pelayanan yang dilakukan oleh dukun. Dalam arti dukun dengan keterbatasan kemampuan dan keterampilan klinis mampu memberikan pelayanan yang holistic, harusnya seorang bidan yang sudah dibekali ilmu pengetahuan dan keterampilan dan dibuktikan dengan telah lulus uji kompetensi maka harusnya dapat memberikan pelayanan lebih prima.

B. Filosofi persalinan

Filosofi persalinan mencerminkan pandangan mendalam tentang proses kelahiran, yang melibatkan dimensi fisik, emosional, spiritual, dan sosial(Evi Pratami, 2014). Berikut adalah beberapa poin yang menjadi dasar filosofi persalinan:

1. Proses Alami dan Sakral

Persalinan adalah proses alami yang dirancang oleh tubuh manusia, menunjukkan kekuatan dan kemampuan tubuh perempuan untuk melahirkan kehidupan. Proses ini sering dianggap sebagai momen sakral yang penuh makna, baik secara individu maupun spiritual. Persalinan merupakan kejadian yang luar biasa. Persalinan merupakan pengalaman hidup yang normal(Crowther & Hall, 2015).

2. Pusat Kendali pada Ibu

Dalam filosofi persalinan, ibu dipandang sebagai aktor utama. Kepercayaan pada intuisi dan kemampuan perempuan untuk melahirkan menjadi inti. Dukungan dari tenaga medis atau pendamping hanya bersifat mendampingi dan memperkuat kepercayaan diri ibu.(Statement, 2012)

3. Keseimbangan antara Sains dan Naluri

Meski kemajuan teknologi dan ilmu kedokteran membantu meminimalkan risiko, filosofi persalinan juga menghormati naluri dan ritme alami tubuh. Pendekatan ini mencoba mengintegrasikan sains dan naluri untuk memastikan pengalaman persalinan yang positif.

4. Pendekatan Holistik

Persalinan tidak hanya dipandang sebagai proses fisik tetapi juga sebagai perjalanan emosional dan mental. Dukungan terhadap kesehatan mental ibu, keterlibatan keluarga, serta pemahaman akan nilai-nilai budaya menjadi bagian penting dari filosofi ini.

5. Penghormatan terhadap Keunikan Setiap Persalinan

Setiap proses persalinan adalah unik. Tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua. Filosofi ini menghargai kebutuhan, pilihan, dan kondisi setiap ibu yang berbeda-beda.

6. Kekuatan Dukungan Komunitas

Persalinan tidak hanya melibatkan ibu, tetapi juga pasangan, keluarga, dan bahkan masyarakat. Dukungan emosional dari orang-orang terdekat sering kali menjadi kunci dalam menciptakan pengalaman persalinan yang positif.

7. 7. Penerimaan atas Ketidakpastian

Filosofi persalinan juga mengajarkan penerimaan terhadap kemungkinan perubahan rencana. Meski persiapan sangat penting, fleksibilitas dalam menghadapi situasi yang tidak terduga adalah bagian dari proses

C. Pendekatan holistik dalam persalinan

Pendekatan holistik dalam persalinan adalah pendekatan yang mempertimbangkan ibu hamil secara utuh—mencakup aspek fisik, emosional, dan spiritual. Pendekatan ini menekankan bahwa persalinan bukan hanya peristiwa medis, tetapi juga pengalaman manusia yang kompleks dan mendalam. Berikut adalah prinsip dan penerapan pendekatan holistik dalam persalinan:

1. Prinsip Pendekatan Holistik

a. Keseimbangan Tubuh dan Pikiran

Mengintegrasikan kesehatan fisik dengan kesejahteraan emosional ibu selama kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan.

b. Menghormati Keunikan Ibu dan Bayi

Mengakui bahwa setiap individu memiliki kebutuhan, preferensi, dan pengalaman berbeda selama proses melahirkan.

c. Fokus pada Proses Alami

Memberikan kesempatan bagi tubuh untuk bekerja sesuai dengan ritme alami, sembari tetap siap menghadapi intervensi jika diperlukan.

d. Keterlibatan Keluarga dan Dukungan Sosial

Memastikan ibu didukung oleh pasangan, keluarga, dan komunitas yang peduli, yang membantu menciptakan lingkungan persalinan yang positif.

e. Peningkatan Spiritualitas dan Keseimbangan Emosional

Memandang persalinan sebagai pengalaman yang mendalam secara spiritual dan emosional, di mana kehadiran mindfulness, doa, atau meditasi dapat mendukung. Peran spiritualitas juga telah diakui sebagai peningkatan kualitas pengalaman melahirkan melalui perawatan, kasih sayang, dan kehadiran bidan (Moloney & Gair, 2015)

2. Penerapan Pendekatan Holistik

a. Perawatan Fisik

- 1) Memberikan panduan gaya hidup sehat, seperti nutrisi yang seimbang, olahraga ringan (yoga kehamilan, senam hamil), dan teknik pernapasan.
- 2) Mendorong persalinan alami (normal) jika memungkinkan, dengan minimalisasi intervensi medis kecuali jika diperlukan.

b. Dukungan Emosional

- 1) Kehadiran atau pendamping persalinan yang memberikan rasa tenang, kenyamanan, dan motivasi. Empati merupakan unsur penting dalam praktik efektif bagi profesional kesehatan (Moloney & Gair, 2015)
- 2) Terapi berbasis seni atau terapi relaksasi seperti hypnobirthing untuk mengatasi rasa cemas.

c. Lingkungan yang Mendukung

- 1) Menciptakan ruang persalinan yang nyaman dan personal, dengan pencahayaan lembut, musik, atau aromaterapi.
- 2) Memberikan ibu kendali atas prosesnya, seperti memilih posisi persalinan atau waktu untuk melakukan tahapan tertentu (dengan panduan tenaga medis).

d. Penggunaan Teknik Alternatif dan Tradisional

- 1) Akupunktur, pijat prenatal, atau teknik pereda nyeri alami seperti kompres air hangat (Ulfah et al., 2024) (Mandiri & Harahap, 2024) (Azizah & Riana Pascawati, 2023).
- 2) Mengadopsi tradisi budaya yang membantu ibu merasa terhubung dengan komunitas atau leluhurnya, seperti ritual persalinan tradisional.

e. Pendekatan Spiritual

- 1) Menyediakan ruang untuk praktik spiritual seperti doa atau meditasi, yang sering kali membantu ibu merasa lebih tenang dan berdaya. Spiritual menjadi factor yang mempengaruhi kesejahteraan manusia (Crowther & Hall, 2015)
- 2) Mengintegrasikan keyakinan atau tradisi religius yang relevan untuk ibu.

3. Manfaat Pendekatan Holistik dalam Persalinan

- a. Mengurangi stres dan kecemasan selama kehamilan dan persalinan.
- b. Meningkatkan kepercayaan diri ibu dalam menghadapi proses persalinan.
- c. Meminimalkan risiko komplikasi karena tubuh bekerja secara alami dalam lingkungan yang mendukung.
- d. Mempererat ikatan antara ibu, bayi, pasangan, dan keluarga sejak awal.
- e. Menghasilkan pengalaman persalinan yang lebih positif dan bermakna.

D. Keseimbangan fisik dalam pertolongan persalinan

Keseimbangan fisik dalam pertolongan persalinan berfokus pada bagaimana tubuh ibu didukung secara optimal selama proses persalinan. Hal ini mencakup strategi, teknik, dan intervensi yang mendukung kemampuan tubuh ibu untuk menjalani persalinan dengan efisien, nyaman, dan aman. Berikut adalah aspek-aspek penting dari keseimbangan fisik dalam pertolongan persalinan:

1. Posisi Tubuh yang Optimal

- a. Variasi Posisi Persalinan: Ibu didorong untuk mencoba berbagai posisi seperti berjongkok, berdiri, berlutut, atau berbaring miring, tergantung pada kenyamanannya. Posisi ini dapat membantu melancarkan proses persalinan dengan:
 - 1) Mengurangi tekanan pada panggul.
 - 2) Membantu bayi menemukan posisi ideal untuk dilahirkan (optimal fetal positioning).
 - 3) Meningkatkan efektivitas kontraksi.
- b. Penggunaan Alat Bantu: Bola persalinan, kursi persalinan, atau tali persalinan dapat digunakan untuk membantu ibu menjaga keseimbangan dan kenyamanan(Choirunissa et al., 2021).

2. Teknik Pernapasan

- a. Pernapasan dalam dan teratur membantu ibu tetap rileks selama kontraksi, memastikan suplai oksigen yang cukup untuk ibu dan bayi.
- b. Teknik seperti hypnobirthing atau latihan pernapasan dari yoga kehamilan dapat membantu mengelola nyeri dengan lebih baik(Choirunissa et al., 2021)(Ayu et al., n.d.; Sandy et al., 2016; Swencionis et al., 2012; Yaqoob et al., 2024; Yarici & Rath, 2018).

3. Peran Gerakan Aktif

- a. Mobilitas Selama Persalinan: Berjalan, bergoyang pada bola persalinan, atau melakukan gerakan pinggul dapat membantu bayi turun ke jalan lahir lebih efektif(Dina et al., 2023).
- b. Manuver dan Peregangan: Pijatan ringan pada punggung bawah atau peregangan lembut dapat mengurangi ketegangan otot.

4. Pemanfaatan Gravitasi

- a. Posisi seperti jongkok atau berdiri memanfaatkan gravitasi untuk membantu bayi bergerak ke jalan lahir dengan lebih mudah(Apifah & Mulyana, 2025; Di et al., n.d.; Ii et al., 2018; Martini et al., 2016).
- b. Ini juga mengurangi kebutuhan intervensi medis seperti vakum atau forceps

5. Manajemen Nyeri Alami

- a. Kompres Hangat atau Dingin: Memberikan kehangatan di area punggung bawah atau perut untuk meredakan nyeri (Azizah & Riana Pascawati, 2023).
- b. Pijatan dan Akupresur: Menstimulasi titik-titik tertentu di tubuh untuk membantu meredakan ketegangan dan nyeri (Anita, 2018; Irianti & Karlinah, 2019; Sudjarwo & Solikhah, 2023).
- c. Water Birth atau Berendam: Air hangat dapat memberikan rasa rileks, mengurangi tekanan pada sendi, dan mengurangi rasa sakit.

6. Dukungan Nutrisi dan Cairan

- a. Selama persalinan, ibu harus tetap terhidrasi dengan baik untuk menjaga stamina.
- b. Makanan ringan yang mudah dicerna dapat membantu mempertahankan energi, terutama dalam persalinan yang berlangsung lama.

7. Peran Tenaga Medis dalam Menjaga Keseimbangan Fisik

- a. Pemantauan Kontraksi dan Detak Jantung: Tim medis memastikan ritme kontraksi tetap produktif dan memantau kesejahteraan bayi.
- b. Intervensi Minimal: Tim medis hanya melakukan intervensi (seperti pemberian oksitosin atau epidural) jika diperlukan, dengan tetap mendukung proses alami.
- c. Panduan Ergonomis: Membantu ibu menemukan posisi dan teknik yang paling sesuai untuk kondisi fisiknya.

8. Pemberdayaan Ibu untuk Mendengarkan Tubuhnya

- a. Memberi ruang bagi ibu untuk beristirahat ketika dibutuhkan, atau bergerak aktif sesuai dengan insting tubuhnya.
- b. Menghormati preferensi ibu dalam memilih metode persalinan, seperti water birth atau persalinan di tempat khusus (rumah atau fasilitas medis).

E. Keseimbangan mental dalam pertolongan persalinan

Keseimbangan mental dalam pertolongan persalinan adalah tentang menjaga kondisi emosional dan psikologis ibu agar tetap stabil, positif, dan fokus selama proses persalinan. Hal ini penting untuk membantu ibu mengatasi stres, ketakutan, atau kecemasan, sehingga proses persalinan dapat berjalan dengan lebih lancar. Berikut adalah komponen utama dalam menjaga keseimbangan mental selama persalinan:

1. Lingkungan yang Mendukung

- a. Suasana Nyaman dan Aman: Menciptakan ruang persalinan yang tenang, dengan pencahayaan lembut, musik relaksasi, atau aromaterapi yang membantu ibu merasa lebih rileks.

- b. Privasi dan Kebebasan: Memberikan ruang pribadi kepada ibu untuk merasa aman dan bebas berekspresi selama persalinan.

2. Dukungan Emosional

- a. Pendamping Persalinan: Kehadiran pasangan, keluarga, atau doula yang memberikan dukungan emosional sangat penting untuk menjaga kestabilan mental ibu. Pendamping dapat:
 - 1) Memberi semangat verbal (affirmasi)(Moloney & Gair, 2015; Sandy et al., 2016; Yaqoob et al., 2024).
 - 2) Membantu menenangkan ibu dengan sentuhan atau pijatan ringan.
- b. Empati dari Tenaga Medis: Pendekatan ramah dan empatik dari dokter, bidan, atau perawat dapat membantu ibu merasa didengar dan dihormati(Moloney & Gair, 2015).

3. Manajemen Ketakutan dan Kecemasan

- a. Edukasi Sebelum Persalinan: Informasi yang memadai tentang apa yang diharapkan selama proses persalinan membantu mengurangi ketakutan akan hal-hal yang tidak diketahui(Lailiyah, 2019).
- b. Teknik Relaksasi:
 - 1) Pernapasan Terpandu: Latihan pernapasan dalam dan teratur dapat membantu ibu tetap tenang selama kontraksi.
 - 2) Meditasi atau Visualisasi: Membayangkan tempat yang damai atau hasil positif dari persalinan dapat mengalihkan perhatian dari rasa sakit.
 - 3) Hypnobirthing: Teknik ini mengajarkan cara mengelola rasa takut dan nyeri dengan pemrograman pikiran yang positif(Ayu et al., n.d.; Nichlas et al., 2022; Norhapifah, 2020; Sandy et al., 2016; Swencionis et al., 2012; Yaqoob et al., 2024; Yarici & Rath, 2018).

4. Memberdayakan Ibu

- a. Memberikan Kendali:
 - 1) Melibatkan ibu dalam pengambilan keputusan selama persalinan (misalnya memilih posisi persalinan atau metode pengelolaan nyeri).
 - 2) Memberikan rasa bahwa ibu adalah tokoh utama dalam proses persalinannya, sehingga ia merasa berdaya dan percaya diri.
- b. Penggunaan Affirmasi Positif: Kata-kata seperti *"Tubuhku tahu apa yang harus dilakukan"* atau *"Aku mampu melahirkan dengan tenang"* dapat memperkuat mental ibu(Moloney & Gair, 2015; Sandy et al., 2016; Yaqoob et al., 2024).

5. Dukungan Spiritual

- a. Praktik Keagamaan atau Spiritualitas: Membawa elemen spiritual seperti doa, zikir, atau ritual yang sesuai dengan keyakinan ibu dapat memberikan rasa tenang dan keberanian.
- b. Mindfulness: Membantu ibu fokus pada momen saat ini tanpa terlalu terbebani oleh rasa sakit atau ketakutan akan komplikasi.

6. Mengelola Ekspektasi dan Rencana

- a. Fleksibilitas dalam Rencana Persalinan: Membantu ibu memahami bahwa perubahan rencana persalinan adalah hal yang wajar (misalnya jika persalinan normal berubah menjadi operasi caesar), sehingga ia tidak merasa gagal.
- b. Edukasi tentang Proses Persalinan: Menjelaskan tahapan persalinan secara sederhana dan jelas agar ibu tahu apa yang sedang terjadi pada tubuhnya.

7. Mengurangi Stres dari Lingkungan Eksternal

- a. Mengeliminasi tekanan dari pihak luar, seperti komentar negatif atau cerita persalinan yang menakutkan.
- b. Memberi ibu ruang untuk fokus pada dirinya sendiri tanpa gangguan.

8. Pasca Persalinan

Dukungan Mental Setelah Melahirkan: Setelah melahirkan, perhatian pada kesehatan mental ibu tetap penting. Memberikan waktu untuk pemulihan, mendengar cerita ibu tentang pengalaman persalinannya, dan memastikan ia merasa dihargai dapat memperkuat keseimbangan mentalnya.

9. Manfaat Keseimbangan Mental dalam Persalinan

- a. Membantu tubuh ibu bekerja lebih efektif karena hormon oksitosin dan endorfin, yang mendukung proses persalinan, dilepaskan dengan baik.
- b. Mengurangi risiko trauma persalinan atau depresi pascapersalinan.
- c. Memberikan pengalaman persalinan yang lebih positif dan penuh makna bagi ibu, bayi, dan keluarga.

F. Keseimbangan spiritual dalam pertolongan persalinan

Keseimbangan spiritual dalam pertolongan persalinan melibatkan aspek-aspek yang mendukung ibu secara rohani selama proses kelahiran. Spiritualitas dalam persalinan tidak hanya berkaitan dengan agama, tetapi juga mencakup perasaan kedamaian, koneksi mendalam dengan kehidupan, dan pemaknaan proses kelahiran sebagai momen sakral. Berikut adalah elemen-elemen penting dalam menciptakan keseimbangan spiritual selama persalinan:

1. Menjadikan Persalinan sebagai Pengalaman Sakral

- a. Pemaknaan Kelahiran: Proses persalinan dianggap sebagai momen istimewa yang melibatkan keajaiban kehidupan, sehingga ibu merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar.
- b. Rasa Syukur: Mengarahkan ibu untuk fokus pada rasa syukur terhadap tubuhnya, bayi, dan kesempatan menjadi bagian dari proses kehidupan.

2. Praktik Spiritual yang Mendukung

- a. Doa dan Zikir: Bagi ibu yang beragama, doa atau zikir selama persalinan dapat membantu menenangkan pikiran dan memperkuat rasa percaya pada kekuatan Tuhan.
- b. Meditasi dan Mindfulness: Membantu ibu tetap fokus pada momen saat ini dan menerima setiap tahap persalinan dengan tenang.
- c. Mantra Positif: Mengulang kata-kata penuh makna, seperti "Aku kuat, aku mampu," atau ayat-ayat tertentu dari kitab suci, dapat meningkatkan rasa percaya diri dan ketenangan.

3. Lingkungan yang Mendukung Spiritualitas

- a. Penciptaan Atmosfer Sakral:
 - 1) Memanfaatkan pencahayaan lembut, musik yang menenangkan, atau aroma tertentu (seperti minyak esensial lavender) untuk menciptakan suasana yang damai dan khusyuk.
 - 2) Jika memungkinkan, menyediakan ruang untuk praktik keagamaan atau refleksi spiritual sebelum dan sesudah persalinan.
- b. Elemen Tradisi atau Budaya: Mengintegrasikan ritual budaya yang mendukung, seperti pembacaan doa bersama keluarga atau penggunaan simbol tradisional untuk menciptakan rasa aman dan nyaman.

4. Koneksi Mendalam dengan Bayi

Membantu ibu membangun hubungan spiritual dengan bayi, seperti berbicara pada bayi atau mendoakannya selama proses persalinan. Hal ini menciptakan rasa keterhubungan yang memperkuat motivasi ibu dalam menghadapi tantangan persalinan.

5. Dukungan dari Pendamping dan Tenaga Medis

- a. Pendamping Spiritual: Kehadiran tokoh agama, keluarga, atau doula yang memahami aspek spiritual ibu dapat memberikan rasa nyaman dan menenangkan.
- b. Tenaga Medis yang Empatik: Pendekatan yang ramah dan penuh empati dari tenaga medis membantu ibu merasa dihormati dan didukung secara emosional dan spiritual.

6. Simbol atau Ritual

- a. Simbol Keagamaan atau Spiritualitas: Ibu dapat membawa benda simbolik seperti kitab suci, rosario, atau benda tradisional yang dianggap membawa kekuatan atau perlindungan.
- b. Ritual Tradisional: Ritual khusus yang relevan dengan budaya ibu, seperti pemberian doa oleh keluarga sebelum persalinan, dapat membantu menciptakan rasa damai.

7. Pemaknaan pada Ketidakpastian

- a. Penerimaan dan Keikhlasan: Proses persalinan sering kali tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Pendekatan spiritual mengajarkan penerimaan dan keikhlasan terhadap apapun hasilnya, dengan tetap percaya bahwa segalanya adalah bagian dari rencana yang lebih besar.
- b. Doa untuk Kekuatan dan Perlindungan: Ibu dapat didorong untuk memohon kekuatan dan perlindungan selama proses persalinan.

8. Refleksi Setelah Persalinan

- a. Syukur dan Penghormatan: Setelah persalinan, ibu diajak untuk merefleksikan pengalamannya, bersyukur atas keberhasilan prosesnya, dan memberikan penghormatan kepada dirinya sendiri.
- b. Ritual Pasca Persalinan: Beberapa budaya memiliki ritual pasca kelahiran untuk menghubungkan ibu dan bayi dengan komunitas atau keluarga, menciptakan rasa keterhubungan yang lebih luas

Manfaat Keseimbangan Spiritual dalam Persalinan

1. Membantu ibu merasa tenang dan percaya diri, sehingga tubuh dapat bekerja lebih efektif dalam proses persalinan.
2. Meningkatkan hormon positif seperti oksitosin dan endorfin, yang membantu mengurangi stres dan nyeri.
3. Memberikan rasa damai dan penguatan mental, terutama ketika menghadapi situasi sulit selama persalinan.
4. Memperkuat hubungan antara ibu, bayi, dan keluarga melalui makna spiritual yang mendalam.

G. Hambatan dalam pemberian pelayanan holistic

Dalam memberikan pelayanan holistik, bidan menghadapi sejumlah hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas penerapan pendekatan ini. Berikut adalah beberapa hambatan utama yang sering dihadapi:

1. Hambatan Pengetahuan dan Keterampilan

- a. Kurangnya Pelatihan Khusus: Tidak semua bidan memiliki pelatihan mendalam tentang pendekatan holistik, termasuk teknik seperti hypnobirthing, pijat prenatal, atau dukungan emosional intensif.
- b. Minimnya Pemahaman tentang Spiritualitas: Sebagian bidan mungkin tidak merasa cukup percaya diri untuk mendukung aspek spiritual atau emosional klien karena kurangnya pengalaman atau pelatihan.

2. Keterbatasan Waktu

- a. Beban Kerja yang Tinggi: Bidan sering kali harus melayani banyak pasien dalam waktu singkat, sehingga sulit untuk menyediakan perhatian penuh yang dibutuhkan dalam pelayanan holistik.
- b. Proses Administrasi: Tuntutan administratif yang berat dapat mengurangi waktu yang tersedia untuk memberikan perawatan yang personal dan menyeluruh.

3. Keterbatasan Sumber Daya

- a. Fasilitas yang Tidak Mendukung: Lingkungan kerja yang tidak nyaman, kurangnya ruang pribadi untuk persalinan, atau minimnya alat bantu seperti bola persalinan dan aromaterapi dapat menghambat pemberian pelayanan holistik.
- b. Keterbatasan Dukungan Teknologi dan Pendanaan: Beberapa fasilitas kesehatan mungkin tidak memiliki anggaran untuk pelatihan, alat, atau pengembangan pelayanan holistik.

4. Hambatan Budaya dan Keyakinan

- a. Ketidaksesuaian Nilai atau Tradisi: Beberapa ibu atau keluarga mungkin memiliki keyakinan atau tradisi yang bertentangan dengan pendekatan holistik. Misalnya, ketidakpercayaan terhadap metode non-medis atau tradisional.
- b. Stigma terhadap Metode Alternatif: Penggunaan teknik seperti meditasi, hypnobirthing, atau aromaterapi mungkin dipandang skeptis oleh sebagian masyarakat atau tenaga medis lainnya.

5. Kurangnya Dukungan dari Sistem Kesehatan

- a. Pendekatan Medis yang Dominan: Sistem kesehatan sering kali lebih fokus pada aspek medis dan prosedural daripada pendekatan menyeluruh yang mempertimbangkan kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual.
- b. Minimnya Kolaborasi Multidisiplin: Kurangnya kolaborasi antara bidan dengan tenaga profesional lain, seperti konselor, psikolog, atau ahli terapi alternatif, dapat membatasi pelayanan holistik.

6. Hambatan Psikologis pada Bidan

- a. Kurang Percaya Diri: Bidan yang merasa tidak yakin dengan kemampuan mereka untuk mendukung kebutuhan non-fisik klien mungkin cenderung fokus pada aspek medis saja.
- b. Burnout atau Stres Kerja: Beban kerja yang berat dan tekanan emosional dapat membuat bidan merasa lelah secara mental, sehingga sulit memberikan perhatian penuh pada kebutuhan holistik ibu.

7. Kurangnya Kesadaran Pasien

- a. Minimnya Pengetahuan Ibu: Beberapa ibu mungkin tidak memahami pentingnya pendekatan holistik dan hanya berfokus pada aspek fisik persalinan.
- b. Preferensi untuk Pendekatan Medis: Sebagian pasien lebih memilih pendekatan medis yang cepat dan langsung, mengabaikan manfaat dukungan emosional, mental, atau spiritual.

8. Hambatan Regulasi dan Kebijakan

- a. Kebijakan yang Tidak Mendukung: Kurangnya kebijakan yang mengatur dan mempromosikan pendekatan holistik dalam layanan kesehatan.
- b. Standar Pelayanan yang Terbatas: Standar pelayanan bidan sering kali lebih menekankan pada pencapaian target fisik dan medis, bukan pada kebutuhan holistik ibu.

H. Strategi meningkatkan

1. Pelatihan dan Edukasi: Menyediakan pelatihan berkelanjutan tentang pendekatan holistik bagi bidan.
2. Manajemen Waktu dan Beban Kerja: Mengatur jadwal kerja yang lebih seimbang untuk memberi ruang bagi pelayanan yang lebih personal.
3. Dukungan Sistem Kesehatan: Meningkatkan fasilitas dan alat yang mendukung pendekatan holistik.
4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Mengedukasi ibu hamil dan keluarga tentang manfaat pelayanan holistik melalui kelas prenatal atau penyuluhan.
5. Kolaborasi Multidisiplin: Melibatkan tenaga profesional dari berbagai disiplin ilmu untuk mendukung pelayanan holistik secara komprehensif.

I. Kesimpulan

Persalinan adalah hal yang fisiologis yang di alami oleh setiap wanita. Wanita adalah makhluk yang unik dan holistic. Maka dalam hal ini dalam pertolongan persalinan juga harus dilaksanakan dengan memberikan asuhan yang holistic meliputi aspek fisik, emosional dan spiritual agar memberikan hasil yang optimal.

J. Referensi

- Anita, A. (2018). Pengaruh Akupresur Lo4 (he kuk) dan Thai Cong terhadap Tingkat Nyeri Persalinan Kala I pada Ibu Bersalin. *Jurnal Kesehatan*, 9(3), 471. <https://doi.org/10.26630/jk.v9i3.1166>
- Apifah, S., & Mulyana, D. S. (2025). DENGAN POSISI JONGKOK TERHADAP PROGRES PERSALINAN DAN KEPUASAN IBU DI PUSKESMAS SAKETI TAHUN 2024. 9(7), 1024–1028.
- Ayu, R., Harsachatri, D. O., Mahendika, D., & Prihartini, S. (n.d.). THE EFFECT OF HYPNOBIRTHING ON THE ANXIETY LEVEL OF PREGNANT WOMEN IN TRIMESTER III IN THE WORKING AREA OF THE PROUDE I HEALTH CENTER , PROUDE DISTRICT . 66–74.
- Azizah, M. J., & Riana Pascawati. (2023). Evidance Based Case Report (Ebcr) : Pengaruh Kompres Air Hangat Terhadap Penurunan Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif. *Jurnal Kesehatan Siliwangi*, 3(3 SE-), 420–431. <https://jurnal.polkesban.ac.id/index.php/jks/article/view/1219>
- Choirunissa, R., Widowati, R., & Nabila, P. (2021). Peningkatan Pengetahuan Tentang Terapi Birth Ball Untuk Pengurangan Rasa Nyeri Persalinan Di Klinik P Kota Serang. 4(1), 219–224.
- Crowther, S., & Hall, J. (2015). Spirituality and spiritual care in and around childbirth. *Women and Birth*, 28(2), 173–178. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2015.01.001>
- Di, P., Ny, B. P. M., & Kota, M. S. (n.d.). HUBUNGAN ANTARA POSISI MIRING KIRI DENGAN PROSES MEMPERCEPAT PENURUNAN KEPALA JANIN PADA PROSES. 60–64.
- Dina, K. F., Altika, S., Hastuti, P., Kebidanan, P. S., Bakti, S., & Pati, U. (2023). HUBUNGAN TERAPI BIRTH BALL DENGAN KEMAJUAN PERSALINAN KALA I. 14(1), 35–41.
- Evi Pratami, M. K. (2014). *Konsep Kebidanan Berdasarkan Kajian Filosofi dan Sejarah*.
- Ii, K., Bpm, D. I., Babat, E., & Anggeni, U. (2018). Perbedaan posisi persalinan setengah duduk dengan posisi jongkok terhadap lamanya kala ii di bpm erniwaty babat supat. 9(18), 113–122.
- Irianti, B., & Karlinah, N. (2019). Pengaruh Akupresur Terhadap Intensitas Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif Di Bidan Praktik Mandiri Rahmadina Rosa Tahun 2019. *Prosiding Hang Tuah Pekanbaru*, 59–64. <https://doi.org/10.25311/prosiding.vol1.iss1.16>
- Lailiyah, S. R. (2019). Efektifitas Teknik Relaksasi Nafas Dalam dan Pijatan Effleurage terhadap penurunan skala nyeri pada post sectio caesarea. *NURSING UPDATE: Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan P-ISSN: 2085-5931 e-ISSN: 2623-2871*, 1(1), 61–69. <https://doi.org/10.36089/nu.v1i1.37>
- Mandiri, J. S., & Harahap, D. A. (2024). MASSAGE THERAPY PRENATAL SEBAGAI INTERVENSI MENGURANGI KECEMASAN PADA IBU PRIMIGRAVIDA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BANGKINANG KOTA , PROVINSI RIAU. 19(1), 299–307.
- Martini, T., Keb, S. S. T., Damayanti, W., Fratidhina, Y., & Kes, M. (2016). PERBEDAAN POSISI

MIRING DENGAN POSISI SETENGAH DUDUK TERHADAP KEMAJUAN PERSALINAN KALA II PADA MULTIPARA DI PUSKESMAS BALARAJA TAHUN 2016 Abstrak. 361–365.

- Moloney, S., & Gair, S. (2015). Empathy and spiritual care in midwifery practice: Contributing to women's enhanced birth experiences. *Women and Birth*, 28(4), 323–328. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2015.04.009>
- Nichlas, E., Yustian Ananti, & Tri Budy Rahayu. (2022). Efektifitas Hypnobirthing Terhadap Penurunan Nyeri Persalinan: Systematic Literatur Review. *Jurnal Indonesia Sehat*, 1(3), 205–215.
- Norhapifah, H. (2020). Pengaruh Teknik Hypnobirthing Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Pada Ibu Bersalin. *Jurnal Medika: Karya Ilmiah Kesehatan*, 5(1). <https://doi.org/10.35728/jmkik.v5i1.119>
- Sandy, P., Imannura, U., Budhiastuti, U. R., & Poncorini, E. (2016). *The Effectiveness of Hypnobirthing in Reducing Anxiety Level During Delivery*. 1, 200–204.
- Statement, P. (2012). Keeping Birth Normal. *International Journal of Childbirth*, 2(2), 146–148. <https://doi.org/10.1891/2156-5287.2.2.146>
- Sudjarwo, E., & Solikhah, K. (2023). Pengaruh Penerapan Terapi Akupresur terhadap Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Operasi Sectio Caesarea (SC) Acupressure Therapy to Pain Levels in Post-C-section (SC) Patients Poltekkes Kemenkes Malang (Co Author: eddi@poltekkes-malang.ac.id). *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan Dr. Soetomo*, 9(1), 1–9. www.jurnal.tikes-yrsds.ac.id
- Swencionis, C., Rendell, S. L., Dolce, K., Massry, S., & Mongan, M. (2012). *Outcomes of HypnoBirthing*. 27(2), 120–139.
- Ulfah, D., Ratnasari, F., Elviani, Y., Fatimah, S., Sumartini, S., Hamil, K. I., Prenatal, P., Anxiety, M., & Care, P. (2024). *Penggunaan teknik relaksasi untuk mengurangi kecemasan pada ibu hamil selama proses persalinan*. 7, 9931–9935.
- Yaqoob, H., Ju, X., Jamshaid, S., Yaqoob, H., Ju, X., & Jamshaid, S. (2024). *Hypnobirthing Training for First-Time Mothers: Pain , Anxiety and Postpartum Wellbeing* *Hypnobirthing Training for First-Time Mothers : Pain , Anxiety and Postpartum Wellbeing*. <https://doi.org/10.2147/PRBM.S465361>
- Yarici, F., & Rath, G. (2018). *Complementary Therapies in Clinical Practice The effect of hypnobirthing training given in the antenatal period on birth pain and fear*. 33(August), 3881.

K. Glosarium

Acupressure : Tekik pengobatan tradisional tingkok yang dilkaukan dengan menekan titik-titik tertentu di tubuh.

Afirmasi : Penetapan yang positif seperti penegasan atau peneguhan yang berkaitan dengan sesuatu yang positif

Ahli terapi alternative : praktisi yang memberikan pengobatan komplementer atau alternatif

Aromaterapi : terapi yang menggunakan minyak essensial dari tanaman untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan

Aromaterapi : Terapi yang menggunakan minyak essensial untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan tubuh, pikiran dan jiwa. Aroma terapi dapat digunakan sebagai perawatan alternative untuk berbagai kondisi kesehatan.

Doa : Permohonan, harapan, atau pujian kepada Tuhan

Doula : Pendampingan profesional yang memberikan dukungan fisik dan emosional selama kehamilan. Persalinan, dan setelah melahirkan.

Dukun bersalin : orang yang membantu proses persalinan, merawat ibu dan bayi, serta mendampingi ibu hamil.

Ekspektasi : Segenap keinginan, harapan dan cita-cita mengenai sesuatu hal yang ingin diraih dengan adanya tingkah laku dan tindakan yang secara nyata.

Emosional: keadaan yang menunjukkan perasaan atau emosi. Emosi merupakan perasaan yang muncul sebagai respon terhadap situasi tertentu. Emosi dapat memengaruhi pikiran, perilaku, dan persepsi seseorang.

Empatik : Sikap memahami perasaan, pikiran, dan pengalaman orang lain

Endorphin : hormone yang diproduksi oleh tubuh untuk meredakan rasa dan meningkatkan perasaan senang

Epidural : Teknik anestesi yang dilakukan dengan menyuntikkan obat bius ke punggung untuk menghilangkan rasa sakit.

Ergonomic : Ilmu mempelajari interaksi antara manusia dengan lingkungan kerja, peralatan, dan mesin.

Fisik : Jasmani

Holistic : cara pandang yang menyeluruh, terintegrasi dan kompleks. Kata holistic berasal dari Bahasa Inggris holistic yang berarti keseluruhan

Hypnobirthing : teknik relaksasi dan manajemen nyeri yang digunakan selama kehamilan dan persalinan

Keyakinan : sikap subjektif yang percaya bahwa sesuatu benar

Konselor : seorang profesional yang memberikan layanan konseling pada klien.

Manuver : Prosedur atau tindakan yang mengubah arah

Meditasi : Teknik relaksasi yang bertujuan untuk menjernihkan pikiran dan meningkatkan konsentrasi

Meditasi : teknik relaksasi yang dilakukan dengan cara mengatur pernapasan dan memusatkan pikiran.

Mental : Berkaitan dengan batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan atau tenaga: bukan hanya pembangunan fisik yang diperhatikan, melainkan juga pembangunan

Mindfulness : Teknik untuk meraih kesadaran dan fokus pada momen saat ini,

tanpa menghakimi

Nyeri : Perasaan tidak nyaman yang disebabkan oleh kerusakan jaringan atau potensi karesakan jaringan

Oksitosin : hormone pada manusia yang berfungsi untuk merangsang kontraksi yang kuat pada dinding rahim/[uterus](#) sehingga mempermudah dalam membantu proses kelahiran. Selain itu, Hormon ini juga berfungsi untuk mensekresi air susu dengan merangsang kontraksi [duktus laktiferus](#) kelenjar mammae (payudara) pada ibu menyusui. Namun, produksi air susu tersebut diatur oleh hormon [prolaktin](#)

Persalinan : Proses pengeluaran janin dan plasenta dari Rahim ibu melalui vagina

Pijat prenatal : Pijat yang dilakukan pada ibu hamil untuk membantu meredakan ketegangan dan nyeri otot, serta meningkatkan sirkulasi darah

Pijatan : Terapi kesehatan tradisional yang dilakukan dengan memberikan tekanan pada tubuh. Pijat dilakukan dengan cara menekan, mengurut, atau menggosok jaringan otot dan kulit. Pijat dapat dilakukan secara manual atau dengan alat mekanis.

Psikolog : ahli yang mempelajari perilaku dan kesehatan mental manusia

Relaksasi : Proses untuk merelaksasikan otot dan pikiran agar tubuh dan pikiran menjadi lebih seimbang dan stabil

Religious : Bersifat keagamaan, bersifat religi atau yang berkaitan dengan religi.

Ritual : Serangkaian tindakan atau upacara yang dilakukan berdasarkan aturan tertentu seringkali dalam konteks keagamaan atau budaya

Skeptis : sikap meragukan atau tidak percaya terhadap suatu hal, gagasan, atau pernyataan

Spiritualitas : Pengalaman manusia yang berkaitan dengan makna, tujuan dan moralitas

Stress : Reaksi fisik dan emosional yang muncul ketika seseorang menghadapi perubahan lingkungan, tekanan, atau ancaman.

Symbol :Tanda yang mewakili suatu gagasan, objek, atau konsep. Simbol sering berupa objek kata, atau tindakan yang memiliki arti tertentu.

Tradisional : Sikap, cara berfikir dan bertindak yang berpegang teguh pada norma dan adat istiadat yang di wariskan secara turun-temurun

Visualisasi : Proses mengubah data atau gagasan menjadi gambar, diagram, grafik, atau peta untuk mempermudah pemahaman.

WUS: Wanita Usia Subur

Yoga : Olahraga yang menggabungkan gerakan tubuh, pernafasan, meditasi, dan relaksasi untuk menyeimbangkan pikiran, tubuh, dan jiwa.

Zikir : kegiatan mengingat dan memuji Allah SWT secara terus-menerus

CHAPTER 6

PERAN TEKNOLOGI DALAM MEMANTAU PERSALINAN NORMAL

Wira Meiriza, S.ST., M.Keb.

A. Pendahuluan

Kondisi transformasi digital kesehatan telah menjadi topik yang hangat dalam beberapa tahun terakhir ini, bahkan dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang dan telah menyentuh hampir semua aspek kehidupan. Dalam konteks kesehatan, transformasi digital merujuk pada perubahan yang terjadi dalam sistem dan praktik kesehatan karena adopsi teknologi digital dan inovasi. Transformasi digital kesehatan merupakan suatu perjalanan yang sedang berlangsung dengan potensi luar biasa untuk membawa perubahan positif dalam industri kesehatan dan kehidupan pasien. Untuk memaksimalkan manfaat dan mengatasi tantangan, penting bagi semua pihak yang terlibat termasuk penyedia layanan kesehatan, industri teknologi, pemerintah, dan pasien untuk berkolaborasi dan berkomitmen dalam menciptakan masa depan kesehatan yang lebih cerdas, efisien, dan inklusif. Teknologi digital mengubah bidang kesehatan, khususnya pelayanan publik. Pemerintah meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat sebagai bentuk memperbaiki pelayanan kesehatan publik. Pada era digitalisasi ini, teknologi memegang peranan penting dalam peningkatan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan (Purba et al., 2024).

Dengan adanya kemajuan teknologi yang dibawa dan dikenalkan dari negara maju, menyebabkan adanya perubahan yang terlihat dari sistem pelayanan yang mulai bergeser menjadi lebih modern (Eprilianto et al., 2019). Kemajuan dalam bidang kesehatan ini sangat berkembang dengan begitu pesat, sehingga banyak temuan-temuan yang didapatkan dengan bantuan Teknologi Informasi baik dalam bidang pengorganisasian rumah sakit, pengobatan, maupun penelitian pengembangan dari ilmu kesehatan itu sendiri. Pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi tengah mendapat banyak perhatian dunia (Zahra et al., 2023).

Kemajuan teknologi yang pesat juga akan memunculkan berbagai revolusi baru untuk melihat model transisi dari kinerja tradisional menjadi kinerja digital. Perkembangan teknologi informasi juga tidak kalah penting sebagai pendorong globalisasi. Pemerintah telah menerapkan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, mengingat bahwa teknologi yang semakin

pesat pasti akan mempengaruhi kualitas dari suatu pelayanan (Purba et al., 2024).

Beberapa bentuk penerapan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan publik adalah adanya berbagai inovasi seperti platform online, telemedicine, aplikasi mobile, big data analytics, kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan Internet of Things (IoT). Dengan bantuan teknologi ini, individu dapat dengan mudah mengakses informasi kesehatan, melakukan konsultasi jarak jauh dengan tenaga medis, mengelola catatan medis elektronik, serta memantau kondisi kesehatan secara mandiri (Nugroho et al., 2023). Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk diaplikasikan khususnya dalam memberikan asuhan kebidanan.

B. Manfaat Teknologi Dalam Pelayanan Kesehatan

Dengan adanya pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan, terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh, meliputi :

1. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Teknologi digital memungkinkan pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan secara fisik, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas atau berada di daerah terpencil.

2. Meningkatnya efisiensi pelayanan kesehatan.

Penggunaan teknologi digital mengurangi waktu tunggu, mempercepat proses pemeriksaan dan diagnosis, serta mempermudah koordinasi antarprofesional medis.

3. Meningkatnya akurasi dan keselamatan pelayanan.

Sistem informasi kesehatan elektronik meminimalisir risiko kesalahan dalam pengelolaan data pasien, termasuk kesalahan dalam memberikan pengobatan atau diagnosa.

4. Meningkatnya partisipasi pasien dalam pengelolaan kesehatan.

Aplikasi kesehatan dan perangkat wearable memungkinkan pasien untuk memantau dan mengelola kesehatan pribadi mereka secara aktif (Nugroho et al., 2023).

C. Tantangan Dalam Implementasi Pemanfaatan Teknologi Digital

Beberapa tantangan yang muncul dalam implementasi pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan infrastruktur dan koneksi internet yang memadai

Implementasi teknologi digital memerlukan infrastruktur yang memadai dan akses internet yang stabil. Tantangan ini terutama dialami di daerah pedesaan atau terpencil di mana ketersediaan infrastruktur dan konektivitas mungkin terbatas.

2. Kekhawatiran privasi dan keamanan data pasien

Penggunaan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan melibatkan pertukaran dan penyimpanan data pasien. Keamanan dan privasi data menjadi perhatian utama, terutama dengan meningkatnya ancaman keamanan cyber. Perlindungan data pasien yang memadai dan kepatuhan terhadap regulasi privasi menjadi tantangan penting yang harus diatasi.

3. Kurangnya keterampilan teknologi dari pihak tenaga medis

Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan membutuhkan pemahaman dan keterampilan teknologi yang memadai dari pihak tenaga medis. Kurangnya keterampilan ini dapat menghambat adopsi dan penggunaan teknologi secara efektif.

4. Kurangnya pemahaman teknologi dari masyarakat umum

Masyarakat juga perlu memiliki pemahaman dan literasi teknologi yang memadai untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan digital. Tantangan ini termasuk kurangnya pemahaman tentang aplikasi kesehatan, telemedicine, dan cara memanfaatkannya dengan baik.

5. Tantangan regulasi dan kepatuhan

Pengembangan dan implementasi teknologi digital dalam pelayanan kesehatan juga dihadapkan pada tantangan regulasi yang kompleks. Kebijakan dan regulasi yang jelas perlu dihadirkan untuk mengatur penggunaan dan perlindungan data, telemedicine, serta aspek hukum lainnya yang terkait.

6. Penyesuaian budaya dan sikap terhadap teknologi

Perubahan budaya dan sikap terhadap penggunaan teknologi juga merupakan tantangan dalam implementasi. Penerimaan dan adopsi teknologi yang luas dari pihak tenaga medis dan masyarakat memerlukan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang inklusif terhadap inovasi digital.

7. Tantangan finansial

Implementasi teknologi digital dalam pelayanan kesehatan membutuhkan investasi yang signifikan, termasuk pengadaan perangkat keras, pengembangan aplikasi, dan pelatihan tenaga medis. Tantangan finansial ini dapat menjadi hambatan dalam memperluas pemanfaatan teknologi digital di berbagai fasilitas kesehatan.

8. Pengintegrasian sistem dan interoperabilitas

Dalam lingkungan pelayanan kesehatan yang kompleks, tantangan integrasi dan interoperabilitas sistem muncul. Sistem dan aplikasi yang berbeda perlu dapat berkomunikasi dan berbagi informasi secara efektif untuk mencapai pengelolaan data yang terkoordinasi dan pelayanan yang terpadu.

9. Ketidaksetaraan akses dan kesenjangan teknologi

Implementasi teknologi digital harus memperhatikan kesenjangan akses dan kesenjangan teknologi yang ada di masyarakat. Tantangan ini meliputi akses terbatas ke perangkat digital dan internet, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan seperti penduduk pedesaan, orang tua, dan golongan ekonomi lemah.

10. Penerimaan dan adopsi oleh pihak tenaga medis

Kesuksesan implementasi teknologi digital dalam pelayanan kesehatan juga tergantung pada penerimaan dan adopsi teknologi oleh pihak tenaga medis. Tantangan ini melibatkan perubahan pola pikir, dukungan pelatihan yang memadai, dan keterlibatan aktif dari pihak tenaga medis dalam proses implementasi (Nugroho et al., 2023).

D. Peran Teknologi Dalam Memantau Persalinan Normal

Persalinan adalah proses pergerakan keluarnya janin, plasenta dan membran dari dalam rahim melalui jalan lahir. Proses ini dimulai dari adanya pembukaan dan dilatasi serviks yang diakibatkan karena kontraksi uterus dengan frekuensi, durasi, dan kekuatan yang teratur. Persalinan akan dianggap normal jika prosesnya terjadi pada usia cukup bulan (setelah 37 minggu) tanpa disertai dengan penyulit (Yuriati & Khoiriyah, 2021).

Kehamilan dan kelahiran bayi yang sehat merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam siklus kehidupan dengan menghasilkan bayi dan ibu yang sehat. Kendala yang paling signifikan adalah bahwa sebagian besar kematian janin terjadi di dalam rahim. Penyebab utama kematian janin ini adalah hipoksia kronis yang menyebabkan retardasi pertumbuhan intrauterin, komplikasi ibu, malformasi janin kongenital, dan kelainan kromosom. Sementara faktor ibu dapat dengan mudah dideteksi dan ditangani, komplikasi janin memerlukan tingkat kemampuan diagnostik dan manajemen yang lebih tinggi (Jain & Acharya, 2022).

Penggunaan teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam memantau persalinan normal. Penyediaan alat dan sistem pada teknologi ini dapat membantu tenaga kesehatan dalam memastikan keselamatan ibu dan bayi selama proses persalinan. Berikut ini beberapa peran teknologi dalam memantau persalinan normal :

1. Pemantauan Pada Ibu

a. Pemantauan Tekanan Darah

Tekanan darah ibu harus dipantau secara teratur untuk mendeteksi tanda-tanda hipertensi dan preeklamsia. Tanda-tanda ini dapat mempengaruhi kemampuan ibu untuk melahirkan secara normal. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dapat menimbulkan komplikasi yang membahayakan ibu dan

janin. Oleh karena itu, memantau tekanan darah sangatlah penting. Pemantauan tekanan darah otomatis merupakan teknologi yang sangat berguna untuk memantau tekanan darah ibu, seperti Monitor Tekanan Darah Digital atau tensimeter digital.

b. Pemantauan Kontraksi Uterus

Kontraksi rahim merupakan bagian penting dalam pemantauan kehamilan. Kontraksi rahim adalah tanda alami kehamilan dan terjadi saat tubuh bersiap untuk melahirkan. Namun, pemantauan yang cermat diperlukan untuk mendeteksi kontraksi yang tidak normal atau berpotensi berbahaya.

Beberapa perangkat Internet of Things (IoT) yang dapat melacak nyeri persalinan ibu hamil menggunakan sensor yang dapat ditempatkan di perut ibu hamil untuk melacak kontraksi rahim. Data yang dikumpulkan oleh sensor ini dapat membantu meningkatkan layanan kesehatan jika diproses, dianalisis, dan dibagikan dengan cara yang dapat dimengerti oleh ibu hamil dan petugas kesehatan. Menggunakan teknologi IoT untuk pemantauan kontraksi tidak hanya menyediakan data yang lebih akurat tetapi juga memungkinkan pemantauan terintegrasi dan secara real-time.

Teknologi yang digunakan sistem berbasis IoT ini adalah elektromiografi (EMG). Elektromiograf adalah alat yang merekam sinyal yang dipancarkan otot saat berkontraksi dan berelaksasi. Ketika otot berkontraksi dan berelaksasi, potensial listrik dihasilkan. Potensial ini direkam oleh elektromiograf dan digunakan untuk memantau aktivitas otot. Alat ini dapat memantau kontraksi ibu hamil yang akan melahirkan, sehingga menghilangkan kebutuhan tenaga medis untuk terus-menerus memeriksa perut ibu. Perancangan alat pemantauan ini menggunakan WeMos D1 Mini yang berfungsi sebagai sistem kendali perangkat keras dan pengontrol pada platform IoT (Romadhoni et al., 2024).

2. Pemantauan Pada Janin

Pemantauan kesejahteraan janin merupakan hal yang sangat penting dilakukan sebagai pengawasan janin saat asuhan antenatal dan pada saat persalinan. Adapun tujuan dilakukan monitoring pada janin adalah sebagai berikut :

a. Mengetahui lebih dini kelainan dan komplikasi pada janin

Saat melahirkan, perlu dilakukan pemantauan kesejahteraan janin secara rutin. Jika ibu merasa gerakan janin menurun dan denyut jantung janin menurun (kurang dari 120 denyut/menit) atau meningkat (lebih dari 160 denyut/menit), sebaiknya dokter kandungan segera mengambil tindakan untuk mencegah komplikasi pada janin . .

b. Menghindari intervensi yang tidak perlu selama persalinan.

Memantau detak jantung janin (DJJ) selama persalinan dapat sangat membantu dalam memberikan perawatan yang diperlukan. Jika detak jantung janin masih dalam kisaran normal, intervensi yang tidak perlu seperti pemberian oksigen tidak diperlukan.

c. Mencegah kematian janin

Pemantauan denyut jantung janin, gerakan janin dan moulase sutura janin, membantu dalam pengambilan keputusan klinik. Jika ditemukan kelainan, maka dapat segera ditangani untuk mencegah terjadinya kematian janin (Badawi et al., 2024).

Teknologi telah memberikan berbagai kontribusi yang sangat positif dalam meningkatkan layanan persalinan normal. Salah satu contoh penggunaan teknologi yang telah membawa manfaat besar adalah pada penilaian kesejahteraan janin selama persalinan. Penilaian ini dilakukan untuk memantau perkembangan janin dari waktu ke waktu. Manfaat terpenting dari penilaian kesejahteraan janin adalah jika ditemukan adanya tanda-tanda masalah pada kondisi janin, tindakan segera harus diambil untuk memperbaiki masalah tersebut. Langkah-langkah yang diambil seringkali bersifat mendasar, seperti : mencakup tirah baring bagi ibu, pengawasan janin lanjutan, terapi obat, persalinan darurat, perawatan intensif neonatal dan dalam kasus yang tidak menguntungkan (Jain & Acharya, 2022).

Salah satu dari komponen pemantauan kesejahteraan janin atau kondisi janin adalah menilai detak jantung janin. Detak jantung janin selama Kala I dan kala II persalinan dinilai dan dicatat setiap 30 menit. Tindakan ini dapat dilakukan lebih sering jika ada tanda-tanda gawat janin. DJJ normal berkisaran 120-160x/menit. Jika kondisi DJJ berada pada kisaran ini, maka tidak ada intervensi yang akan dilakukan. Jika DJJ dibawah 120x/menit atau diatas 160x/menit bidan harus segera bertindak yang menunjukkan bahwa adanya tanda awal gawat janin. Tanda gawat janin dengan DJJ < 100x/menit atau >180x/menit dapat terjadi selama persalinan. Kondisi ini memerlukan asuhan segera meliputi : posisikan ibu miring kiri, anjurkan narik nafas panjang dan pada saat Kala II minta ibu berhenti meneran, berikan minum dan lakukan resusitasi intrauterin, dan nilai ulang DJJ setelah 5 menit (jika DJJ normal, minta ibu untuk meneran kembali saat kontraksi, dan pastikan ibu tetap dalam posisi miring. Jika DJJ masih abnormal, siapkan ibu untuk dirujuk, dan dampingi ibu saat merujuk) (Badawi et al., 2024).

Berikut teknologi yang digunakan dalam pemantauan kesejahteraan janin :

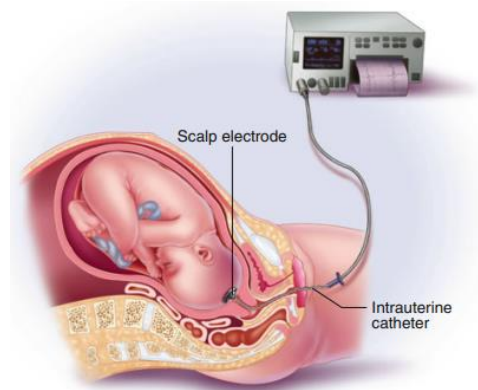
a. Teknologi Tindakan Invasif

1) Internal Elektronik Fetal monitoring

Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara pemeriksaan langsung pada kulit kepala janin, melalui pemecahan selaput ketuban, Hasilnya berupa grafik gambar EKG (elektrokardiografi) berupa gelombang P, QRS, dan T. Gambar yang muncul berupa grafik dan dapat menunjukkan keadaan denyut jantung janin normal atau abnormal.

2) Internal Contraction Monitoring

Ini adalah tindakan invasif dengan cara memecahkan selaput ketuban. Pemeriksaan tekanan intra uterin langsung didalam ketuban. Teknologi ini digunakan ketika dokter tidak mendapatkan hasil yang baik dari pemeriksaan eksternal electronic monitoring biasa dikenal dengan Non Stress Test. Dokter akan memasang elektroda ke bagian tubuh bayi yang paling dekat dengan pembukaan serviks, biasanya adalah kepala bayi. Dokter juga akan menyisipkan kateter tekanan kedalam rahim untuk memantau kontraksi (Faradisa et al., 2017).



Gambar 6.1 Internal fetal heart rate monitoring

Sumber : (Ganti, 2022)

b. Teknologi Tindakan Non-Invasif

1) Pemeriksaan Non Stress Test (NST)

Pemeriksaan Non Stress Test adalah cara pemeriksaan kesejahteraan janin yang merupakan tindakan non-invasif, yaitu teknologi medis yang dilakukan dari luar tubuh tanpa memerlukan sayatan atau memasukkan instrumen/ alat ke dalam tubuh. Pemeriksaan ini berfungsi sebagai alat skrining untuk menilai kesehatan janin dengan mengukur detak jantung janin dan respon terhadap gerakan janin, untuk memastikan pasokan oksigen yang cukup. Prosedur yang aman dan tidak menimbulkan rasa sakit ini tidak menimbulkan stres pada ibu ataupun janin. Pemeriksaan ini dapat dilakukan pada saat kehamilan maupun saat persalinan.

Fungsi dari NST adalah sebagai berikut :

- a) Pemeriksaan NST dilakukan untuk menilai denyut jantung janin (DJJ) dalam hubungannya dengan gerakan atau aktivitas janin. Penilaian NST dilakukan terhadap frekuensi dasar DJJ (baseline), variabilitas (variability) dan munculnya akselerasi yang sesuai dengan gerakan/ aktivitas janin (Fetal Activity Determination / FAD).
- b) Pemeriksaan NST dilakukan untuk menentukan apakah bayi merespon stimulus secara normal dan apakah bayi menerima cukup oksigen. Biasanya dilakukan pada usia kehamilan minimal 26-28 minggu, atau kapanpun tergantung dengan kondisi bayi.
- c) Pemeriksaan NST yang dinilai adalah gambaran DJJ dalam hubungannya dengan gerakan atau aktivitas janin. Pada janin sehat dan bergerak aktif dapat dilihat peningkatan frekuensi denyut jantung janin. Namun, bila janin kurang baik, pergerakan bayi tidak diikuti oleh peningkatan frekuensi denyut jantung janin.

Aktifitas dinamika jantung dipengaruhi oleh sistem saraf otonom yaitu sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Jika oksigenasi jantung normal, bunyi jantung dasar dan variabilitas dari jantung janin akan normal. Jika simpanan nutrisi plasenta (oksigen) cukup, maka stres intrinsik (gerakan janin) akan menghasilkan akselerasi bunyi jantung janin, dan stres ekstrinsik (kontraksi rahim) tidak akan mengakibatkan deselerasi.

Cara membaca pemeriksaan NST adalah :

- a) Reaktif, jika:

Denyut jantung basal antara 120-160 kali per menit, Variabilitas denyut jantung 6 atau lebih per menit, Gerakan janin terutama gerakan multipel dan berjumlah 5 gerakan atau lebih dalam 20 menit, reaksi denyut jantung terutama akselerasi pola "omega" pada NST yang reaktif berarti janin dalam keadaan sehat, pemeriksaan diulang 1 minggu kemudian. Pada pasien diabetes melitus tipe IDDM pemeriksaan NST diulang tiap hari, tipe yang lain diulang setiap minggu.

- b) Tidak reaktif, jika:

Denyut jantung basal 120-160 kali per menit, Variabilitas kurang dari 6 denyut /menit, Gerak janin tidak ada atau kurang dari 5 gerakan dalam 20 menit, dan Tidak ada akselerasi denyut jantung janin meskipun diberikan rangsangan dari luar.

- c) Sinusoidal, jika:

Ada osilasi yang persisten pada denyut jantung asal, Tidak ada gerakan janin, Tidak terjadi akselerasi, janin dalam keadaan bahaya. Bila paru-paru janin matur, janin dilahirkan. Gambaran ini didapatkan pada

keadaan isoimunisasi-RH.

d) Hasil pemeriksaan NST disebut abnormal (baik reaktif ataupun non reaktif) apabila ditemukan :

Bradikardi, deselerasi 40 atau lebih di bawah (baseline), atau DJJ mencapai 90 dpm, yang lamanya 60 detik atau lebih.

Pada pemeriksaan ini sebaiknya dilakukan terminasi kehamilan bila janin sudah viable atau pemeriksaan ulang setiap 12-24 jam bila janin belum viable. Hasil NST yang reaktif biasanya diikuti oleh keadaan janin yang masih baik sampai 1 minggu kemudian (spesifitas sekitar 90%), oleh karena itu pemeriksaan ulang dianjurkan 1 minggu kemudian. Namun jika ada faktor resiko seperti hipertensi/gestosis, DM, pendarahan atau oligohidramnion hasil NST yang reaktif tidak menjamin bahwa keadaan janin akan masih tetap baik hingga 1 minggu kemudian, sehingga pemeriksaan ulang harus lebih sering (dibawah 1 minggu). Menurut beberapa ahli pemeriksaan NST tidak diperlukan pada kehamilan beresiko rendah. Pemeriksaan NST ini mengharuskan pasien tetap diam, gerakan akan mengganggu sinyal dan pembacaan mesin yang tidak akurat (Badawi et al., 2024).

2) Auskultasi

Teknologi auskultasi yang digunakan untuk pemeriksaan frekuensi denyut jantung janin adalah berupa stetoskop manual ataupun stetoskop digital. Stetoskop manual yang biasa digunakan untuk pemeriksaan DJJ yaitu stetoskop pinard dan fetoscope, sedangkan untuk stetoskop digital akan menghasilkan yang dinamakan fPCG (Badawi et al., 2024).

a) Menggunakan stetoskop Pinard/ Laennec atau monoaural

Stetoskop pinard merupakan metode awal yang digunakan untuk memantau kesejahteraan janin selama persalinan, dengan menghitung detak jantung janin secara teratur. Stetoskop yang dirancang khusus untuk dapat mendengarkan detak jantung janin secara manual oleh pemeriksa setiap kali melakukan pemeriksaan kehamilan dan pada saat persalinan Kala I dan II. Pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari pemeriksaan palpasi. Agar hasil tes DJJ lebih akurat, stetoskop ditaruh di area punctum maksimal, biasanya di daerah punggung janin. Pastikan bahwa yang terdengar adalah denyut jantung janin, dan bukan nadi ibu. Biasanya, detak jantung yang terdengar dibandingkan dengan denyut nadi ibu (detak jantung janin lebih cepat daripada detak jantung ibu). Setelah memastikan bahwa detak yang terdengar adalah detak jantung janin, maka denyut jantung janin dihitung untuk mengetahui teratur

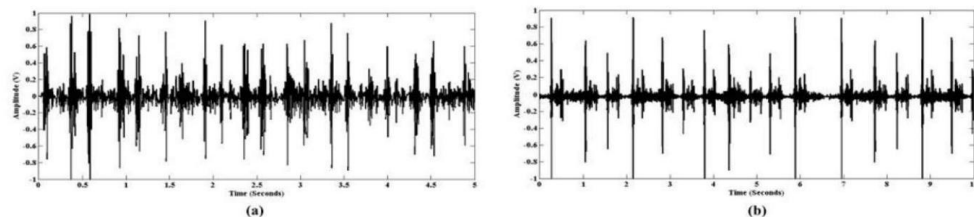
tidaknya, frekuensi dan kuat lemahnya denyut jantung janin itu.

b) Stetoskop Janin Fetoscope

Dari usia kehamilan 28 tahun hingga persalinan, pemeriksa dapat mendengarkan detak jantung janin secara manual menggunakan stetoskop yang dirancang khusus. Cara pemeriksaannya sama seperti pemeriksaan menggunakan stetoskop Pinar.

c) Stetoskop Digital

Prosedur pemeriksaan DJJ dengan stetoskop digital ini sama dengan menggunakan stetoskop konvensional, hanya hasilnya dapat dilihat pada layar komputer yang disebut dengan fetalphonocardiogram (fPCG). Alat ini sangat pasif karena tidak ada energi yang ditransmisikan ke janin. fPCG adalah rekaman akustik detak jantung janin, yang dihasilkan oleh aktivitas mekanis berbagai struktur jantung janin. Gambar yang dihasilkan dari pemeriksaan memberikan gambaran lebih detail tentang keadaan jantung janin.



**Gambar 6.2 Contoh Sinyal Suara Jantung Janin (a) Normal
(b) Abnormal**

Sumber : (Faradisa et al., 2017)

3) Ultrasonografi

Ultrasonografi (USG) merupakan salah satu alat yang memanfaatkan gelombang ultrasonik, dengan gelombang suara yang memiliki frekuensi yang tinggi (250 kHz 2000 kHz) dan hasilnya ditampilkan dalam layar monitor. Meskipun penggunaan teknologi USG lebih umum digunakan selama kehamilan, teknologi ini juga dapat digunakan untuk memantau posisi janin menjelang persalinan. Hal ini membantu dokter untuk menentukan apakah janin berada dalam posisi yang optimal untuk melahirkan (kepala di bawah) atau apakah ada tanda-tanda yang memerlukan intervensi medis. Disarankan agar pemantauan ultrasonografi ini tidak dilakukan seringkali. Biasanya dianjurkan pada awal kehamilan dan akhir kehamilan (Badawi et al., 2024).

Beberapa jenis Pemeriksaan USG adalah :

a) USG 2 Dimensi

Menampilkan gambar dalam dua bidang (memanjang dan melintang). Kualitas gambar yang baik, dan kondisi janin dapat terlihat dengan jelas.

b) USG 3 Dimensi

Dengan alat USG ini maka ada tambahan 1 bidang gambar lagi yang disebut koronal. Gambar yang ditampilkan akan menyerupai aslinya. Permukaan suatu benda (dalam hal ini tubuh janin) dapat dilihat dengan jelas. Demikian pula keadaan janin dari posisi yang berbeda. Hal ini dimungkinkan karena gambarnya dapat diputar (bukan janin yang berputar).

c) USG 4 Dimensi

Sebetulnya USG 4D merupakan istilah yang merujuk pada USG 3D yang bergerak (live 3D). Sementara gambar yang diperoleh dengan USG 3D bersifat statis, USG 4D memungkinkan gambar janin untuk "digerakkan", sehingga pasien dapat melihat dan membayangkan kondisi janin di dalam rahim lebih jelas.

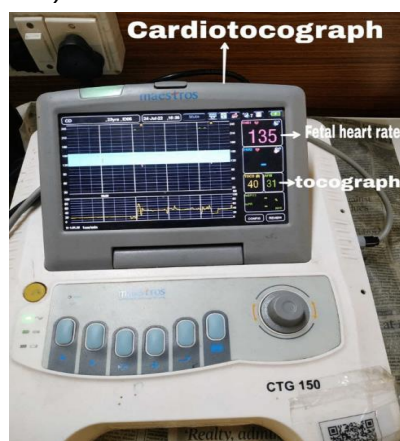
d) USG Doppler

USG Doppler atau Fetal Doppler adalah alat yang digunakan untuk deteksi detak jantung janin di dalam kandungan. Tujuannya adalah untuk memeriksa apakah janin tumbuh dengan normal, yang ditandai dengan adanya denyut jantungnya. Ultrasonografi umumnya teknik yang digunakan untuk deteksi detak jantung janin adalah dengan ultrasound (frekuensi 2 MHz). Pemeriksaan menggunakan USG Doppler ini dapat dilakukan pada usia kehamilan 12 minggu.

4) Kardiotokograf (CTG)

Kardiotokograf (CTG) adalah perangkat yang menggunakan transduser ultrasound untuk merekam detak jantung janin secara elektronik secara terus-menerus. Satu transduser diletakkan di perut ibu untuk mengukur detak jantung janin, dan transduser lainnya diletakkan di atas fundus uterus gravid untuk merekam kontraksi uterus. Alat ini digunakan untuk memantau detak jantung janin dan kontraksi uterus ibu (Jain & Acharya, 2022). Hasil pemeriksaan kedua komponen tersebut disalin secara bersamaan ke dalam selembar kertas. Hal ini memudahkan untuk menilai apakah janin mengalami hipoksia selama masa persalinan atau mengetahui apakah janin mengalami stress atau jika ada masalah dengan detak jantung janin, serta memastikan kontraksi berlangsung dengan baik dan efektif. Selanjutnya hasil pemeriksaan ini memegang peranan penting, apakah persalinan dapat dilakukan secara pervaginam atau melalui operasi

Caesar (Badawi et al., 2024).



Gambar 6.3 Kardiotokograf (CTG)

Sumber : (Jain & Acharya, 2022)

E. Simpulan

Transformasi digital kesehatan merupakan suatu perjalanan yang sedang berlangsung dengan potensi luar biasa untuk membawa perubahan positif dalam industri kesehatan dan kehidupan pasien. Dengan adanya pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan, terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh, meliputi : meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, meningkatnya efisiensi pelayanan kesehatan, meningkatnya akurasi dan keselamatan pelayanan, dan meningkatnya partisipasi pasien dalam pengelolaan kesehatan. Penggunaan teknologi juga memiliki peran yang sangat penting dalam memantau persalinan normal. Penyediaan alat dan sistem pada teknologi ini dapat membantu tenaga kesehatan dalam memastikan keselamatan ibu dan bayi selama proses persalinan. Pemantauan kondisi ibu yang memanfaatkan teknologi seperti pemantauan tekanan darah, dan kontraksi uterus, sedangkan untuk pemantauan janin seperti Internal penggunaan Elektronik Fetal monitoring, Internal Contraction Monitoring, Pemeriksaan Non Stress Test (NST), Teknologi auskultasi berupa stetoskop manual ataupun stetoskop digital, Ultrasonografi (USG), dan Kardiotokograf (CTG).

F. Referensi

- Badawi, B., Marlina, Sri Kustiyati, Dinda Gustina Aulia, Ni Ketut Somoyani, & U. Evi Nasla. (2024). Asuhan Kebidanan Persalinan Normal. In *Asuhan Kebidanan Persalinan Normal* (Issue Juli). [https://repository.poltekkes-tjk.ac.id/id/eprint/1315/6/BAB II.pdf](https://repository.poltekkes-tjk.ac.id/id/eprint/1315/6/BAB%20II.pdf)
- Eprilianto, D. F., Yuyun Eka Kartika Sari, & Saputra, B. (2019). Mewujudkan Integrasi Data Melalui Implementasi Inovasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Digital. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(1), 30–37. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p30-37>

- Faradisa, I. S., Sardjono, T. A., & Purnomo, M. H. (2017). Teknologi Pemantauan Kesejahteraan Janin di Indonesia. *Seminar Nasional Inovasi Dan Aplikasi Teknologi Di Industri 2017*, 1–6.
- Ganti, L. (2022). Atlas of Emergency Medicine. In *Canadian Journal of Emergency Medicine* (Vol. 5, Issue 2). Springer Cham. <https://doi.org/10.1017/S1481803500008344>
- Jain, S., & Acharya, N. (2022). Fetal Wellbeing Monitoring – A Review Article. *Cureus*, 14(9), 1–7. <https://doi.org/10.7759/cureus.29039>
- Nugroho, R., Hidayat, M., Rianti, E. D. D., Mutiarahati, N. L. A. C., & Rosyid, A. F. (2023). Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pelayanan Kesehatan Publik: Sebuah Tinjauan Analisis Kebijakan. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 5(2), 277–285. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i2.28550>
- Purba, N. F., Annisa, F. S., Syafitri, A., & Purba, S. H. (2024). Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Pelayanan Kesehatan Publik: Sebuah Tinjauan Analisis Kebijakan. *Jurnal Kesehatan Unggul Gemilang*, 8(6), 38–44.
- Romadhoni, S., Sulistiyowati, I., & Rizqiyah, M. A. (2024). IoT-based Pregnant Mother Contraction Monitoring System Design. *Jurnal Edukasi Elektro*, 8(1), 12–22. <https://doi.org/10.21831/jee.v8i1.66465>
- Yuriati, P., & Khoiriyah, E. (2021). Persalinan Nyaman Dengan Teknik Rebozo. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 12(2), 287–291. <https://doi.org/10.26751/jikk.v12i2.1052>
- Zahra, D., Nurdin, A., & Kurnia, U. F. K. A. D. R. (2023). Pemanfaatan Teknologi dalam Bidang Kesehatan Masyarakat. *Public Health Journal*, 443–451.

G. Glosarium

CTG	= Kardiotokograf
DJJ	= Detak Jantung Janin
DM	= Diabetes Mellitus
EKG	= Elektrokardiografi
EMG	= Elektromiografi
FAD	= Fetal Activity Determination
fPCG	= Fetalphonocardiogram
IoT	= Internet of Things
NST	= Non Stress Test
USG	= Ultrasonografi

CHAPTER 7

PEMANTAUAN KESEHATAN IBU DAN JANIN SELAMA PERSALINAN

Bdn. Pipih Salanti, SST., MKM.

A. Pendahuluan /Prolog

Persalinan adalah Proses pengeluaran janin dari uterus yang diawali dengan adanya kontraksi uterus yang secara teratur menyebabkan menipisnya serviks dan terjadi pembukaan dari pembukaan 1 sampai dengan 10, kemudian lahir janin kemudian lahir plasenta sampai 2 jam post partum. Persalinan normal terjadi pada kehamilan cukup bulan yaitu 37 – 42 minggu. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses persalinan adalah Passage (jalan lahir), Passenger (Janin), Power (Tenaga/Kekuatan), Psikis Ibu dan Penolong persalinan.

Pada masa persalinan Ibu dan janin membutuhkan support dan pendamping untuk memberikan semangat dan kekuatan pada psikis ibu, sehingga dapat melahirkan bayinya dengan normal dan lancar tanpa bantuan alat apapun dan tanpa intervensi. Asuhan Kebidanan Pemantauan kesehatan Ibu selama Persalinan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh bidan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan ibu selama proses persalinan. Asuhan ini meliputi pemantauan kondisi ibu dan janin, memberikan dukungan emosional, serta melakukan tindakan medis yang diperlukan.

B. Pemantauan Kesehatan Ibu Selama Persalinan

Kesehatan Ibu selama persalinan harus selalu di perhatikan, karena ibu pada saat menjalani persalinan membutuhkan tenaga yang kuat dan tentunya ibu harus sehat serta bebas dari penyakit penyerta persalinan, seperti penyakit, jantung, Asthma, Diabetes Melitus, Hipertensi. Pemantauan ibu dalam persalinan dapat diobservasi melalui patograf.

Patograf adalah alat untuk memantau kemajuan persalinan ibu dan janin.

Masa persalinan ibu dapat di mulai dari kala I sampai kala IV, sebagai berikut

Kala I Persalinan, di mulai dari timbulnya his secara teratur, kemudian dari vagina mengeluarkan lender yang bersemu darah atau *bloody show*, yang berasal dari lender kanalis servikalis karena serviks mulai membuka dan mendatar , sedangkan darahnya berasal dari pembuluh-pembuluh darah kapiler yang berada di sekitar kanalis servikalis itu pecah karena terjadi pergeseran ketika serviks

membuka mulai dari pembukaan 1cm sampai pembukaan 10 cm.

Kala II persalinan, mulai dari pembukaan 10 cm, kemudian his menjadi semakin lebih kuat, lebih cepat, kira-kira 2 sampai 3 menit sekali. Dalam hal ini kepala janin sudah masuk ke ruang panggul, maka pada saat ada his di rasakan tekanan pada otot-otot dasar panggul dan ibu akan merasakan ingin buang air besar. Ibu juga merasakan adanya tekanan pada anus, kemudian mulai perineum menonjol , lalu vulva membuka. Pada saat itulah ibu akan merasakan dorongan janin dari dalam Rahim kemudian ibu akan mengejan . penolong persalinan pada saat itu terjadi harus membimbing ibu agar dapat mengejan dengan baik dan ibu dapat melahirkan bayinya dengan kondisi yang sehat. Ketika pembukaan memang sudah lengkap , penolong persalinan di bolehkan untuk melakukan amniotomi atau pemecahan selaput ketuban , amniotomi dilakukan diantara his yang mulai melemah atau relaksasi, amniotomy tidak boleh dilakukan pada saat ada his yang kuat karena akan menyebabkan air ketuban keluar tidak terkendali. Ketika ada his ibu dianjurkan untuk mengejan dan ketika tidak ada his ibu dianjurkan untuk istirahat atau relaks, beri nutrisi dan beri semangat kepada ibu, pantau kesehatan ibu dengan benar sampai bayi lahir.

Kala III Persalinan, adalah kala dimana akan melahirkan plasenta , penolong harus melakukan manajemen persalinan kala III Seperti :

1. Cek apakah ada janin ke dua.
2. Beri suntikan uteritonika.
3. Lakukan Peregangannya Tali Pusat
4. Lahirkan placenta
5. masase

Tanda-tanda pelepasan placenta :

1. Ada semburan darah
2. Fundus mengeras atau globuler
3. Tali pusat memanjang

Kala IV Persalinan, yaitu di mulai dari lahirnya placenta sampai 2 jam postpartum, dimana kondisi ibu biasanya lemah karena letih habis melahirkan bayi dan placenta, maka dikala IV ini ibu di observasi Tensi, Nadi, Suhu, kemudian di lihat fundusnya harus selalu mengeras , kandung kemih , perdarahan tidak boleh lebih dari 500 cc, laserasi perineum. Jika terjadi laserasi perineum maka harus dilakukan penjahitan dengan anastesi. Pemantauan kala IV di lakukan setiap 15 menit sekali dalam 1 jam pertama dan setiap 30 menit sekali dalam 1 jam kedua.

Jika pemantauan kesehatan ibu dilakukan dengan benar, maka kondisi ibu setelah melahirkan akan sehat .

C. Asuhan Kebidanan Pada Ibu selama Melahirkan

1. Mengatur posisi

Ibu mungkin akan melakukan beberapa posisi seperti jongkok, berbaring, miring, fowler dan berdiri di ranjang.

2. Penanganan pada kala II

Memberikan dukungan terus menerus kepada Ibu dengan :

- a. Mendampingi Ibu agar selalu merasa nyaman, menawarkan minum, makan atau memijat Ibu
- b. Menjaga Kebersihan diri agar ibu tetap terjaga kebersihannya dan terhindar dari penyakit dan infeksi.
- c. Massase Ibu untuk memberikan kenyamanan
- d. Memberikan dukungan mental untuk mengurangi kecemasan, atau ketakutan Ibu dengan cara menjaga privasi Ibu, memberikan penjelasan kepada ibu bahwa persalinan adalah proses yang normal dan tidak menyakitkan.
- e. Mengatur posisi ibu, dalam membimbing Ibu mendedan , apalagi sekarang khususnya bidan sudah mempunyai ilmu komplementer dalam membimbing persalinan , seperti ajak ibu untuk melakukan reflex rocking, gymball, rebozzo, yang akan mempermudah proses melahirkan.
- f. Menjaga kandung kemih tetap kosong
- g. Memberikan cukup nutrisi.

3. Dukungan Persalinan dan Kehadiran Pendamping

Dukungan persalinan dengan menghadirkan seorang pendamping dalam hal ini adalah suami si Ibu , padasaat persalinan akan menghasilkan:

- a. Kelahiran dengan tindakan lebih sedikit
- b. SC semakin berkurang
- c. Apgar Scor untuk si bayi akan selalu baik
- d. Lama persalinan Ibu semakin pendek
- e. Kepuasan Ibu semakin Besar dalam pengalaman melahirkan

4. Pengurangan Rasa Sakit

Penyebab rasa sakit dalam persalinan :

- a. Kontraksi Uterus, umumnya di mulai dari bawah pinggang menyebar kebagian bawah perut dan kaki.
- b. Dalam medis sakit kontraksi di kategorikan bersifat tumpul.
- c. Merupakan nyeri primer melibatkan pinggang, punggung, perut dan pangkal paha.
- d. Menyebabkan nyeri sekunder seperti mual, muntah, panas dingin, kram dan pusing.

- e. Penurunan Kepala janin, menyebabkan peregangan jaringan perineum, bersifat tajam dan panas

Asuhan pemantauan Kesehatan Ibu pada saat melahirkan harus di lakukan dengan benar, karena dengan bertindak yang seharusnya dilakukan maka akan menolong mengurangi angka kematian ibu di Indonesia.

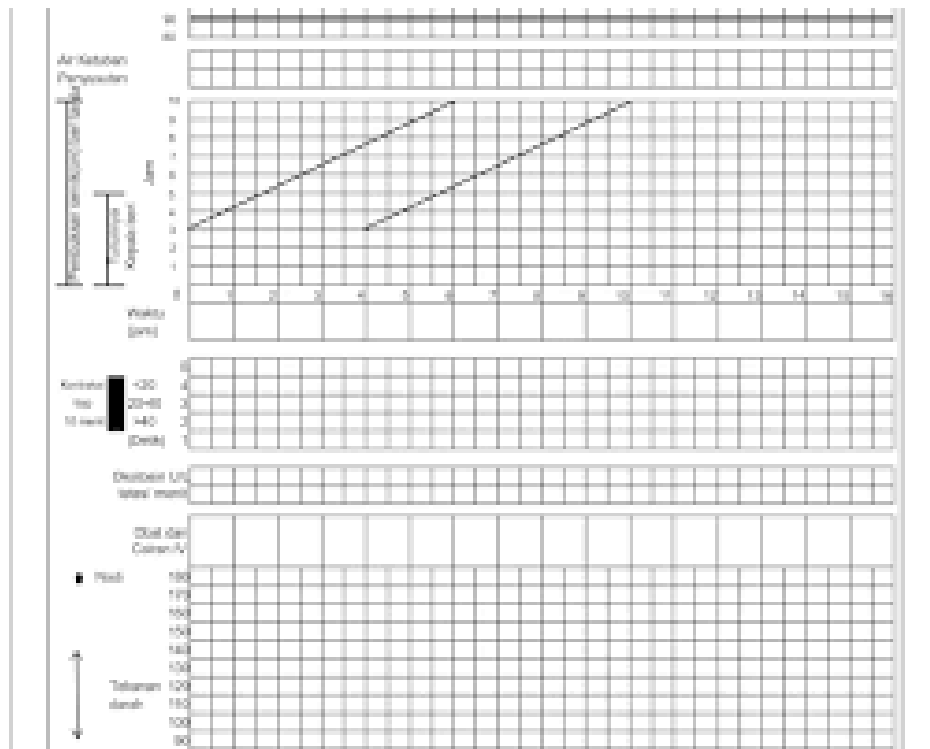
D. Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Ibu Selama Persalinan

1. Usia: Ibu bersalin yang terlalu muda atau terlalu tua memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi.
2. Kondisi kesehatan sebelum bersalin: Penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung dapat meningkatkan risiko komplikasi.
3. Jumlah persalinan : Ibu bersalin yang sudah memiliki banyak anak sebelumnya mungkin memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi.
4. Cara persalinan: Persalinan normal, caesar, atau induksi memiliki risiko dan komplikasi yang berbeda.

E. Partograf

Partograf adalah sebuah alat bantu visual yang digunakan oleh tenaga kesehatan, terutama bidan, untuk memantau kemajuan persalinan. Partograf berfungsi sebagai peta jalan persalinan, membantu tenaga kesehatan untuk:

1. Memantau kemajuan persalinan: Melihat apakah persalinan berjalan normal atau ada tanda-tanda penyulit.
2. Membuat keputusan klinis: Membantu menentukan tindakan yang tepat berdasarkan data yang tercatat di partograf.
3. Mendeteksi dini komplikasi: Memungkinkan tenaga kesehatan untuk segera mengetahui jika ada tanda-tanda bahaya pada ibu atau janin.



Gambar 7.1
Komponen Utama Partograf

Secara umum, partograf terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

1. Sumbu vertikal: Menunjukkan waktu dalam jam.
2. Sumbu horizontal: Menunjukkan pembukaan serviks (dalam sentimeter).
3. Kurva peringatan: Garis yang menunjukkan batas waktu normal untuk setiap tahap persalinan. Jika kemajuan persalinan berada di bawah kurva peringatan, ini bisa menjadi tanda adanya penyulit.
4. Kolom untuk pencatatan: Kolom-kolom ini digunakan untuk mencatat berbagai parameter penting selama persalinan, seperti detak jantung janin, kontraksi, dan pemberian obat.



Gambar 7.2
Partograf dengan keterangan komponen

Cara Menggunakan Partograf

Penggunaan partograf dimulai sejak awal kala I persalinan. Setiap perubahan yang terjadi pada ibu dan janin dicatat pada partograf. Dengan membandingkan data yang ada dengan kurva peringatan, tenaga kesehatan dapat menilai apakah persalinan berjalan normal atau perlu dilakukan tindakan lebih lanjut.



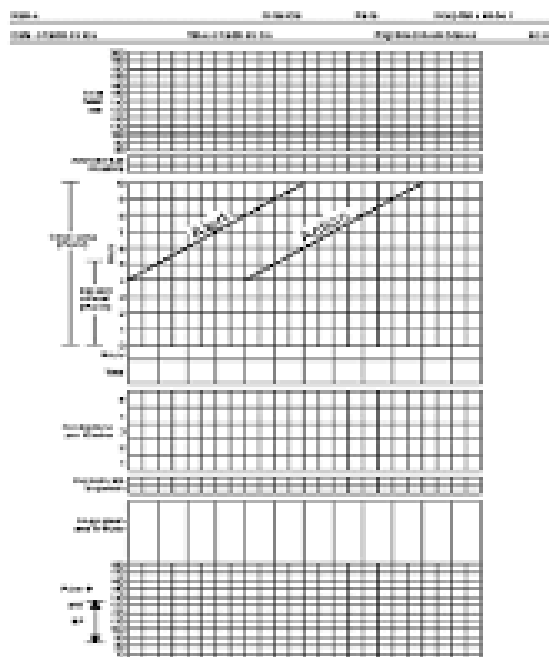
Gambar 7.3 Partograf

Pentingnya Partograf

Partograf memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan asuhan persalinan yang berkualitas. Dengan menggunakan partograf, tenaga kesehatan dapat:

1. Memberikan tindakan yang tepat waktu: Jika ada tanda-tanda penyulit, tenaga kesehatan dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelamatkan ibu dan bayi.
2. Mencegah terjadinya komplikasi: Dengan memantau kemajuan persalinan secara ketat, komplikasi dapat dicegah atau ditangani sedini mungkin.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan: Penggunaan partograf yang tepat dapat meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan.

• Partograf WHO yang sudah dimodifikasi



Gambar 7.4

Ibu bersalin dengan pemantauan partograf

F. Pemantauan Janin Selama Persalinan

Pemantauan janin selama persalinan dilakukan dengan menggunakan partograf, dimana partograf tersebut membantu dalam proses kelahiran bayi dengan aman dan nyaman serta sehat. Janin selama masih di perut ibu harus selalu di pantau kesejahteraannya dengan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin setiap 30 menit dengan menggunakan alat yang di sebut Doppler atau lineks, terkadang jika berada di rumah sakit besar bisa di lakukan USG atau dengan CTG. Kesejahteraan janin selama persalinan harus selalu di perhatikan, jangan sampai kesalahan dari si penolong akan menyebabkan kematian pada janin. Terutama pada janin yang usai kandungannya sudah melebihi 40 minggu. Dan usia Ibu yang sudah diatas 35 tahun. Penanganan bayi dilakukan sejak kepala bayi mulai keluar

dari jalan lahir, yaitu dengan membersihkan cairan dan lender dari wajah bayi, mulut dan hidung , kemudian di bersihkan dengan kain lalu di letakan di dada Ibunya untuk di lakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD), bayi akan menangis dalam 30 detik, tidak perlu dilakukan apa-apa lagi karena bayi akan bernafas secara spontan dan warna kulitnya kemerah merahan.

G. Penilaian Bayi Waktu Lahir

Keadaan umum bayi dinilai pada saat 1 menit setelah lahir dengan menggunakan nilai APGAR. Penilaian ini di perlukan untuk mengetahui keadaan bayi , apakah lahir dengan sehat atau dengan asfiksia. Dalam APGAR Scor yang di nilai adalah, frekwensi jantung (heart rate), usaha napas (respiratory effort), tonus otot (muscle tone), warna kulit (Colour), dan reaksi terhadap rangsangan (response to stimuli).

TABEL 7.1
Penilaian APGAR untuk neonatus.

				A
Appearance (Warna Kulit)	cat	dan Merah, ekstremitas biru	luruh tubuh kemerah merahan	
ulse Rate (frekuensi nadi)	tidak ada	kurang dari 100	lebih dari 100	
Response (reaksi terhadap rangsangan)	tidak ada	dikit Gerakan mimic (grimace)	tuk/bersin	
Activity (tonus Otot)	tidak ada	ekstremitas dalam sedikit flexi	gerakan aktif	
Respiration (pernapasan)	tidak ada	lemah/tidak teratur	baik/menangis	
				jumlah

Catatan:

NA 1 menit lebih/sama dengan 7 tidak perlu resusitasi

NA 1 menit 4 – 6 bag and mask ventilation

NA 1 menit 0 – 3 lakukan intubasi

H. Faktor Risiko yang Memerlukan Pemantauan Janin Lebih Intensif

Beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko komplikasi selama persalinan dan membutuhkan pemantauan janin yang lebih ketat antara lain:

1. Usia ibu: Ibu bersalin yang terlalu muda (di bawah 17 tahun) atau terlalu tua (di atas 35 tahun) cenderung memiliki risiko lebih tinggi.
2. Riwayat persalinan sebelumnya: Ibu yang pernah mengalami persalinan prematur, keguguran berulang, atau memiliki bayi dengan berat lahir rendah mungkin perlu pemantauan ekstra.
3. Kondisi medis ibu: Penyakit seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, atau infeksi dapat mempengaruhi kesehatan janin.
4. Komplikasi persalinan : Kondisi seperti preeklamsia, plasenta previa, atau solusio plasenta memerlukan pemantauan ketat.
5. Persalinan ganda: Persalinan kembar atau lebih memiliki risiko komplikasi yang lebih tinggi.
6. Kelainan janin: Jika terdapat kelainan pada janin yang terdeteksi melalui USG atau tes lainnya, pemantauan intensif juga diperlukan.
7. Induksi persalinan atau penggunaan obat-obatan: Penggunaan obat-obatan untuk merangsang kontraksi atau mempercepat persalinan dapat memengaruhi detak jantung janin.

I. Cara Mengatasi Rasa Tidak Nyaman Selama Pemantauan Janin

Pemantauan janin, terutama dengan menggunakan alat CTG, mungkin terasa tidak nyaman bagi beberapa ibu yang akan melahirkan. Beberapa cara untuk mengatasi rasa tidak nyaman tersebut antara lain:

1. Ganti posisi: Cobalah untuk mengubah posisi tubuh secara berkala agar lebih rileks.
2. Minta bantal: Mintalah bantal penyangga untuk memberikan kenyamanan pada tubuh Ibu.
3. Latihan pernapasan: Latihan pernapasan dalam dapat membantu Ibu rileks dan mengurangi ketegangan.
4. Komunikasikan dengan petugas medis: Jika Ibu merasa sangat tidak nyaman, jangan ragu untuk menyampaikannya kepada bidan atau dokter yang sedang bertugas. Mereka akan berupaya mencari solusi yang terbaik.
5. Dengarkan musik: Mendengarkan musik yang menenangkan dapat membantu Ibu rileks.

Penting untuk diingat:

1. Setiap peristiwa persalinan itu unik: Kebutuhan pemantauan janin setiap ibu bersalin berbeda-beda.
2. Pemantauan janin adalah bagian penting: Tujuan utama pemantauan janin adalah untuk memastikan kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi.
3. Kerjasama dengan petugas medis: Bekerjasama dengan dokter dan bidan akan membantu Anda menjalani proses persalinan dengan lebih baik.

J. Pembahasan

Pemantauan kesehatan Ibu dan Janin Selama Persalinan , harus di laksanakan sebaik-baiknya oleh tenaga kesehatan disini khususnya penolong persalinan. Ibu dan Janin harus di pantau kesehatannya dikarenakan pada saat itu kebutuhan ibu dan janin sangat di perlukan, pathograf menjadi alat utama untuk membantu penolong persalinan untuk memantau kemajuan persalinan Ibu dan janin pada masa persalinan, karena dengan menggunakan pathograf , penolong persalinan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan sistimatis dan benar, penolong persalinan dapat mengetahui kapan harus bertindak ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan ketika ibu dan janin membutuhkan pertolongan cepat, kapan harus melahirkan normal dan kapan harus di rujuk ke tempat pelayanan yang lebih lengkap untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik serta kapan ibu harus di laksanakan oprase sesaria. Pemantauan kesehatan Ibu dan janin selama persalinan sangat bermanfaat untuk keselamatan Ibu dan janin selama persalinan sehingga Ibu dan janinnya sehat sejahtera dapat lahir dengan aman dan nyaman.

K. Referensi

- Apgar V, A proposal for a new method of evalution of the newborn infant, anesth analog 32:260, 2015.
- Dr. Emi Kusumawardani, SST, M.Kes , dkk, tahun 2024 " Asuhan Kebidanan Kasus kompleks," Mahakarya citra.
- Jacobson E, Relaxation Methods in Labor. Amer J Obstet Gynec, 2020;67:1035.
- Sarwono Prawirohardjo, 2018 " Ilmu Kebidanan", Yayasan Bina Pustaka.
- Sarwono Prawirohardjo, 2018 " Ilmu Kebidanan", Yayasan Bina Pustaka.
- Sumiaty, SST, MPH, Niluh Nita Silfia, SST ,tahun 2013,"Konsep Kebidanan", IN Media.

CHAPTER 8

KEPUTUSAN LAPAROTOMI DAN INDIKASI OPERASI CAESAR

Resta Betaliani Wirata, S.Kep., Ns., MSN.

A. Pendahuluan/Prolog

Prosedur untuk mengakses organ dalam rongga perut pasien yang menjalani bedah dikenal sebagai laparotomi. Proses ini dilakukan untuk diagnosis dan pengobatan, terutama dalam situasi darurat (Kliegman, R.M., et al., 2020). Sebaliknya, persalinan melalui prosedur pembedahan yang melindungi kesehatan ibu dan janin dikenal sebagai operasi caesar. Penilaian klinis, penggunaan alat diagnostik, dan konsultasi multidisiplin adalah semua faktor yang mempengaruhi keputusan untuk melakukan kedua prosedur ini (Cunningham, F.G., et al., 2022).

Salah satu prosedur bedah paling penting dalam sejarah kedokteran adalah laparotomi, operasi yang melibatkan pembukaan dinding perut untuk mengakses rongga perut. Prosedur ini memiliki sejarah yang panjang dan telah berkembang dari praktik bedah dasar hingga menjadi teknik yang sangat maju saat ini. Catatan sejarah, prosedur serupa laparotomi sudah dilakukan sejak zaman Mesir kuno dan Yunani kuno. Para tabib pada masa itu menggunakan metode sederhana untuk mengobati trauma perut atau penyakit dalam. Abad ke-18 dan ke-19 menunjukkan kemajuan besar dalam laparotomi mulai terlihat dengan berkembangnya anestesi dan antiseptik. Pada tahun 1809, seorang ahli bedah Amerika bernama Ephraim McDowell melakukan operasi laparotomi pertama yang terdokumentasi untuk mengangkat tumor ovarium dari seorang pasien perempuan. Operasi ini dilakukan tanpa anestesi modern dan berhasil, menjadikannya tonggak sejarah besar dalam dunia bedah (McDowell, E., 1817).

Perkembangan abad ke-20, laparotomi menjadi prosedur standar untuk mengobati berbagai kondisi, seperti trauma abdomen, kanker, dan infeksi intra-abdomen. Perkembangan teknologi, seperti radiologi, ultrasonografi, dan pencitraan CT, memungkinkan diagnosa yang lebih akurat sebelum operasi dilakukan (Schwartz, S.I., et al., 2021).

Asal usul nama "*Caesar*" Operasi caesar (atau *Caesarean Section*) dikenal sebagai prosedur bedah untuk melahirkan bayi melalui sayatan di dinding perut dan rahim ibu. Nama "*caesar*" berasal dari istilah Latin *sectio caesarea*, yang berarti "pemotongan" atau "sayatan." Ada teori tentang asal usul istilah ini yang mungkin

merujuk pada praktik dalam hukum Romawi kuno (*Lex Caesarea*), yang mewajibkan bayi dikeluarkan dari rahim ibu yang meninggal agar bayi dapat diselamatkan (Baskett, T.F., 2002).

Operasi Caesar di Zaman Kuno yaitu Romawi dan Yunani Kuno, operasi caesar dilakukan pada wanita yang meninggal atau sekarat untuk menyelamatkan bayi. Teknik ini tidak dilakukan untuk menyelamatkan ibu, karena keterbatasan pengetahuan medis dan teknologi. Hippocrates dan Plinius mencatat prosedur ini dalam tulisan-tulisan mereka, tetapi hasilnya hampir selalu fatal bagi ibu (Dunn, P.M., 1999). Pada akhir abad ke-16, operasi ini mulai dilakukan pada ibu yang masih hidup. Namun, tanpa anestesi dan antiseptik, risiko kematian akibat infeksi dan perdarahan sangat tinggi. Jacques Guillimeau, seorang ahli bedah Prancis pada abad ke-17, mendokumentasikan prosedur caesar dalam bukunya *Childbirth or The Happy Delivery of Women* pada tahun 1635. Era Modern Awal (Abad ke-19) pada tahun 1881, Max Sanger, seorang ahli bedah Jerman, memperkenalkan teknik menjahit rahim setelah operasi caesar, mengurangi risiko perdarahan dan infeksi.

Perkembangan Abad ke-20, peningkatan keselamatan operasi yaitu penemuan antibiotik pada 1930-an dan transfusi darah meningkatkan tingkat kelangsungan hidup ibu. Caesar Elektif mulai dilakukan yaitu operasi caesar sebagai prosedur elektif (terencana) untuk menghindari komplikasi persalinan normal (Cunningham, F.G., et al., 2022). Saat ini, operasi caesar merupakan salah satu prosedur paling umum di dunia, dan metode ini digunakan untuk lebih dari 20% persalinan yang dilakukan di seluruh dunia (WHO, 2015).

B. Indikasi Laparotomi

Indikasi utama laparotomi meliputi:

1. Trauma Abdomen: Trauma tumpul atau penetrasi yang mengancam nyawa.

Trauma abdomen adalah cedera yang memengaruhi struktur atau organ dalam rongga perut, yang dapat disebabkan oleh trauma tumpul (*blunt trauma*) maupun trauma penetrasi (*penetrating trauma*). Cedera ini dapat mengancam jiwa karena berisiko menyebabkan perdarahan internal, kerusakan organ vital, atau infeksi berat seperti peritonitis. Trauma abdomen menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas di berbagai negara, terutama pada populasi usia produktif akibat kecelakaan lalu lintas, kekerasan fisik, atau jatuh dari ketinggian.

Klasifikasi Trauma Abdomen

a. Trauma Tumpul (Blunt Trauma)

Cedera tumpul disebabkan oleh tekanan eksternal tanpa melibatkan

penetrasi kulit, sering kali akibat: Kecelakaan lalu lintas (misalnya, tabrakan kendaraan atau tabrak lari); Jatuh dari ketinggian; Benturan langsung, seperti pukulan ke perut. Organ yang paling sering terkena trauma tumpul adalah: Hati (hepar) berisiko robek dan mengalami perdarahan berat, Limpa rentan terhadap ruptur yang menyebabkan hemoperitoneum, Usus halus dapat mengalami kontusio atau perforasi (Karmy-Jones, R., et al., 2018).

b. Trauma Penetrasi (Penetrating Trauma)

Cedera penetrasi melibatkan luka yang menembus kulit dan dinding perut, biasanya akibat luka tembak dan atau luka tusuk. Organ yang sering terlibat meliputi: Usus halus paling sering mengalami perforasi pada trauma penetrasi; Lambung dan kolon berisiko tinggi menyebabkan peritonitis; Pembuluh darah besar (aorta, vena cava) trauma ini dapat menyebabkan syok hemoragik (Mattox, K.L., et al., 2021).

2. Peritonitis: Perforasi organ berongga yang memicu inflamasi peritoneum.

Peritonitis adalah peradangan pada peritoneum, yaitu lapisan tipis jaringan yang melapisi dinding dalam rongga perut dan menutupi organ-organ di dalamnya. Kondisi ini merupakan keadaan darurat medis yang memerlukan penanganan segera karena dapat mengancam nyawa (Runyon, B.A., 2019).

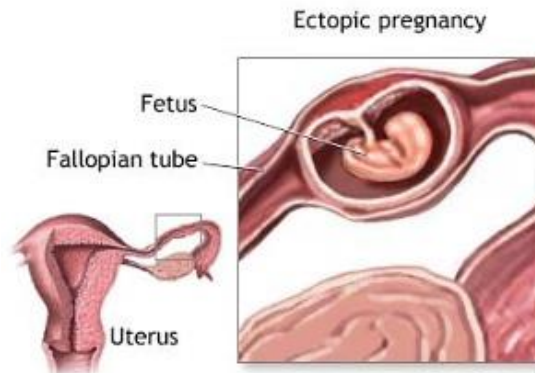
Penyebab Peritonitis

- a. Peritonitis Primer: Disebabkan oleh infeksi spontan, sering kali pada pasien dengan sirosis hati atau asites (contoh: Peritonitis Bakterial Spontan).
- b. Peritonitis Sekunder: Disebabkan oleh perforasi organ dalam perut (contoh: perforasi usus, ruptur apendisitis, atau ulkus lambung).
- c. Peritonitis Tersier: Peradangan berulang atau persisten yang biasanya terjadi setelah operasi atau pengobatan peritonitis sekunder (Sabiston, D.C., et al., 2021).

Gejala Utama Peritonitis yaitu

- a. nyeri perut yang berat dan menetap
- b. perut kaku (*board-like rigidity*)
- c. mual, muntah, dan demam
- d. penurunan tekanan darah dan tanda-tanda syok pada kasus berat (Sabiston, D.C., et al., 2021).

3. Kehamilan Ektopik yang Pecah: Kondisi darurat yang menyebabkan perdarahan internal.



Gambar 8.1 Kehamilan Ektopik

Sumber: <https://luzizhea.com/mengenali-gejala-dan-penanganan-kehamilan-ektopik/>

Kehamilan ektopik adalah kondisi di mana embrio berimplantasi dan berkembang di luar rongga uterus, paling sering di tuba falopi (sekitar 90% kasus). Ketika kehamilan ektopik pecah, kondisi ini menjadi keadaan darurat medis karena dapat menyebabkan perdarahan masif yang mengancam jiwa. Kehamilan ektopik terjadi akibat gangguan dalam perjalanan sel telur yang telah dibuahi menuju rahim. Faktor risiko meliputi (Barnhart, K.T., 2009):

- a. Penyakit radang panggul (PID): Infeksi kronis yang menyebabkan kerusakan tuba falopi.
- b. Riwayat operasi tuba: Seperti ligasi tuba atau rekonstruksi tuba.
- c. Kehamilan ektopik sebelumnya.
- d. Penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD): Risiko kecil jika terjadi kehamilan.
- e. Merokok: Mengurangi motilitas tuba.

Gejala Kehamilan Ektopik yang Pecah menurut Horne, A.W., et al. (2015), yaitu:

- a. Nyeri perut akut: Nyeri hebat dan tiba-tiba, biasanya di salah satu sisi perut.
- b. Perdarahan vagina: Bercak darah atau perdarahan tidak normal.
- c. Tanda-tanda syok: Pucat, pusing, tekanan darah rendah, dan denyut jantung yang cepat.
- d. Nyeri bahu: Akibat iritasi diafragma oleh darah dalam rongga peritoneal.

C. Proses Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan menurut WHO 2003, melibatkan:

1. Evaluasi klinis.

Menurut Moore, E.E., et al. (2020), Pengambilan keputusan untuk melakukan laparotomi memerlukan evaluasi klinis yang menyeluruh, terutama pada kasus trauma abdomen atau kondisi akut lainnya, untuk menentukan

kebutuhan operasi segera.

Tujuan Evaluasi Klinis

Evaluasi klinis bertujuan untuk:

- a. Menentukan indikasi laparotomi berdasarkan temuan klinis dan diagnostik.
- b. Membedakan antara kasus yang dapat ditangani secara konservatif dan yang membutuhkan pembedahan.
- c. Mengidentifikasi kemungkinan komplikasi untuk perencanaan intervensi yang lebih baik.

Langkah-Langkah Evaluasi Klinis menurut Advanced Trauma Life Support (ATLS) Subcommittee (2020), yaitu:

a. Riwayat Medis dan Anamnesis

- 1) Gejala Utama: Nyeri perut akut, perdarahan, atau distensi abdomen.
- 2) Riwayat Trauma: Jenis trauma (tumpul atau penetrasi) dan mekanisme cedera.
- 3) Kondisi Penyerta: Penyakit kronis, riwayat operasi sebelumnya, atau kehamilan.

b. Pemeriksaan Fisik

1) Inspeksi:

Memeriksa adanya luka, hematoma, atau tanda cedera eksternal.

Distensi perut yang menunjukkan adanya cairan bebas atau gas.

2) Palpasi:

Nyeri tekan lokal atau difus, terutama dengan tanda iritasi *peritoneal (rebound tenderness)*.

3) Perkusi dan Auskultasi:

Ketiadaan bising usus dapat mengindikasikan ileus paralitik atau peritonitis.

c. Tanda-Tanda Klinis Penting

- 1) Tanda Iritasi Peritoneal: Nyeri yang memburuk saat perut ditekan dan dilepas (*rebound tenderness*).
- 2) Kekakuan otot dinding perut (*rigidity*).
- 3) Tanda Hemodinamik: Hipotensi, takikardia, dan pucat, yang menunjukkan syok akibat perdarahan intra-abdomen.

2. Pemeriksaan penunjang (CT-Scan, USG).

Setelah evaluasi klinis awal, pemeriksaan tambahan diperlukan untuk mengonfirmasi diagnosis dan menentukan indikasi laparotomi yaitu:

a. Ultrasonografi FAST (*Focused Assessment with Sonography for Trauma*)

Digunakan untuk mendeteksi cairan bebas di rongga peritoneal, yang mengindikasikan perdarahan intra-abdomen.

b. CT Scan Abdomen

Memberikan gambaran detail tentang kerusakan organ internal. CT scan sangat penting pada pasien stabil secara hemodinamik.

c. Pemeriksaan Laboratorium

Hemoglobin dan Hematokrit: Menilai tingkat perdarahan.

Laktat Serum: Mendeteksi hipoperfusi jaringan.

Amilase/ Lipase: Menilai cedera pankreas.

d. Laparoskopi Diagnostik

Digunakan dalam kasus tertentu untuk mengevaluasi rongga perut tanpa melakukan laparotomi penuh.

(Rozycki, G.S., et al.,2015)

3. Diskusi multidisiplin

Pengambilan keputusan untuk melakukan laparotomi sering kali kompleks dan memerlukan pertimbangan dari berbagai aspek medis. Diskusi multidisiplin (*Multidisciplinary Team Discussion/ MDT*) merupakan pendekatan yang melibatkan berbagai spesialis untuk memastikan keputusan yang tepat, terutama pada kasus trauma abdomen berat, kondisi gawat darurat, atau pasien dengan komorbiditas yang kompleks.

Tujuan Diskusi Multidisiplin menurut Gawande, A., 2014 yaitu:

- a. Menilai Risiko dan Manfaat Operasi: Memastikan bahwa laparotomi adalah intervensi yang paling efektif untuk kondisi pasien.
- b. Mengintegrasikan Keahlian Berbeda: Setiap spesialis memberikan perspektif berdasarkan bidang keahliannya, seperti ahli bedah, radiolog, ahli anestesi, dan spesialis penyakit dalam.
- c. Mengurangi Komplikasi: Dengan kolaborasi, potensi komplikasi dapat diidentifikasi dan dikelola lebih baik sebelum dan sesudah operasi.
- d. Meningkatkan Hasil Klinis: Keputusan yang didasarkan pada diskusi lintas disiplin cenderung menghasilkan perawatan yang lebih menyeluruh dan efektif.

Anggota Tim Multidisiplin

1. Ahli Bedah Umum atau Trauma: Memimpin keputusan terkait kebutuhan laparotomi dan menentukan pendekatan bedah.
2. Radiolog: Menginterpretasikan hasil pencitraan (CT scan atau FAST) untuk mengidentifikasi cedera internal.
3. Ahli Anestesi: Menilai kesiapan pasien untuk menjalani operasi dan memastikan manajemen perioperatif yang optimal.
4. Spesialis Penyakit Dalam atau Intensivis: Mengelola kondisi komorbiditas pasien, seperti diabetes, hipertensi, atau gangguan jantung.

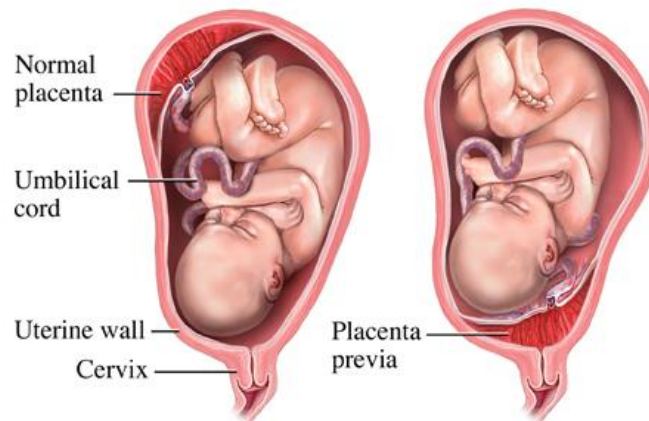
5. Ahli Gizi: Berkontribusi dalam pemulihan pascaoperasi melalui perencanaan nutrisi.
6. Perawat atau Koordinator Klinis: Mendukung komunikasi antaranggota tim dan pasien (McCulloch, P., et al., 2015).

D. Indikasi Operasi Caesar

Operasi Caesar, juga dikenal sebagai *sectio caesarea*, adalah prosedur bedah di mana bayi dilahirkan melalui sayatan di dinding perut ibu dan rahim. Ketika persalinan normal melalui jalan lahir tidak mungkin atau berisiko bagi ibu dan bayi, prosedur ini digunakan.

Indikasi Absolut menurut Cunningham, F.G., et al. (2022), kondisi yang memerlukan operasi caesar meliputi:

1. Placenta Previa Totalis: Plasenta menutupi jalan lahir.



Gambar 8.1 Plasenta Previa

Sumber: <https://mommiesdaily.com/2016/02/23/plasenta-previa-tidak-bisa-melahirkan-secara-normal>

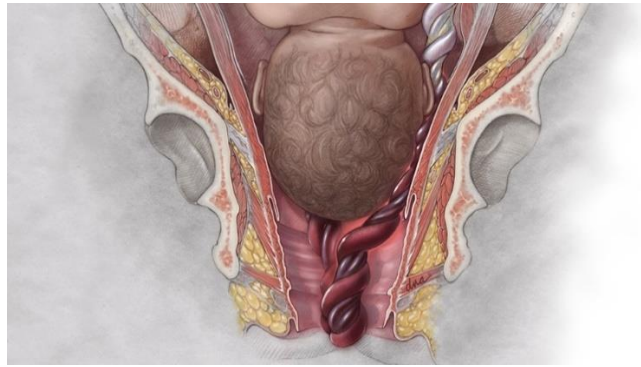
2. *Disproporti Cephalopelvic* (CPD): Ketidaksesuaian ukuran bayi dan panggul ibu.



Gambar 8.2 *Disproporti Cephalopelvic*

Sumber: <https://www.curhatbidan.com/persalinan/bisakah-wanita-dengan-panggul-sempit-melahirkan-secara-normal/>

3. Prolaps Tali Pusat: Tali pusat keluar lebih dulu dari bayi.



Gambar 8.3 Prolaps Tali Pusat

Sumber: <https://ai-care.id/healthpedia-penyakit/prolaps-tali-pusat>

Indikasi Operasi Caesar berdasarkan *American College of Obstetricians and Gynecologists* (ACOG) tahun 202, yaitu:

1. Indikasi Maternal

- Riwayat Caesar Sebelumnya: Untuk menghindari ruptur rahim pada persalinan normal.
- Distosia: Hambatan kemajuan persalinan akibat kontraksi uterus yang tidak adekuat atau panggul sempit.
- Plasenta Previa: Plasenta menutupi jalan lahir.
- Solusio Plasenta: Pelepasan plasenta sebelum kelahiran yang menyebabkan perdarahan masif.
- Preeklamsia Berat: Risiko komplikasi serius pada ibu dan janin.

2. Indikasi Janin

- Gawat Janin: Deteksi denyut jantung janin abnormal.
- Malpresentasi: Posisi janin yang tidak normal, seperti sungsang atau lintang.
- Kehamilan Ganda/ Gemili: Ketika posisi salah satu janin tidak memungkinkan persalinan normal.
- Makrosomia Janin: Berat janin yang terlalu besar sehingga sulit melewati jalan lahir.

3. Indikasi Kombinasi

- Infeksi Maternal: HIV dengan viral load tinggi atau infeksi herpes genital aktif.
- Cacat Janin: Misalnya, hidrosefalus dengan kepala janin terlalu besar untuk melewati jalan lahir.

E. Keuntungan dan Risiko Operasi Caesar

Beberapa keuntungan dan risiko operasi Caesar menurut Betrán, A.P., et al. (2016), yaitu:

1. Keuntungan

- Menghindari risiko komplikasi persalinan normal.

- b. Mengurangi trauma pada bayi dalam kasus tertentu.

2. Risiko

- a. Maternal: Infeksi, perdarahan, tromboemboli, dan risiko operasi berulang pada kehamilan berikutnya.
- b. Janin: Risiko masalah pernapasan pada bayi baru lahir.

F. Komplikasi Operasi Caesar

1. Komplikasi untuk Ibu

a. Infeksi

Wanita yang menjalani operasi caesar berisiko tinggi mengalami infeksi di area luka bedah atau di dalam rahim (endometritis). Secara umum, infeksi dapat memerlukan perawatan tambahan dan antibiotik.

b. Pendarahan

Pendarahan lebih cenderung terjadi selama atau setelah operasi. Dalam kasus pendarahan yang signifikan, transfusi darah mungkin diperlukan. Pendarahan yang parah juga dapat mengakibatkan masalah kesehatan serius bagi ibu.

c. Reaksi terhadap Anestesi

Anestesi dapat menimbulkan reaksi negatif, meskipun ini jarang terjadi. Efek samping bisa beragam, mulai dari mual hingga reaksi alergi yang lebih serius.

d. Penggumpalan Darah

Risiko trombosis vena dalam (DVT) dan emboli paru meningkat setelah operasi caesar, yang bisa berakibat fatal jika tidak diobati.

e. Masalah Penyembuhan

Beberapa wanita mungkin mengalami kesulitan dalam penyembuhan luka, termasuk pembentukan jaringan parut berlebih (keloid) yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan.

f. Komplikasi di Kehamilan Berikutnya

Wanita yang memiliki riwayat operasi caesar memiliki risiko lebih tinggi untuk komplikasi, seperti robekan rahim (uterine rupture), di kehamilan berikutnya.

2. Komplikasi untuk Bayi

a. Masalah Pernapasan

Bayi yang lahir melalui caesar, terutama yang dilakukan sebelum kehamilan mencapai 39 minggu, mungkin mengalami masalah pernapasan, seperti sindrom gangguan pernapasan (RDS).

b. Cedera saat Lahir

Meskipun jarang, ada risiko cedera fisik pada bayi selama proses caesar, seperti luka atau fraktur.

G. Simpulan

Keputusan untuk melakukan laparotomi atau operasi caesar memerlukan pertimbangan klinis menyeluruh dengan tujuan menyelamatkan nyawa pasien. Proses ini membutuhkan kolaborasi tim medis, penggunaan teknologi modern, dan komunikasi efektif dengan pasien dan keluarganya.

H. Referensi

- Advanced Trauma Life Support (ATLS) Subcommittee (2020). Advanced Trauma Life Support Manual.
- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2021). "Practice Bulletin: Indications for Cesarean Delivery."
- ATLS Subcommittee, American College of Surgeons (2020). Advanced Trauma Life Support (ATLS) Student Course Manual.
- Barnhart, K.T. (2009). "Ectopic Pregnancy." New England Journal of Medicine
- Baskett, T.F. (2002). "Caesarean Section: Historical Perspectives." American Journal of Obstetrics and Gynecology.
- Baskett, T.F. (2019). Cesarean Delivery: History and Evolution. Cambridge University Press.
- Betrán, A.P., et al. (2016). "The Increasing Trend of Cesarean Delivery Rates Worldwide." The Lancet Global Health.
- Cunningham, F.G., et al. (2022). Williams Obstetrics. McGraw Hill.
- Cunningham, F.G., et al. (2022). Williams Obstetrics. McGraw Hill.
- Dunn, P.M. (1999). "Caesarean Section and Its History." Archives of Disease in Childhood.
- Gawande, A. (2014). "The Checklist Manifesto: How to Get Things Right." Metropolitan Books.
- Horne, A.W., et al. (2015). "Clinical Presentation of Ectopic Pregnancy." Obstetrics and Gynecology Clinics of North America.
- Karmy-Jones, R., et al. (2018). "Management of Blunt Abdominal Trauma." Journal of Trauma and Acute Care Surgery.
- Kliegman, R.M., et al. (2020). Nelson Textbook of Pediatrics. Elsevier. Cunningham, F.G., et al. (2022). Williams Obstetrics. McGraw Hill.
- Mattox, K.L., et al. (2021). Trauma, Ninth Edition. McGraw Hill.

- McCulloch, P., et al. (2015). "The Importance of Multidisciplinary Teams in Complex Surgical Cases." *BMJ Open Quality*.
- McDowell, E. (1817). "Three Cases of Ovariectomy." *The Eclectic Repertory and Analytical Review*.
- Moore, E.E., et al. (2020). *Trauma Surgery: Current Approaches*. Springer.
- Rozycki, G.S., et al. (2015). "Role of FAST in Trauma Evaluation." *Journal of the American College of Surgeons*.
- Runyon, B.A. (2019). "Management of Spontaneous Bacterial Peritonitis." *New England Journal of Medicine*.
- Sabiston, D.C., et al. (2021). *Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice*. Elsevier.
- Schwartz, S.I., et al. (2021). *Schwartz's Principles of Surgery*. McGraw Hill.
- WHO (2015). "Caesarean Section Rates and Indications Worldwide." *World Health Organization Guidelines*.
- WHO Surgical Care at the District Hospital (2003).

PROFIL PENULIS



Bdn. Dede Waslia, SST., MKM., Lahir di Kadipaten, Tasikmalaya 16 Mei 1986. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D-IV Bidan Pendidik di Stikes Jend. Achmad Yani Cimahi dan lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Kesehatan Reproduksi, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Moch. Hamka, Jakarta tahun 2017. Pada tahun 2022 penulis menyelesaikan pendidikan Profesi Bidan di Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi.

Selain pendidikan formal, penulis juga mengikuti berbagai pendidikan informal yang sesuai dengan bidang keilmuan. Saat ini penulis bekerja di Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi sebagai dosen pengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan & Bayi baru Lahir, Asuhan Kebidanan Kehamilan, dan Asuhan Kebidanan Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, melakukan publikasi dan mengikuti seminar serta pelatihan sesuai bidang keilmuan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dedewaslia@gmail.com

Motto: "Kebahagiaan itu diciptakan, Masa Depan kita yang menentukan"



Umu Qonitun, SST., M.Keb., MM., Penulis lahir di Lamongan pada tanggal 25 Agustus. Merupakan staf dosen tetap Kebidanan di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban sejak tahun 2008, aktif dalam melaksanakan tri darma perguruan tinggi baik sebagai pengajar, menulis buku, melakukan penelitian dan pengabdian. Riwayat pendidikan lulus pendidikan S2 Manajemen di STIE Mahardika Surabaya pada Tahun 2012, Pendidikan S2 Kebidanan di Universitas

Brawijaya pada tahun 2016. pendidikan program D-III Kebidanan di Akbid NU Tuban pada tahun 2006 dan Program D-IV bidan pendidik pada tahun 2008 di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Selain aktif sebagai pengajar, saat ini juga aktif sebagai Ketua Program Studi yang sebelumnya aktif sebagai ketua LPPM dan koordinator kurikulum di prodi D-III kebidanan, pengelola jurnal IJMR (International Journal Of Midwifery Research), sebagai editor dan reviewer pada beberapa jurnal nasional, tim LEPK IIK NU Tuban. Pemenang hibah penelitian nasional dari kemristek dikti pada tahun 2019, Beberapa buku yang sudah di terbitkan antara lain Asuhan Kebidanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal terbit pada tahun 2017, Buku ajar pelayanan kontrasepsi terbit pada tahun 2018, pelayanan keluarga berencana terbit pada tahun 2022.

Email : hafizh.hak@gmail.com

PROFIL PENULIS



Bdn. Siti Rochimatul Lailiyah, S.SiT., M.Kes., Penulis dilahirkan di Kota Sidoarjo, pada tanggal 23 November 1984. Penulis adalah dosen tetap di Universitas Noor Huda Mustofa. Menyelesaikan pendidikan D-III Kebidanan Poltekkes Surabaya Kampus Bangkalan Madura, dan melanjutkan pendidikan D-IV Bidan Pendidik di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudi Waluyo Ungaran Semarang. Pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi ilmu Kesehatan Masyarakat AKK (Administrasi Kebijakan Kesehatan) minat Manajemen Kesehatan Ibu

dan Anak. Mata kuliah yang diampu meliputi mata kuliah pelayanan KB, kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal, Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Sebelumnya penulis juga telah menerbitkan beberapa buku meliputi panduan praktikum Kegawatdaruratan Obstetri, Panduan pelaksanaan Stase Midwifery Critical Care, modul asuhan kebidanan persalinan dan Bayi baru Lahir, Modul asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pojok Tinggi dan berat Badan Balita (Pojok Timbang), ilmu Pendidikan, ilmu kebidanan, etika hukum dan perundang-undangan dalam pelayanan kebidanan, konsep kebidanan, buku ajar persalinan. Penulis juga telah menghasilkan beberapa publikasi pada jurnal nasional terakreditasi antara lain Efektifitas teknik relaksasi nafas dalam dan pijatan Effleurage terhadap penurunan Skala Nyeri pada Post SC, pengaruh lama penggunaan DMPA (Depometdroxi Progesteron Asetat) terhadap penurunan libido pada WUD di PMB Lukluatun Mubrikoh, Evaluasi Input Kelas ibu Hamil di wilayah kerja PKM Sukoliloh, Deteksi Dini preeklampsia pada ibu hamil dengan penimbangan BB dan tekanan Darah, faktor-faktor yang berhubungan dengan pemilihan Alat Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) pada wanita usia Subur (Studi di Wilayah UPT Puskesmas Kabupaten Bangkalan), Dampak Pandemi Covid-19 terhadap pelayanan KIA di Kab Bangkalan. Penulis mengawali karir sebagai pendidik sejak 2006, sekprodi Prodi DIV kebidanan STIKes Ngudia Husada Madura (sejak 2015-2018), Ka prodi DIII Kebidanan STIKes Ngudia Husada Madura (sejak 2018-2019), GKM STIKes Ngudia Husada Madura sejak 2019 sampai saat ini. Penulis dapat di hubungi melalui email sitirochimatullailiyah5@gmail.com nomor telepon 085735492133

Motto: "do the best every day"



PROFIL PENULIS



Anisah Tifani Maulidyanti, S.Tr.Keb., M.Keb., Lahir di Bengkulu, 19 Agustus 1994. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan, Poltekkes Kemenkes Bengkulu tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan pada Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2019-2022 sebagai Teknis Akademik dan Evaluasi D4 Kebidanan Alih Jenjang di Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di STIKes Tri Mandiri Sakti Bengkulu mengampu mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan, Midwifery Disaster, Ilmu Kesehatan Masyarakat, dan Asuhan Kebidanan Pada Persalinan dan BBL. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku dan penelitian. Penulis mendapat hibah penelitian Kemenristekdikti tahun 2024 skema PDP Afirmasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: anisahbidan23@gmail.com.
Motto: "Don't Be A Follower, Be A Story Maker"



Wira Meiriza, S.ST., M.Keb., Lahir di Muaro Gambok, 03 Januari 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV pada Program Studi Bidan Pendidik, Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Andalas Padang dan lulus pada tahun 2018. Saat ini sedang melanjutkan pendidikan S3 di Lincoln University College. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2015. Saat ini penulis bekerja di Universitas Perintis Indonesia, mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL, Asuhan Kebidanan Kehamilan, dan Pengantar Asuhan kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: wirameiriza89@gmail.com

PROFIL PENULIS



Bdn Pipih Salanti, SST, MKM., Penulis lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juli 1969. Penulis merupakan anak ke tiga dari tujuh bersaudara beragama Islam, dari pasangan Bapak H. Mohamad Sanusi (Almh) dan Ibu Hj.Nuriah Nunung . penulis sudah menikah dengan seorang abdi negara TNI AL Bapak Kushermanto serta di karuniai tiga orang anak terdiri dari dua perempuan yang saat ini bergelar dokter dan satu laki-laki masih duduk di bangku sekolah menengah kelas XII Saint 1, cucu dua orang laki dan perempuan ,semoga anak-anak saya di jadikan anak yang sholeh dan sholeha , sukses karirnya, berbakti kepada kedua orang tua dan dapat mengangkat derajat kedua orang tua Aamiin. Pendidikan Formal penulis, SDN 08 Pagi Pasar minggu , SMPN 98 Lenteng agung , Sekolah Perawat Angkatan Laut (SPK), lulus Tahun 1988, Akademi D-III Kebidanan Poltekkes Jakarta 1 lulus Tahun 2007, Akademi D-IV Kebidanan Bhakti Pertiwi Husada Cirebon lulus Tahun 2011, Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta lulus Tahun 2013, dan saat ini sedang melanjutkan kuliah S3 Ilmu Pendidikan di Universitas Islam Nusantara Bandung. Penulis juga gemar sekali menulis buku dan sudah mencetak beberapa buku hasil karyanya sendiri.

Motto: Teruslah Berkarya meski usia sudah tidak muda lagi, karena dengan berkarya namamu akan selalu terkenal.



Resta Betaliani Wirata, S.Kep., Ns., MSN., Lahir di Purbalingga, 21 Oktober 1991. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada St. Paul University Manila dan lulus tahun pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2019 sebagai dosen keperawatan maternitas di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan poster presentasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: resta@stikesbethesda.ac.id

Sinopsis

Buku **"Bunga Rampai: Persalinan Normal dan Penatalaksanaannya"** merupakan sebuah panduan komprehensif yang membahas berbagai aspek penting dalam proses persalinan normal dan bagaimana cara menanganinya dengan tepat. Ditujukan bagi tenaga medis, terutama bidan, dokter, dan perawat yang terlibat dalam proses persalinan, buku ini menawarkan wawasan yang lengkap dan praktis untuk meningkatkan kualitas perawatan ibu dan bayi selama persalinan.

Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai manajemen nyeri persalinan dengan teknik non-farmakologis, yang menawarkan solusi alternatif bagi ibu hamil untuk mengurangi rasa sakit tanpa efek samping obat. Kemudian, dibahas secara rinci tentang fase-fase persalinan normal dan langkah-langkah pengelolaannya, sehingga tenaga medis dapat memberikan penanganan yang tepat pada setiap tahap persalinan.

Selain itu, buku ini juga mengulas komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi selama persalinan normal dan cara menghadapinya dengan cepat dan efektif. Topik penting lainnya yang dibahas adalah pemulihan pasca persalinan, termasuk penanganan luka episiotomi dan perawatan vagina yang sangat penting dalam pemulihan ibu setelah melahirkan.

Dengan pendekatan yang lebih holistik, buku ini juga mengangkat pendekatan fisik, mental, dan spiritual dalam persalinan, yang memberikan gambaran tentang bagaimana pentingnya dukungan emosional dan keseimbangan mental selama proses persalinan. Peran teknologi dalam memantau persalinan dan pemantauan kesehatan ibu dan janin juga dibahas dengan memberikan penjelasan tentang bagaimana teknologi modern dapat meningkatkan keselamatan ibu dan bayi.

Akhirnya, buku ini juga menyentuh tentang keputusan laparotomi dan indikasi operasi caesar, memberikan pemahaman tentang kapan dan mengapa prosedur tersebut diperlukan dalam keadaan tertentu.

Melalui buku ini, pembaca diharapkan dapat memperoleh pengetahuan yang mendalam dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani persalinan normal dengan lebih aman, nyaman, dan efektif. "Bunga Rampai: Persalinan Normal dan Penatalaksanaannya" adalah referensi yang tak ternilai bagi para profesional medis yang ingin memberikan perawatan terbaik bagi ibu dan bayi dalam setiap proses kelahiran.

Buku "Bunga Rampai: Persalinan Normal dan Penatalaksanaannya" merupakan sebuah panduan komprehensif yang membahas berbagai aspek penting dalam proses persalinan normal dan bagaimana cara menanganinya dengan tepat. Ditujukan bagi tenaga medis, terutama bidan, dokter, dan perawat yang terlibat dalam proses persalinan, buku ini menawarkan wawasan yang lengkap dan praktis untuk meningkatkan kualitas perawatan ibu dan bayi selama persalinan.

Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai manajemen nyeri persalinan dengan teknik non-farmakologis, yang menawarkan solusi alternatif bagi ibu hamil untuk mengurangi rasa sakit tanpa efek samping obat. Kemudian, dibahas secara rinci tentang fase-fase persalinan normal dan langkah-langkah pengelolaannya, sehingga tenaga medis dapat memberikan penanganan yang tepat pada setiap tahap persalinan.

Selain itu, buku ini juga mengulas komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi selama persalinan normal dan cara menghadapinya dengan cepat dan efektif. Topik penting lainnya yang dibahas adalah pemulihan pasca persalinan, termasuk penanganan luka episiotomi dan perawatan vagina yang sangat penting dalam pemulihan ibu setelah melahirkan.

Dengan pendekatan yang lebih holistik, buku ini juga mengangkat pendekatan fisik, mental, dan spiritual dalam persalinan, yang memberikan gambaran tentang bagaimana pentingnya dukungan emosional dan keseimbangan mental selama proses persalinan. Peran teknologi dalam memantau persalinan dan pemantauan kesehatan ibu dan janin juga dibahas dengan memberikan penjelasan tentang bagaimana teknologi modern dapat meningkatkan keselamatan ibu dan bayi.

Akhirnya, buku ini juga menyentuh tentang keputusan laparotomi dan indikasi operasi caesar, memberikan pemahaman tentang kapan dan mengapa prosedur tersebut diperlukan dalam keadaan tertentu.

Melalui buku ini, pembaca diharapkan dapat memperoleh pengetahuan yang mendalam dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani persalinan normal dengan lebih aman, nyaman, dan efektif. "Bunga Rampai: Persalinan Normal dan Penatalaksanaannya" adalah referensi yang tak ternilai bagi para profesional medis yang ingin memberikan perawatan terbaik bagi ibu dan bayi dalam setiap proses kelahiran.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

